



STATISTIK KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA 2023

VOLUME 1, 2024



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI UTARA**

<https://sulut.bps.go.id>

STATISTIK KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA 2023

VOLUME 1, 2024



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI UTARA**

STATISTIK KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA 2023

Volume 1, 2024

Katalog : 4201001.71
Nomor Publikasi : 71000.24035

Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman : xx+173 halaman

Penyusun Naskah:

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara

Pembuat Kover:

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara

Penerbit:

©Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara

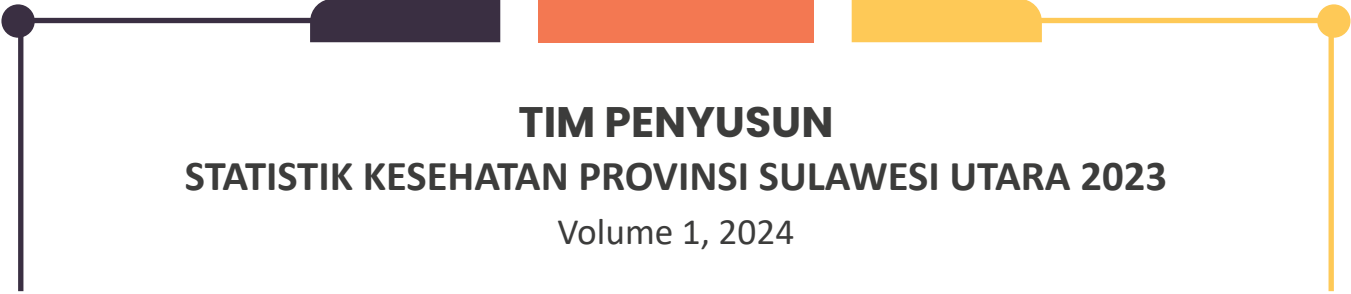
Dicetak oleh:

Girsa Copy & Digital Print

Sumber Ilustrasi:

freepik.com

Dilarang mereproduksi dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara



TIM PENYUSUN

STATISTIK KESEHATAN PROVINSI SULAWESI UTARA 2023

Volume 1, 2024

Pengarah

Aidil Adha, SE., ME

Penanggung Jawab

Titien Kristiningsih, SST., SE., M.Si

Penyunting

Titien Kristiningsih, SST., SE., M.Si

Raymond Nica Seyun Kumolontang, S.Pi

Penulis Naskah

Nova Nurviana, SST, M.T.

Florentz Magdalena, SST, M.Sc

Salonica Oktaviani, SST

Destiana Fitri, S.Tr.Stat.

Pengolah Data

Abdul Aziz Makhrus, S.Tr.Stat.

Penata Letak

Abdul Aziz Makhrus, S.Tr.Stat.

Halaman ini sengaja dikosongkan

KATA PENGANTAR

Publikasi Profil Statistik Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara 2023 merupakan publikasi baru yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara yang menyajikan data kesehatan penduduk Provinsi Sulawesi Utara secara umum, kesehatan penduduk perempuan usia subur, kesehatan anak dan balita, serta pengeluaran masyarakat untuk kesehatan. Publikasi ini bersumber dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023. Data yang disajikan dalam publikasi ini disajikan dalam level provinsi dan kabupaten/kota serta menurut berbagai karakteristik yang dimiliki seperti klasifikasi desa, jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan. Hal tersebut dimaksudkan agar pengguna dapat mengetahui gambaran kondisi kesehatan menurut kelompok-kelompok masyarakat dan kelompok yang masih perlu perhatian dalam aspek kesehatan. Dengan demikian, diharapkan publikasi ini dapat memenuhi kebutuhan akan data kesehatan di Provinsi Sulawesi Utara guna penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan kesehatan yang berbasis bukti.

Publikasi ini terwujud berkat kerjasama dan partisipasi dari berbagai pihak. Untuk itu, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi. Dalam rangka meningkatkan kualitas publikasi Profil Statistik Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara dan pelayanan kepada para pengguna, kami mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk perbaikan pada edisi berikutnya.

Manado, September 2024
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Utara,

Aidil Adha, SE., ME

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR ISI
Statistik Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara 2023
Volume 1, 2024

Halaman

TIM PENYUSUN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB 1 DATA BERKELANJUTAN UNTUK PEMBANGUNAN KESEHATAN.....	3
1.1 Peran Penting Pembangunan Kesehatan untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Sulawesi Utara	3
1.2 Penyediaan Data yang Berkualitas untuk Pembangunan Kesehatan yang Berkelanjutan.....	4
1.3 Ruang Lingkup	5
BAB 2 PEMBANGUNAN SULAWESI UTARA MELALUI KESEHATAN PENDUDUK	9
2.1 Tingkat Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan di Sulawesi Utara	10
2.2 Pemerataan Layanan Kesehatan untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat	14
2.3 Kepemilikan dan Penggunaan Jaminan Kesehatan	21
2.4 Kebiasaan Merokok di Provinsi Sulawesi Utara	27
BAB 3 KESEHATAN ANAK: INVESTASI MENUJU SULUT HEBAT	75
3.1 Gambaran Kesehatan Anak Sulawesi Utara	75
3.2 Jaminan Kesehatan Anak Sulawesi Utara	78
3.3 Imunisasi Adalah Hak Sekaligus Perisai Anak.....	80
3.4 Menjawab Permasalahan Gizi melalui Pemberian ASI pada Baduta	82
BAB 4 MEMBANGUN KESEHATAN IBU SEBAGAI UPAYA CIPTAKAN GENERASI EMAS.....	125
4.1 Umur Perkawinan Pertama Perempuan Usia Subur dan Kesehatan Persalinan Ibu	126
4.2 Keluhan dan Upaya Kesehatan yang Dilakukan Perempuan Usia Subur...	130
BAB 5 POLA PENGELUARAN KESEHATAN PENDUDUK SULAWESI UTARA	159
5.1 Pola Pengeluaran Penduduk	160

5.2	Pola Pengeluaran Kesehatan.....	161
5.3	Komposisi Pengeluaran Kesehatan	162
5.4	Pengeluaran Kesehatan OOP	165

DAFTAR PUSTAKA	173
-----------------------------	------------

<https://sulut.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2.1 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota, 2021–2023	31
Tabel 2.2 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari Menurut Kabupaten/Kota, 2021–2023	32
Tabel 2.3 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota, 2021–2023....	33
Tabel 2.4 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Rawat Jalan, 2023	34
Tabel 2.5 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik dan Tempat Rawat Jalan, 2023	36
Tabel 2.6 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Tidak Rawat Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Alasan Utama Tidak Rawat Jalan, 2023	38
Tabel 2.7 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Tidak Rawat Jalan Menurut Karakteristik dan Alasan Utama Tidak Rawat Jalan, 2023	40
Tabel 2.8 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota, 2021–2023	42
Tabel 2.9 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Karakteristik dan Tempat Rawat Inap, 2023	43
Tabel 2.10 Persentase Penduduk Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Kabupaten/ Kota, 2023	45
Tabel 2.11 Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jaminan Kesehatan yang Dimiliki, 2023.....	46
Tabel 2.12 Persentase Penduduk Menurut Karakteristik dan Jaminan Kesehatan yang Dimiliki, 2023.....	48
Tabel 2.13 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Jaminan Kesehatan yang Dimiliki, 2023	50
Tabel 2.14 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir menurut Karakteristik dan Jaminan Kesehatan yang Dimiliki, 2023	52

Tabel 2.15	Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan dalam Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota, 2023.....	54
Tabel 2.16	Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan dalam Setahun Terakhir Menurut Karakteristik, 2023.....	55
Tabel 2.17	Persentase Penduduk yang Merokok Menggunakan Rokok Elektrik selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota, 2023	56
Tabel 2.18	Persentase Penduduk yang Merokok Menggunakan Rokok Elektrik selama Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2023	57
Tabel 2.19	Persentase Penduduk Umur 5 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Apakah Merokok Tembakau selama Sebulan Terakhir, 2023	58
Tabel 2.20	Persentase Penduduk Umur 5 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik dan Apakah Merokok Tembakau selama Sebulan Terakhir, 2023	59
Tabel 2.21	<i>sampling Error</i> Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jaminan Kesehatan yang Dimiliki, 2023	60
Tabel 2.22	<i>sampling Error</i> Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Jaminan Kesehatan yang Dimiliki, 2023	66
Tabel 2.23	<i>sampling Error</i> Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menggunakan Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota, 2023.....	71
Tabel 3.1	Persentase Penduduk Umur 0–17 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2023	85
Tabel 3.2	Persentase Penduduk Umur 0–17 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik di Sulawesi Utara, 2023	86
Tabel 3.3	Persentase Penduduk Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2023	87
Tabel 3.4	Persentase Penduduk Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik di Sulawesi Utara, 2023	88
Tabel 3.5	Persentase Penduduk Umur 0–17 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2023	89
Tabel 3.6	Persentase Penduduk Umur 0–17 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari Menurut Karakteristik di Sulawesi Utara, 2023	90

Tabel 3.7	Persentase Penduduk Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2023	91
Tabel 3.8	Persentase Penduduk Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari Menurut Karakteristik di Sulawesi Utara, 2023	92
Tabel 3.9	Persentase Penduduk Umur 0–17 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Upaya Perawatan di Sulawesi Utara, 2023.....	93
Tabel 3.10	Persentase Penduduk Umur 0–17 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari Menurut Karakteristik dan Jenis Upaya Perawatan di Sulawesi Utara, 2023.....	94
Tabel 3.11	Persentase Penduduk Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Upaya Perawatan di Sulawesi Utara, 2023.....	95
Tabel 3.12	Persentase Penduduk Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari Menurut Karakteristik dan Jenis Upaya Perawatan di Sulawesi Utara, 2023.....	96
Tabel 3.13	Persentase Penduduk Umur 0–17 Tahun yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2023.....	97
Tabel 3.14	Persentase Penduduk Umur 0–17 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari Menurut Karakteristik dan Jenis Upaya Perawatan di Sulawesi Utara, 2023.....	98
Tabel 3.15	Persentase Penduduk Umur 0–4 Tahun yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2023	99
Tabel 3.16	Persentase Penduduk Umur 0–4 Tahun yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Karakteristik di Sulawesi Utara, 2023.....	100
Tabel 3.17	Persentase Anak Umur 12–23 Bulan yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2023	101
Tabel 3.18	Persentase Anak Umur 12–23 Bulan yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Karakteristik di Sulawesi Utara, 2023	102
Tabel 3.19	Persentase Anak Umur 12–23 Bulan yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Jenis Imunisasi yang Diterima dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2023	103

Tabel 3.20	Persentase Anak Umur 12–23 Bulan yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Jenis Imunisasi yang Diterima dan Karakteristik di Sulawesi Utara, 2023	104
Tabel 3.21	Persentase Anak Umur 0–23 Bulan yang Pernah Diberi ASI Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2023.....	105
Tabel 3.22	Persentase Anak Umur 0–23 Bulan yang Pernah Diberi ASI Menurut Karakteristik di Sulawesi Utara, 2023.....	106
Tabel 3.23	Rata-rata Lama Pernah Diberi ASI Anak Umur 0–23 Bulan Menurut Karakteristik di Sulawesi Utara, 2023.....	107
Tabel 3.24	Sampling Error Persentase Anak Umur 0–17 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota, 2023	108
Tabel 3.25	Sampling Error Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota, 2023	109
Tabel 3.26	Sampling Error Persentase Anak Umur 0–17 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2023	110
Tabel 3.27	Sampling Error Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2023	111
Tabel 3.28	Sampling Error Persentase Anak Umur 0–17 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Mengobati Sendiri Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2023	112
Tabel 3.29	Sampling Error Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Mengobati Sendiri Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2023	113
Tabel 3.30	Sampling Error Persentase Anak Umur 0–17 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2023.....	114
Tabel 3.31	Sampling Error Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2023.....	115
Tabel 3.32	Sampling Error Persentase Anak Umur 0–17 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Inap Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2023	116
Tabel 3.33	Sampling Error Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Inap Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2023	117

Tabel 3.34	<i>Sampling Error</i> Persentase Anak Umur 0–17 Tahun yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2023.....	118
Tabel 3.35	<i>Sampling Error</i> Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2023.....	119
Tabel 3.36	<i>Sampling Error</i> Persentase Anak Umur 12–23 Bulan yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2023 .	120
Tabel 3.37	<i>Sampling Error</i> Persentase Bayi Umur 0–23 Bulan yang Pernah Diberi ASI Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2023	121
Tabel 4.1	Rata-Rata Umur Perkawinan Pertama Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023.....	133
Tabel 4.2	Rata-Rata Umur Perkawinan Pertama Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun Menurut Karakteristik Tahun 2023.....	134
Tabel 4.3	Rata-Rata Umur Kehamilan Pertama Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Pernah Hamil Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023.....	135
Tabel 4.4	Rata-Rata Umur Kehamilan Pertama Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Pernah Hamil Menurut Karakteristik Tahun 2023.....	136
Tabel 4.5	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 tahun yang melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Lahir Hidup yang Terakhir Dilahirkan di Fasilitas Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	137
Tabel 4.6	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 tahun yang melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Lahir Hidup yang Terakhir Dilahirkan dengan Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	138
Tabel 4.7	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 tahun yang melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Lahir Hidup yang Terakhir Dilahirkan dengan Berat Badan Lahir Rendah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	139
Tabel 4.8	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 tahun yang melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Lahir Hidup yang Terakhir Dilahirkan dengan Berat Badan Lahir Rendah Menurut Karakteristik Tahun 2023	140
Tabel 4.9	Persentase Perempuan Umur 15–49 tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	141
Tabel 4.10	Persentase Perempuan Umur 15–49 tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik Tahun 2023	142
Tabel 4.11	Persentase Perempuan Umur 15–49 tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	143

Tabel 4.12	Persentase Perempuan Umur 15–49 tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari Menurut Karakteristik Tahun 2023	144
Tabel 4.13	Persentase Perempuan Umur 15–49 tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Mengobati Sendiri dalam Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	145
Tabel 4.14	Persentase Perempuan Umur 15–49 tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	146
Tabel 4.15	Sampling Error Rata-Rata Umur Perkawinan Pertama Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023.....	147
Tabel 4.16	Sampling Error Rata-Rata Umur Kehamilan Pertama Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Pernah Hamil Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	148
Tabel 4.17	Sampling Error Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 tahun yang melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Lahir Hidup yang Terakhir Dilahirkan di Fasilitas Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	149
Tabel 4.18	Sampling Error Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 tahun yang melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Lahir Hidup yang Terakhir Dilahirkan dengan Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023.....	150
Tabel 4.19	Sampling Error Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 tahun yang melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Lahir Hidup yang Terakhir Dilahirkan dengan Berat Badan Lahir Rendah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	151
Tabel 4.20	Sampling Error Persentase Perempuan Umur 15–49 tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	152
Tabel 4.21	Sampling Error Persentase Perempuan Umur 15–49 tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	153
Tabel 4.22	Sampling Error Persentase Perempuan Umur 15–49 tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Mengobati Sendiri dalam Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023.....	154
Tabel 4.23	Sampling Error Persentase Perempuan Umur 15–49 tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	155

Tabel**Halaman**

Tabel 5.1	Rata-rata Pengeluaran Rupiah per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (Rupiah), 2023.....	167
Tabel 5.2	Rata-rata Pengeluaran Rupiah per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (Rupiah), 2023.....	168
Tabel 5.3	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Penduduk di Perdesaan Sebulan Menurut Rincian Pengeluaran Kesehatan (Rupiah), 2023	169
Tabel 5.4	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Penduduk Sebulan Menurut Rincian Pengeluaran Kesehatan (Rupiah), 2023	170
Tabel 5.5	Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Penduduk Sebulan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pengeluaran Kesehatan (Rupiah), 2023	171
Tabel 5.6	Rata-rata Pengeluaran Rupiah per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (Rupiah), 2023.....	172

<https://sulut.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir, 2021–2023..... 10
Gambar 2.2	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2023 12
Gambar 2.3	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari, 2021–2023 13
Gambar 2.4	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari (Angka Kesakitan) Menurut Karakteristik, 2023 14
Gambar 2.5	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Mengobati Sendiri dalam Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota, 2023..... 15
Gambar 2.6	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Mengobati Sendiri dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2023 16
Gambar 2.7	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2023 17
Gambar 2.8	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Tempat Rawat Jalan, 2023 18
Gambar 2.9	Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Dalam Setahun Terakhir Menurut Karakteristik, 2023 19
Gambar 2.10	Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Dalam Setahun Terakhir Menurut Tempat Rawat Inap, 2023 20
Gambar 2.11	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Karakteristik, 2023 22
Gambar 2.12	Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki, 2023 22
Gambar 2.13	Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki, 2023 24
Gambar 2.14	Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/ Kota, 2023..... 25

Gambar 2.15	Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Karakteristik, 2023 ..	26
Gambar 2.16	Persentase Penduduk yang Tidak Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Rawat Jalan atau Rawat Inap, 2023	27
Gambar 2.17	Rata-rata Jumlah Batang Rokok yang Dihisap per Minggu oleh Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Merokok selama Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2023	30
Gambar 3.1	Angka Kesakitan Anak Berumur 0–17 Tahun di Sulawesi Utara Menurut Karakteristik, 2023	78
Gambar 3.2	Persentase Kepemilikan Jaminan Kesehatan pada Anak Berumur 0-17 Tahun dan Anak Berumur 0–4 Tahun di Sulawesi Utara Menurut Kabupaten/Kota, 2023	80
Gambar 3.3	Persentase Anak Berumur 12–23 Bulan yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap di Sulawesi Utara Menurut Karakteristik, 2023	81
Gambar 3.4	Persentase Baduta yang Pernah Diberi ASI di Sulawesi Utara Menurut Karakteristik, 2023	83
Gambar 3.5	Rata-rata Lama Pemberian ASI Tanpa Makanan Pendamping dan ASI dengan Makanan Pendamping (Bulan) Anak Berumur Kurang dari 2 Tahun (Baduta) menurut Klasifikasi Desa di Sulawesi Utara, 2023..	84
Gambar 4.1	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Lahir Hidup yang Terakhir Dilahirkan di Fasilitas Kesehatan Menurut Karakteristik Wilayah, 2023	127
Gambar 4.2	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Lahir Hidup yang Terakhir Dilahirkan dengan Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Menurut Karakteristik Wilayah, 2023	128
Gambar 4.3	Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Lahir Hidup Terakhir Menurut Lamanya Waktu Diletakkan di Atas Dada Ibu dengan Bersentuhan Kulit secara Langsung Saat Dilahirkan, 2023	129
Gambar 4.4	Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2023	131
Gambar 4.5	Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Mengobati Sendiri dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik Wilayah, 2023	132
Gambar 5.1	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Penduduk Sebulan untuk Kesehatan menurut Wilayah (Rupiah), 2023	161

Gambar**Halaman**

Gambar 5.2	Proporsi Pengeluaran per Kapita Penduduk Sebulan untuk Kesehatan menurut Sumber Pembiayaan 162
Gambar 5.3	Proporsi Pengeluaran per Kapita Penduduk Sebulan untuk Kesehatan menurut Jenis Pengeluaran Kesehatan, 2023 163
Gambar 5.4	Proporsi Pengeluaran per Kapita Penduduk Sebulan untuk Kesehatan (dalam persen) menurut Dua Jenis Pengeluaran Terbesar per Kelompok Pengeluaran Kesehatan 165

<https://sulut.bps.go.id>

BAB 1

DATA BERKELANJUTAN UNTUK PEMBANGUNAN KESEHATAN

**STATISTIK KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA
2023**



BAB 1

DATA BERKELANJUTAN UNTUK PEMBANGUNAN KESEHATAN

1.1 Peran Penting Pembangunan Kesehatan untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Sulawesi Utara

Dalam pembangunan berkelanjutan, faktor sumber daya manusia memegang peranan besar. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi akan meningkatkan produktivitas yang dapat menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi untuk menjaga berkelanjutan pembangunan. Sulawesi Utara merupakan provinsi yang memiliki potensi sumber daya manusia sangat besar dengan lebih dari 2,6 juta penduduk yang sebagian besar berada di usia produktif. Untuk menjaga momentum bonus demografi tersebut, pemerintah menetapkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sebagai upaya untuk menjadikan Sulawesi Utara sebagai Pintu Gerbang Indonesia ke Asia dan Pasifik yang mandiri, maju, dan berkelanjutan, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2025–2045.

Selain itu, kesehatan merupakan bagian dari hasil pembangunan sumber daya manusia sekaligus menjadi modal dasar pembangunan sumber daya manusia. Sebagai hak dasar setiap warga negara, kesehatan juga diamanatkan dalam Undang Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 pasal 28. Selanjutnya, Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan juga menyatakan bahwa kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan menjadi salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan UUD Tahun 1945. Hak atas kesehatan memiliki cakupan yang luas dari faktor ekonomi dan sosial hingga makanan, air minum, dan nutrisi, serta tempat tinggal dan lingkungan yang sehat. Faktor-faktor tersebut memengaruhi penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang sehat.

Pembangunan kesehatan memegang peran yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas suatu masyarakat. Kesehatan yang baik adalah pondasi utama bagi individu untuk mencapai potensi terbaiknya dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk produktivitas. Investasi dalam pembangunan kesehatan tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan ekonomi suatu negara. Individu yang sehat cenderung lebih produktif karena mereka memiliki energi yang cukup, daya

tahan tubuh yang baik, dan kemampuan kognitif yang optimal. Selain itu, upaya pencegahan penyakit dan peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan dapat mengurangi beban penyakit yang dapat menghambat produktivitas. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan yang holistik dan berkelanjutan bukan hanya merupakan investasi dalam kesejahteraan individu, tetapi juga merupakan strategi cerdas untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa di tingkat global.

Berbagai upaya telah pemerintah daerah lakukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di antaranya yaitu pemanfaatan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional untuk membangun fasilitas kesehatan, sehingga Sulawesi Utara dapat menjadi kiblat kesehatan di Indonesia Timur. Selain pembangunan fasilitas, berbagai program kerja sama dan koordinasi berbagai pihak dilakukan, misalnya dengan menyelenggarakan *Healthy Week* dengan menghadirkan pameran kesehatan di pusat perbelanjaan, serta dengan menyosialisasikan pentingnya imunisasi, terutama imunisasi polio tambahan.

1.2 Penyediaan Data yang Berkualitas untuk Pembangunan Kesehatan yang Berkelanjutan

Penyediaan data yang berkualitas memegang peran penting dalam pembangunan yang berkelanjutan termasuk di bidang kesehatan. Data kesehatan yang akurat dan komprehensif menjadi landasan yang kuat untuk perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan kesehatan berbasis bukti. Data dan informasi kesehatan yang komprehensif akan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan kesehatan masyarakat, termasuk determinan sosial ekonomi yang mempengaruhi kesehatan serta kelompok-kelompok masyarakat yang perlu menjadi prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Dengan data yang handal, pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan.

Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki peran krusial dalam penyediaan data statistik dasar di bidang kesehatan yang berkualitas untuk mendukung pembangunan kesehatan yang berkelanjutan. Sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab utama dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran data statistik, BPS menjadi garda terdepan dalam menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya terkait dengan situasi kesehatan masyarakat Indonesia. BPS terus berupaya menyediakan data kesehatan yang berkualitas secara berkesinambungan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Susenas mengumpulkan data kesehatan penduduk secara umum yang terdiri dari pemanfaatan pelayanan kesehatan untuk rawat jalan

maupun rawat inap, kepemilikan dan pemanfaatan jaminan kesehatan, perilaku merokok, kesehatan ibu, serta kesehatan anak. Dengan demikian, Susenas dapat menyediakan informasi kesehatan secara komprehensif untuk setiap kelompok umur. Selain itu, Susenas juga menyediakan informasi mengenai pengeluaran kesehatan rumah tangga sehingga dapat diketahui beban biaya kesehatan yang ditanggung rumah tangga.

1.3 Ruang Lingkup

Secara sistematis, publikasi Statistik Kesehatan 2023 disajikan dalam lima bab sebagai berikut:

- | | |
|---------|--|
| Bab I | menjelaskan pentingnya pembangunan sektor kesehatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan peran BPS dalam menyajikan data-data kesehatan sebagai sumber perencanaan dan evaluasi kebijakan kesehatan berbasis bukti. |
| Bab II | menyajikan informasi mengenai kesehatan seluruh penduduk yang mencakup keluhan kesehatan dan angka kesakitan, upaya kesehatan, kepemilikan dan pemanfaatan jaminan kesehatan, serta perilaku merokok. |
| Bab III | mengulas situasi kesehatan anak dan balita, di antaranya terkait keluhan kesehatan dan angka kesakitan pada anak, upaya kesehatan yang dilakukan pada anak-anak, jaminan kesehatan yang dimiliki, imunisasi, pemberian Air Susu Ibu dan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI). |
| Bab IV | memberikan informasi mengenai kesehatan Wanita Usia Subur (WUS) yaitu penduduk perempuan yang berumur 15-49 tahun yang merupakan pilar kesehatan keluarga. |
| Bab V | menyajikan informasi mengenai pengeluaran rumah tangga untuk kesehatan baik untuk pencegahan/preventif, pengobatan/kuratif, maupun obat. Disajikan pula data pengeluaran kesehatan rumah tangga yang dikeluarkan secara <i>out of pocket</i> (OOP). |

Data yang digunakan dalam publikasi ini seluruhnya bersumber pada data Susenas Maret 2021–2023.

BAB 2

PEMBANGUNAN SULAWESI UTARA MELALUI KESEHATAN PENDUDUK



**STATISTIK KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA
2023**

BAB 2

PEMBANGUNAN SULAWESI UTARA MELALUI KESEHATAN PENDUDUK

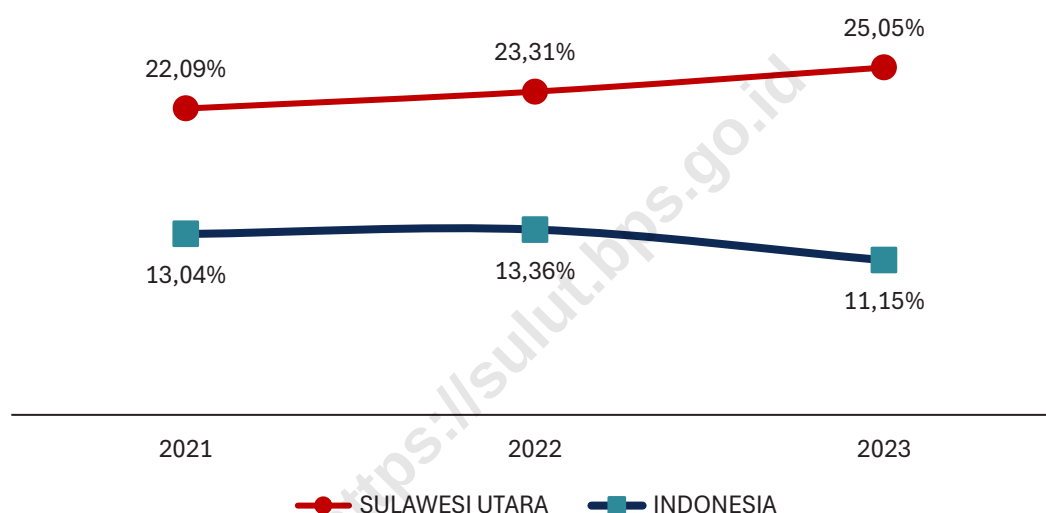
Disertakannya berbagai target kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 merupakan komitmen nyata pemerintah dalam rangka meningkatkan status kesehatan masyarakat. Hal ini didasari akan pentingnya pembangunan sektor kesehatan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berbicara mengenai pembangunan kesehatan penduduk tentunya harus disertai dengan perhatian pada peningkatan kesehatan ibu dan anak karena tercakup dalam siklus pembentukan modal manusia yang berkaitan dengan kesehatan. Mayer-foulkes (2004) menjelaskan bahwa pendapatan, kesehatan, dan pendidikan keluarga yang baik akan menentukan perkembangan anak, yang selanjutnya akan berpengaruh pada tingkat kesehatan saat remaja serta kesempatan memperoleh pendapatan saat usia dewasa dan juga menentukan kualitas generasi selanjutnya.

Sejumlah tantangan di bidang kesehatan masih dihadapi oleh pemerintah dalam upaya memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Di samping masalah malnutrisi yang sering terjadi pada anak, proses transisi epidemiologi dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular masih menjadi beban dalam pembangunan kesehatan masyarakat di Indonesia termasuk Sulawesi Utara. Dari komposisi umur yang didominasi usia produktif, upaya pengendalian perilaku merokok juga perlu terus diupayakan karena prevalensi merokok pada kelompok usia produktif cukup tinggi (Kemenkes RI, 2019). Pengendalian perilaku merokok menjadi penting karena kerugian yang diakibatkan bukan hanya bagi perokok itu sendiri, namun juga perokok pasif.

Berdasarkan hal tersebut, pemahaman mendalam terkait demografi penduduk menjadi kunci dalam perencanaan kebijakan kesehatan yang efektif. Melalui analisis demografi, pemerintah dapat memberikan kebijakan yang tepat bagi sektor kesehatan. Dengan memahami hubungan antara demografi penduduk dan kesehatan masyarakat, pemerintah dapat mengembangkan strategi kesehatan yang berkelanjutan dan berfokus pada keberlanjutan kesejahteraan seluruh populasi.

2.1 Tingkat Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan di Sulawesi Utara

Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dapat memberikan gambaran awal situasi kesehatan penduduk secara umum. Persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dari waktu ke waktu memberikan informasi kepada pemerintah untuk melakukan pemantauan terhadap kecenderungan kesehatan masyarakat. Perubahan dalam angka ini dapat memberikan petunjuk tentang efektivitas kebijakan kesehatan, program pencegahan, atau upaya perbaikan sistem kesehatan. Informasi ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemantauan dan perawatan kesehatan sehingga dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam program pencegahan dan pemeliharaan kesehatan.



Gambar 2.1 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir, 2021–2023

Gambar 2.1 menunjukkan bahwa persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 2,96 persen poin. Pada tahun 2023, angka keluhan kesehatan Provinsi Sulawesi Utara sebesar 25,05 persen atau sekitar 25 dari 100 penduduk di Provinsi Sulawesi Utara menyatakan mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir. Angka keluhan kesehatan ini tidak sejalan dengan angka keluhan kesehatan nasional yang mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 11,15 persen.

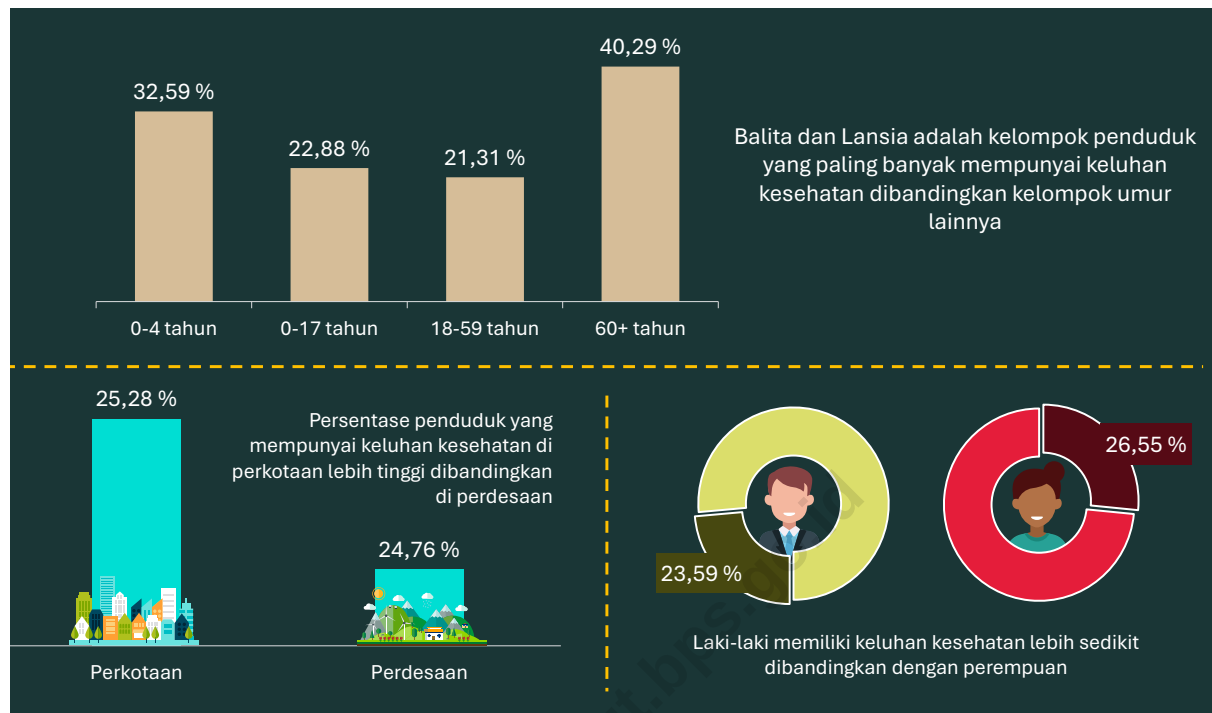
Susenas mengumpulkan informasi keluhan kesehatan dengan menggunakan pendekatan *Self-Assessed Health* (SAH) atau pengukuran kesehatan melalui pernyataan subjektif individu terhadap status kesehatan. Meskipun pendekatan bersifat subjektif, penelitian telah menunjukkan bahwa *Self-Assessed Health* dapat menjadi prediktor yang

reliable dalam memprediksi kesehatan (Doiron, Fiebig, Johar, & Suziedelyte, 2015). Kelebihan dari pendekatan ini adalah kemudahan penggunaannya, serta kemampuannya untuk mencerminkan dimensi kesehatan yang mungkin tidak terukur dengan indikator kesehatan objektif. Keluhan kesehatan yang dicakup dalam definisi operasional Susenas meliputi batuk, pilek, demam, termasuk juga penduduk yang memiliki penyakit kronis, mempunyai keluhan kesehatan akibat kecelakaan, keluhan kesehatan pada ibu hamil atau wanita yang sedang menstruasi seperti mual dan pusing, ataupun keluhan psikologis yang berdampak pada keluhan fisik seperti bulimia.

Pada rentang waktu 2021-2022, terdapat 2 (dua) kabupaten/kota yang mengalami penurunan persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir yaitu Kabupaten Minahasa dan Kota Manado (Tabel 2.1). Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir di Kabupaten Minahasa turun sebanyak 9,97 persen poin pada tahun 2022 menjadi 27,19 persen, sementara itu di Kota Manado persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir turun sebanyak 22,87 persen poin menjadi 8,22 persen. Kemudian pada tahun 2023, persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir di Kabupaten Minahasa mengalami peningkatan sebesar 7,80 persen poin menjadi 34,99 persen yang merupakan persentase tertinggi penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Terdapat 4 (empat) kabupaten/kota lain yang memiliki persentase di atas persentase Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2023 yaitu Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Sementara itu, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro menjadi wilayah dengan persentase terendah penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir yaitu sebesar 15,13 persen.

Angka keluhan kesehatan juga dapat dijabarkan menurut karakteristiknya yakni menurut kewilayahan dan kondisi demografi. Persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Disparitas situasi kesehatan masyarakat di perkotaan dan perdesaan antara lain dipengaruhi oleh perbedaan kondisi sosial-demografis penduduk serta akses terhadap layanan kesehatan. Menurut jenis kelamin, persentase perempuan yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Perempuan mengalami perubahan biologis yang signifikan selama siklus hidup mereka, termasuk menstruasi, kehamilan, dan menopause. Setiap fase ini dapat membawa risiko kesehatan yang spesifik, termasuk gangguan hormonal, anemia, dan masalah kesehatan reproduksi. Dalam aspek sosial, penelitian di Malawi

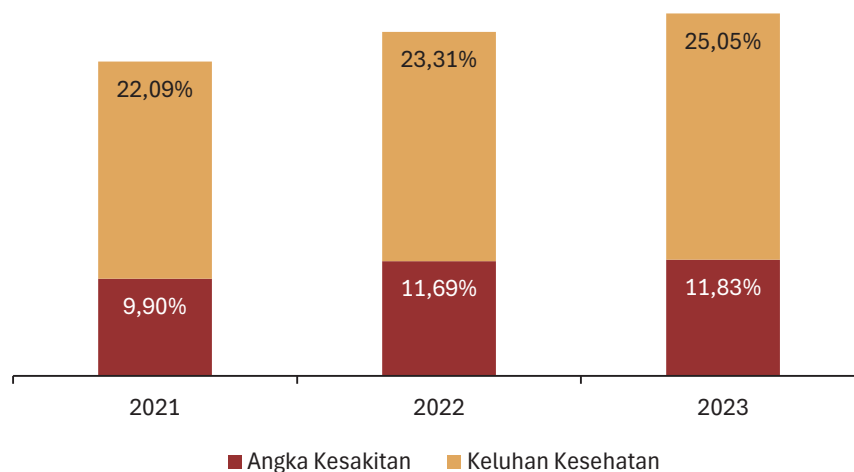
menemukan bahwa perempuan dalam ketidaksetaraan gender memiliki hambatan yang lebih besar untuk mengakses layanan kesehatan sehingga peluang mereka untuk mempunyai keluhan kesehatan lebih besar dibanding laki-laki (Azad et al. 2020).



Gambar 2.2 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2023

Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir paling tinggi terdapat pada kelompok umur balita (0-4 tahun) dan lanjut usia (60 tahun ke atas). Balita dan lansia memiliki sistem kekebalan tubuh yang cenderung lebih rentan. Pada balita sistem kekebalan tubuh masih berkembang, sedangkan pada lansia terdapat penurunan fungsi kekebalan tubuh karena proses penuaan. Kedua hal ini dapat membuat keduanya lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit.

Ukuran lain yang sering digunakan untuk memberikan gambaran situasi kesehatan masyarakat adalah angka kesakitan, yaitu suatu ukuran statistik yang menggambarkan tingkat gangguan kesehatan di suatu populasi dalam suatu periode waktu tertentu. Angka kesakitan adalah persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir dan keluhan yang dialami tersebut mengakibatkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Pada tahun 2023, sekitar 11 dari 100 penduduk Sulawesi Utara mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir dan keluhan kesehatan tersebut mengakibatkan terganggunya kegiatan sehari-hari (Gambar 2.3). Sejalan dengan pola tingkat keluhan kesehatan, angka kesakitan terus meningkat dari tahun 2021 hingga tahun 2023 mencapai 11,83 persen.

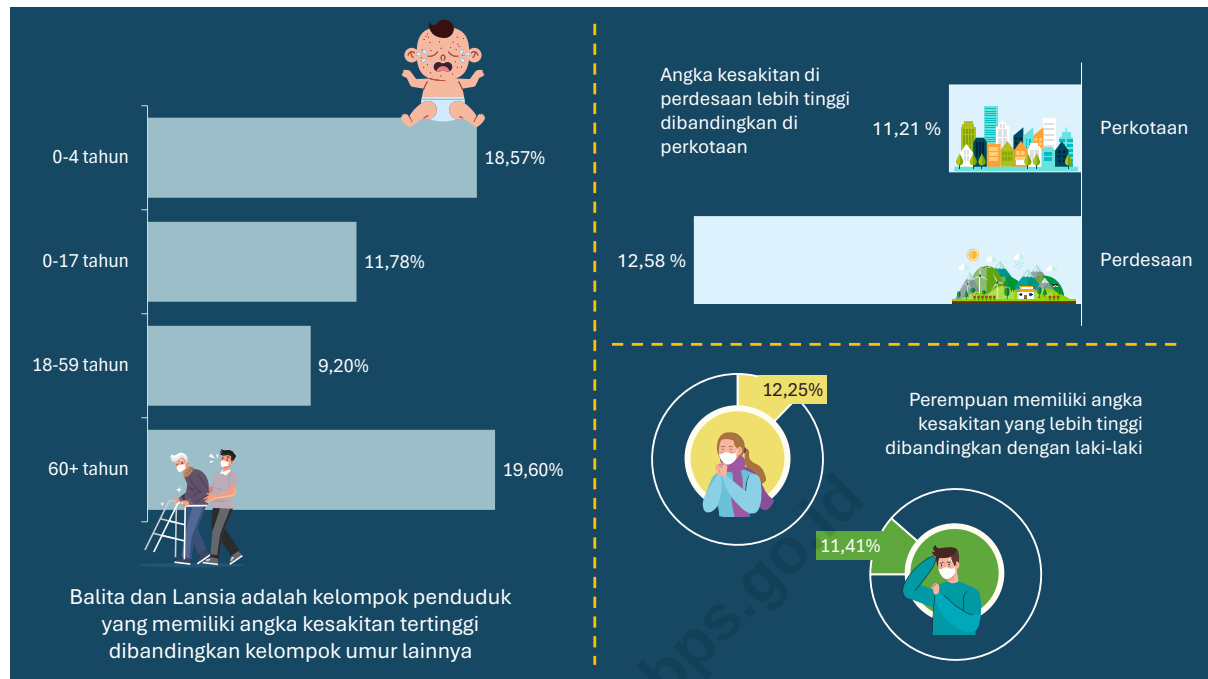


Gambar 2.3 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari, 2021–2023

Kabupaten Minahasa Selatan merupakan kabupaten/kota dengan persentase tertinggi penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir dan mengakibatkan terganggunya kegiatan sehari-hari tahun 2023 yaitu sebesar 15,56 persen, sementara wilayah dengan persentase terendah adalah Kota Manado yaitu sebesar 7,47 persen (Tabel 2.2). Tingginya tingkat keluhan kesehatan di Kabupaten Minahasa Selatan diikuti dengan tingginya angka kesakitan di wilayah tersebut.. Wilayah dengan angka kesakitan tertinggi kedua adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meskipun tingkat keluhan kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2023 berada di bawah tingkat keluhan kesehatan Provinsi Sulawesi Utara (22,17 persen), angka kesakitan di kabupaten ini merupakan tertinggi kedua yaitu sebesar 15 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa keluhan kesehatan yang dialami penduduk di Kabupaten Kepulauan Sangihe lebih banyak mengakibatkan terganggunya kegiatan sehari-hari dibandingkan dengan wilayah lain.

Sebagaimana tingkat keluhan kesehatan penduduk, angka kesakitan juga dipengaruhi oleh struktur demografi dan faktor geografis. Angka kesakitan penduduk Sulawesi Utara pada tahun 2023 cenderung lebih tinggi di wilayah perdesaan yaitu sebesar 12,58 persen, pada kelompok penduduk perempuan yaitu sebesar 12,25 persen, serta pada kelompok umur balita (0-4 tahun) dan lansia (60 tahun ke atas). Sebesar 19,60 persen lansia mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir dan mengakibatkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Tingginya angka kesakitan pada lansia dapat berkaitan dengan penyakit degeneratif dan komplikasi yang banyak diderita oleh penduduk lansia. Adioetomo (2018) menjelaskan dalam setiap tahapan hidup, terdapat perbedaan risiko yang memengaruhi kondisi kesehatan dan

produktivitas. Secara umum, risiko kesehatan tersebut berbeda pada usia 1.000 hari pertama, usia dini, remaja dan dewasa, serta lansia, walaupun terdapat risiko-risiko terlepas dari umur yang dapat memengaruhi kesehatan seperti kondisi lingkungan, urbanisasi, dan kemiskinan.



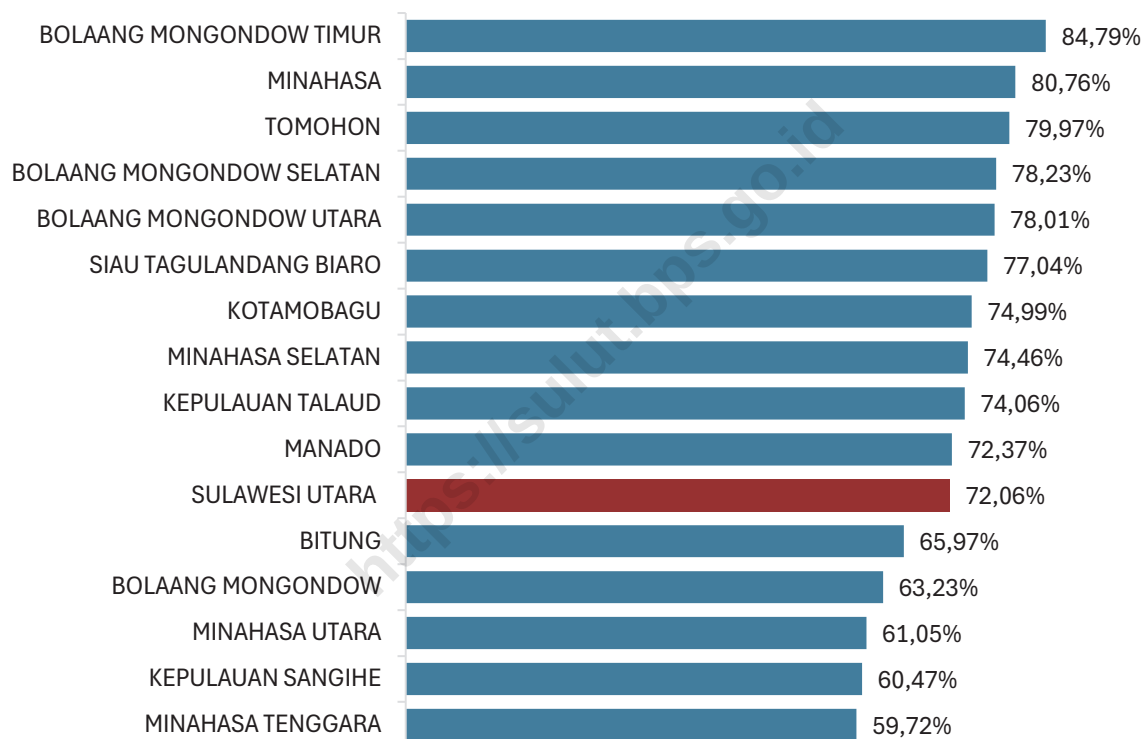
Gambar 2.4 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari (Angka Kesakitan) Menurut Karakteristik, 2023

2.2 Pemerataan Layanan Kesehatan untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat

Perilaku atau upaya kesehatan merupakan setiap aktivitas yang dilakukan oleh individu yang menginginkan dirinya untuk menjadi sehat, dalam upaya pencegahan penyakit atau ketika terdeteksi menderita suatu penyakit (Kasl & Cobb, 1966). Perilaku masyarakat dalam mencari layanan kesehatan dipengaruhi oleh pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan serta aksesibilitas ke fasilitas dan tenaga kesehatan. Perilaku kesehatan masyarakat meliputi upaya preventif (pencegahan sebelum sakit) maupun kuratif (pengobatan ketika sudah menderita sakit). Upaya kesehatan yang dikumpulkan dalam Susenas dibedakan menjadi mengobati sendiri, rawat jalan, dan rawat inap.

WHO mendefinisikan *self-medication* atau mengobati sendiri sebagai pengobatan terhadap gangguan atau gejala yang dikenali sendiri dengan menggunakan obat-obatan tanpa konsultasi terlebih dahulu dengan tenaga kesehatan. Mengobati sendiri merupakan upaya kesehatan yang tersebar luas di seluruh dunia dan dianggap sebagai bagian penting dari

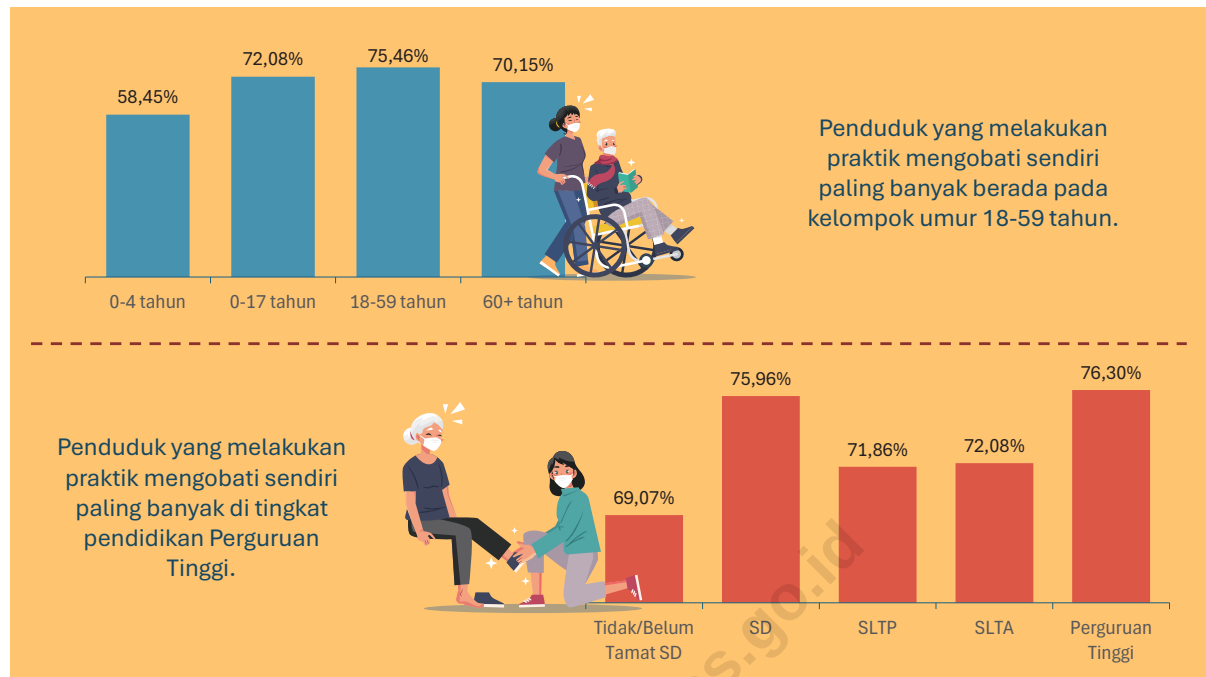
kebijakan kesehatan di berbagai negara. Data Susenas menunjukkan persentase penduduk Sulawesi Utara yang mempunyai keluhan kesehatan dan pernah mengobati sendiri dalam sebulan terakhir pada tahun 2023 yaitu sebesar 72,06 persen. Kabupaten/kota dengan persentase tertinggi penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan pernah mengobati sendiri dalam sebulan terakhir adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yaitu sebesar 84,79 persen. Terdapat lima kabupaten/kota yang memiliki persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan pernah mengobati sendiri dalam sebulan terakhir dibawah persentase Provinsi Sulawesi Utara yakni Kota Bitung, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Kabupaten Minahasa Tenggara yang memiliki persentase terendah yaitu sebesar 59,72 persen.



Gambar 2.5 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Mengobati Sendiri dalam Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota, 2023

Di Provinsi Sulawesi Utara, praktik mengobati sendiri lebih banyak terjadi pada kelompok umur 18-59 tahun yaitu sebesar 75,46 persen. Masih tingginya praktik mengobati sendiri di Sulawesi Utara ditunjukkan dengan persentase seluruh kelompok umur diatas 50 persen. Upaya pengobatan dengan mengobati sendiri tidak sepenuhnya buruk, namun menurut penelitian yang dilakukan di Indonesia, penggunaan obat-obatan dari pengobatan sendiri dan dalam jangka waktu lama pada penyakit tertentu cenderung berbahaya dan berhubungan dengan reaksi obat yang merugikan (Andarini et al., 2019). Sementara itu,

persentase penduduk yang melakukan praktik mengobati sendiri paling banyak di tingkat Perguruan Tinggi.



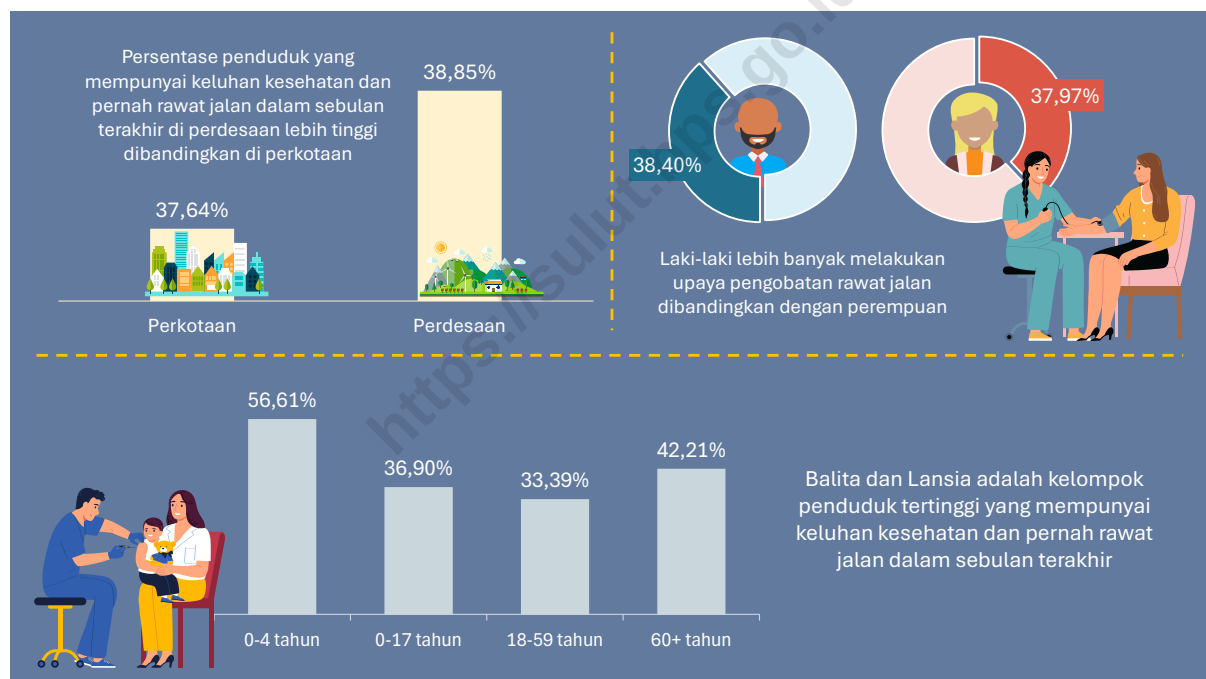
Gambar 2.6 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Mengobati Sendiri dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2023

Upaya kesehatan berikutnya yang umumnya dilakukan penduduk ketika upaya mengobati sendiri belum memberikan hasil yang diharapkan adalah rawat jalan dan rawat inap. Informasi mengenai rawat jalan dan rawat inap juga dapat memberikan gambaran mengenai pemanfaatan atau akses masyarakat terhadap layanan kesehatan baik fasilitas maupun tenaga kesehatan. Pemerataan fasilitas maupun tenaga kesehatan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan merupakan salah satu program pemerintah di bidang kesehatan untuk mencapai sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Persentase penduduk Sulawesi Utara yang mempunyai keluhan kesehatan dan pernah rawat jalan dalam sebulan terakhir pada tahun 2023 sebesar 38,18 persen, atau ada sekitar 38 dari 100 penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan melakukan upaya rawat jalan untuk mengatasi keluhannya tersebut. Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2021 sebesar 41,52 persen dan tahun 2022 sebesar 46,19 persen (Tabel 2.3). Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan kabupaten/kota dengan persentase tertinggi penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan pernah rawat jalan dalam sebulan terakhir yaitu sebesar 59,62 persen. Persentase terendah berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu hanya sebesar 19,72 persen. Dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Kabupaten Minahasa Utara

memiliki selisih kenaikan terbesar persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan pernah rawat jalan dalam sebulan terakhir dimana pada tahun 2021 sebesar 37,66 persen dan naik sebanyak 13,05 persen poin menjadi 50,71 pada tahun 2023.

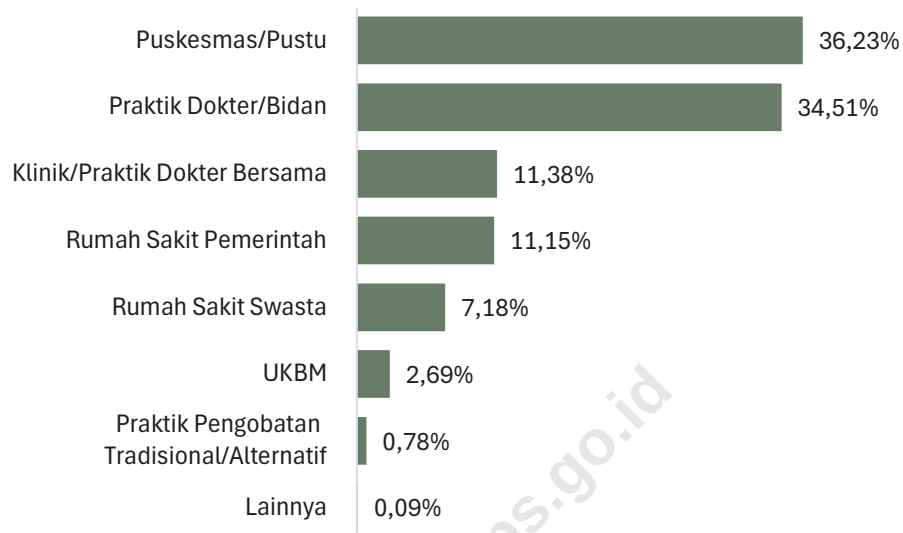
Persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan pernah rawat jalan dalam sebulan terakhir di wilayah perdesaan lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan yaitu 38,85 persen di perdesaan dan 37,64 persen di perkotaan. Gambar 2.7 menunjukkan persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan pernah rawat jalan dalam sebulan terakhir menurut karakteristik sosial ekonomi lainnya yang memberikan gambaran perbedaan pemanfaatan layanan rawat jalan oleh berbagai kelompok masyarakat. Ditinjau dari jenis kelamin, pemanfaatan layanan rawat jalan lebih besar pada laki-laki dibandingkan perempuan. Pemanfaatan layanan rawat jalan juga digunakan paling banyak pada kelompok usia 0-4 tahun (balita) dibandingkan dengan kelompok umur lainnya.



Gambar 2.7 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2023

Tempat rawat jalan yang paling banyak dikunjungi oleh penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan selama sebulan terakhir adalah Puskesmas/Pustu sebesar 36,23 persen diikuti dengan Praktik Dokter/Bidan sebanyak 34,51 persen dan Klinik/Praktik Dokter Bersama sebesar 11,38 persen (Gambar 2.8). Kabupaten/kota dengan persentase tertinggi penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan pernah rawat jalan dalam sebulan terakhir di Puskesmas/Pustu adalah Kota Tomohon (64,48 persen) dan untuk tempat rawat jalan Praktik

Dokter/Bidan adalah Kabupaten Bolaang Mongondow (62,39 persen). Sementara itu, untuk tempat rawat jalan Klinik/Praktik Dokter Bersama yang tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe yaitu 24,29 persen atau sekitar 24 dari 100 penduduk Kabupaten Kepulauan Sangihe yang mempunyai keluhan kesehatan dan pernah rawat jalan dalam sebulan terakhir di Klinik/Praktik Dokter Bersama (Tabel 2.4).



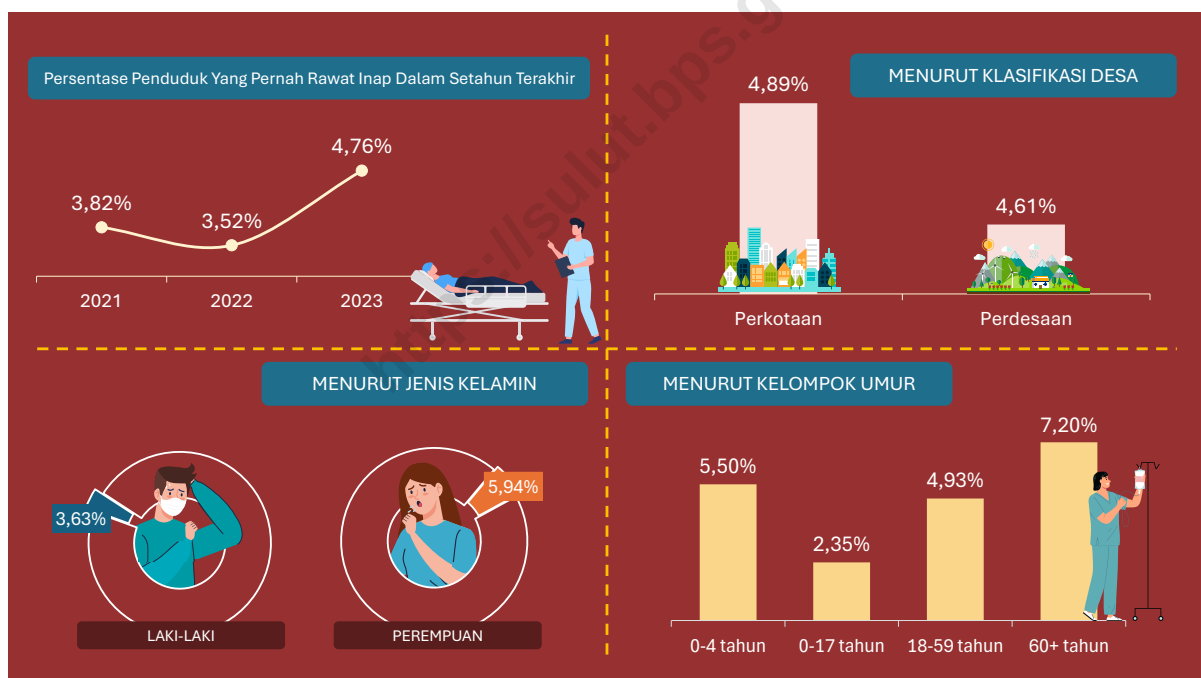
Gambar 2.8 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Tempat Rawat Jalan, 2023

Menurut karakteristiknya, penduduk perkotaan lebih banyak melakukan rawat jalan di Puskesmas/Pustu, Klinik/Praktik Dokter Bersama, Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta (Tabel 2.5). Penduduk perdesaan banyak menggunakan Praktik Dokter/Bidan, UKBM, dan Praktik Pengobatan Tradisional/Alternatif sebagai tempat untuk rawat jalan. Baik penduduk laki-laki maupun perempuan paling banyak melakukan rawat jalan di Puskesmas/Pustu. Persentase penduduk yang melakukan rawat jalan di Puskesmas/Pustu paling banyak pada kelompok umur 60 tahun ke atas (lansia).

Masih rendahnya persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan pernah rawat jalan didasari beragam alasan. Alasan terbesar penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir dan tidak rawat jalan menurut Tabel 2.6 adalah karena lebih memilih untuk mengobati sendiri (62,33 persen) atau karena merasa tidak perlu (34,46 persen). Meskipun persentase untuk alasan-alasan lainnya jauh lebih kecil, namun perlu diperhatikan bahwa masih terdapat penduduk yang tidak melakukan rawat jalan dengan alasan tidak memiliki biaya untuk berobat, tidak ada biaya transpor, dan karena waktu tunggu pelayanan lama. Tabel 2.7 menunjukkan bahwa alasan utama tidak rawat jalan karena tidak mempunyai biaya berobat lebih tinggi pada penduduk yang tinggal di perdesaan dibandingkan

di perkotaan. Sementara itu, alasan utama waktu tunggu pelayanan lama lebih tinggi pada penduduk di perkotaan dibandingkan di perdesaan. Informasi ini dapat membantu pengambil kebijakan untuk merumuskan solusi yang lebih tepat di setiap wilayah.

Upaya kesehatan lebih lanjut yang ditempuh oleh penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan adalah rawat inap. Persentase penduduk yang pernah rawat inap dalam setahun terakhir pada tahun 2021 sebesar 3,82 persen kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 3,52 persen, dan kembali meningkat sebanyak 1,25 persen poin menjadi 4,76 persen pada tahun 2023 (Gambar 2.9). Persentase penduduk yang pernah rawat inap dalam setahun terakhir di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan yaitu 4,89 persen di perkotaan dan 4,61 persen di perdesaan. Ditinjau dari jenis kelamin, pemanfaatan layanan rawat inap lebih besar digunakan oleh perempuan dibandingkan laki-laki. Pemanfaatan layanan rawat inap juga digunakan paling banyak pada kelompok usia 60 tahun ke atas dibandingkan dengan kelompok umur lainnya.

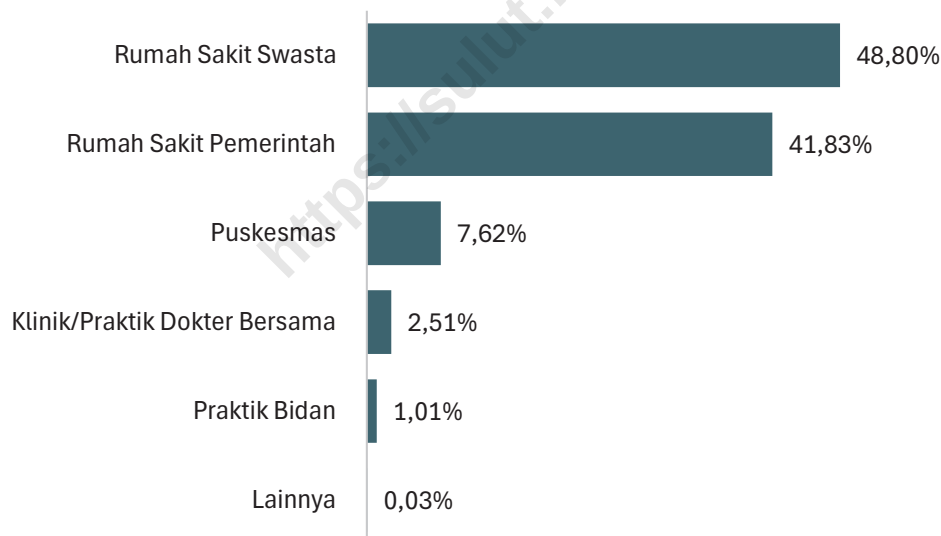


Gambar 2.9 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Dalam Setahun Terakhir Menurut Karakteristik, 2023

Kabupaten/kota dengan persentase tertinggi penduduk yang pernah rawat inap dalam setahun terakhir pada tahun 2023 adalah Kabupaten Minahasa Utara yang mencapai 8,22 persen (Tabel 2.8). Angka ini meningkat sebanyak 3,74 persen poin dari tahun 2022 dan 5,18 persen poin jika dibandingkan dengan tahun 2021. Sementara itu, persentase terendah penduduk yang pernah rawat inap dalam setahun terakhir pada tahun 2023 adalah Kabupaten

Bolaang Mongondow Selatan yaitu sebesar 2,54 persen. Penduduk yang pernah rawat inap di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengalami penurunan sebanyak 0,26 persen poin dibandingkan tahun 2022 dan 0,22 persen poin dibandingkan dengan tahun 2021. Penurunan terbesar persentase penduduk yang pernah rawat inap dalam setahun terakhir terdapat di Kota Tomohon. Persentase penduduk yang pernah rawat inap dalam setahun terakhir di Kota Tomohon pada tahun 2022 sebesar 4,60 persen mengalami penurunan menjadi 3,44 persen pada tahun 2023.

Rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta menjadi fasilitas kesehatan yang paling banyak digunakan oleh penduduk yang pernah rawat inap dalam setahun terakhir. Pada tahun 2023, persentase penduduk yang rawat inap dalam setahun terakhir di Rumah Sakit Swasta sebesar 48,80 persen dan di Rumah Sakit Pemerintah sebesar 41,83 persen (Gambar 2.10). Dengan semakin banyaknya Puskesmas yang menyediakan fasilitas rawat inap menjadikan Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan dengan persentase tertinggi ketiga yang digunakan oleh penduduk yang pernah rawat inap dalam setahun terakhir yaitu sebesar 7,62 persen.



Gambar 2.10 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap Dalam Setahun Terakhir Menurut Tempat Rawat Inap, 2023

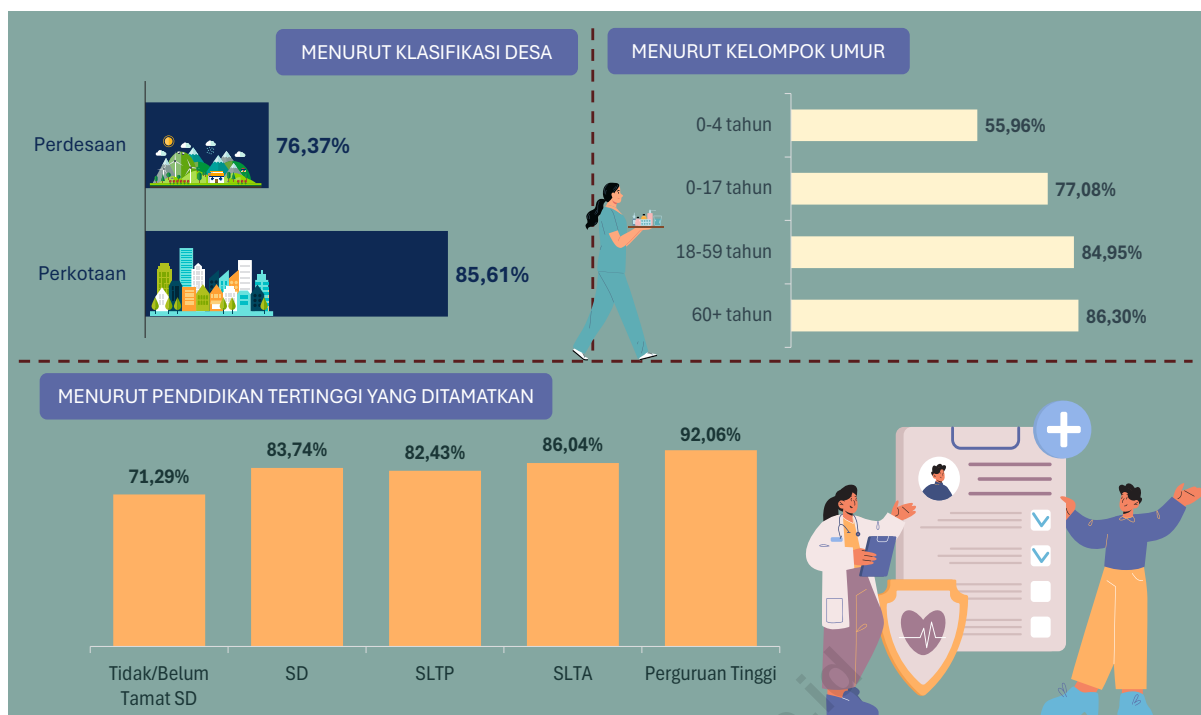
Persentase penduduk yang pernah rawat inap dalam setahun terakhir di RS Swasta dan Praktik Bidan lebih besar di perkotaan dibandingkan di perdesaan (Tabel 2.9). Sementara itu, untuk RS Pemerintah, Klinik/Praktik Dokter Bersama, dan Puskesmas persentasenya lebih besar di perdesaan dibandingkan perkotaan.

2.3 Kepemilikan dan Penggunaan Jaminan Kesehatan

Jaminan kesehatan memungkinkan masyarakat untuk dapat mengakses layanan kesehatan yang diperlukan tanpa harus menghadapi beban finansial yang berlebihan. Hal ini menciptakan perlindungan finansial yang penting untuk mencegah keluarga terperangkap dalam kemiskinan akibat biaya kesehatan yang tinggi. Jaminan kesehatan, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun sektor swasta, memberikan jaminan perlindungan finansial dan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas. Dengan memastikan ketersediaan dana untuk perawatan medis, asuransi kesehatan membantu mencegah terjadinya pemiskinan akibat biaya kesehatan yang tidak terduga. Dengan akses yang memadai terhadap pelayanan kesehatan, individu dapat menjaga kesehatan mereka dengan lebih baik, mencegah penyakit, dan mengelola kondisi kronis.

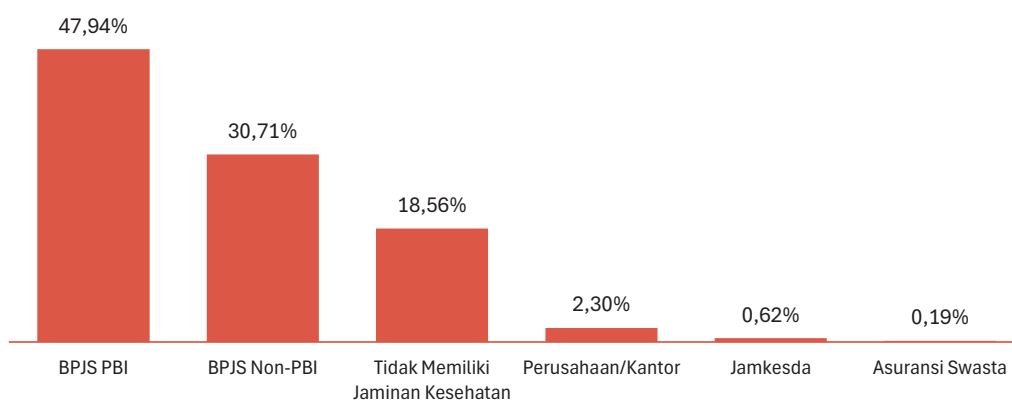
Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan di Sulawesi Utara tahun 2023 mencapai 81,44 persen. Kota Tomohon dan Kota Bitung menonjol sebagai kabupaten/kota dengan persentase tertinggi penduduk yang memiliki jaminan kesehatan. Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan di Kota Tomohon sebesar 91,16 persen dan Kota Bitung sebesar 90,36 persen. Sementara itu, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro menjadi yang terendah dalam persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan yaitu sebesar 68,23 persen (Tabel 2.10).

Kepemilikan jaminan kesehatan juga menunjukkan perbedaan ditinjau dari karakteristik sosial ekonomi penduduk sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.11. Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan di perkotaan sebesar 85,61 persen lebih tinggi dibandingkan di perdesaan yang sebesar 76,37 persen. Kepemilikan jaminan kesehatan semakin meningkat pada kelompok umur yang lebih tinggi. Hal tersebut terkait dengan kebutuhan untuk menjamin ketersediaan pembiayaan kesehatan seiring peningkatan risiko kesehatan pada kelompok umur yang semakin meningkat. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan juga memengaruhi kepemilikan jaminan kesehatan. Persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan semakin besar pada tingkat pendidikan yang semakin tinggi. Hasil penelitian Sari dan Idris (2022) menunjukkan bahwa umur, wilayah, riwayat penyakit kronis, status ekonomi, pendidikan, dan tempat tinggal mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kepemilikan jaminan kesehatan. Teori ekonomi memperkirakan bahwa peningkatan usia seseorang akan menyebabkan penurunan kondisi kesehatan dan mereka menjaga kesehatan dengan berinvestasi di bidang kesehatan melalui asuransi kesehatan.



Gambar 2.11 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Karakteristik, 2023

Sebagian besar penduduk di Provinsi Sulawesi Utara memiliki jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan baik PBI maupun Non-PBI. Gambar 2.12 menunjukkan bahwa persentase penduduk yang memiliki jaminan kesehatan berupa BPJS Kesehatan sebesar 78,65 persen, dengan persentase untuk PBI sebesar 47,94 persen dan Non-PBI sebesar 30,71 persen. Selanjutnya sebanyak 18,56 persen tidak memiliki jaminan kesehatan, sebanyak 2,30 persen memiliki jaminan kesehatan dari perusahaan/kantor, sebanyak 0,62 persen memiliki jaminan kesehatan jamkesda, dan 0,19 persen sisanya memiliki jaminan kesehatan dari asuransi swasta.



Gambar 2.12 Persentase Penduduk yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki, 2023

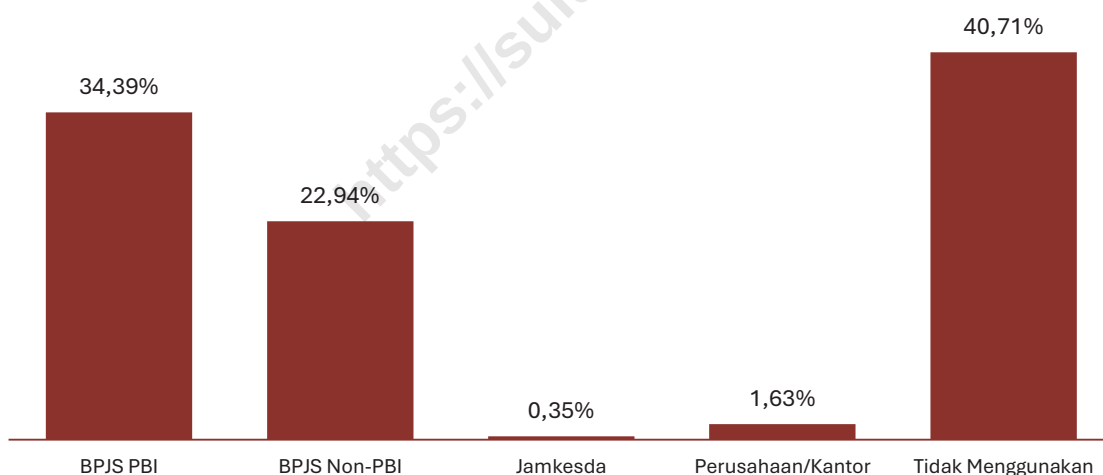
Dengan adanya desentralisasi, pemerintah daerah memiliki peran besar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan program jaminan kesehatan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakatnya. Hal tersebut mendorong fleksibilitas yang diperlukan untuk menyesuaikan program kesehatan dengan kondisi sosial dan ekonomi daerah maupun kemampuan fiskal pemerintah daerah. Pemerintah pusat terus mendorong integrasi program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan BPJS Kesehatan. Integrasi Jamkesda ke dalam BPJS Kesehatan akan meningkatkan cakupan dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta menciptakan keterpaduan data dan sistem informasi sehingga memungkinkan pengelolaan data peserta, pembiayaan, dan informasi kesehatan lainnya dapat diintegrasikan secara lebih baik. Berdasarkan data Susenas tahun 2023, persentase penduduk yang memiliki Jamkesda di Provinsi Sulawesi Utara sudah mendekati 0 persen. Hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya integrasi program Jamkesda di Provinsi Sulawesi Utara dengan BPJS Kesehatan.

Kabupaten/kota dengan persentase tertinggi penduduk yang memiliki jaminan kesehatan berupa BPJS Kesehatan adalah Kota Tomohon yaitu sebesar 87,83 persen yang terdiri dari 56,86 persen BPJS PBI dan 30,97 persen BPJS Non-PBI (Tabel 2.11). Sementara itu, persentase terendah penduduk yang memiliki jaminan kesehatan berupa BPJS Kesehatan berada di Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu sebesar 65,32 persen yang terdiri dari 38,65 persen BPJS PBI dan 26,67 persen BPJS Non-PBI. Wilayah dengan persentase tertinggi penduduk yang memiliki jaminan kesehatan BPJS Kesehatan PBI adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (70,90 persen). Untuk kepemilikan jaminan kesehatan berupa BPJS Kesehatan Non-PBI, kabupaten/kota dengan persentase tertinggi adalah Kota Manado yaitu sebesar 41,93 persen.

Sekitar 82 dari 100 penduduk yang tinggal di perkotaan memiliki jaminan kesehatan berupa BPJS Kesehatan (45,02 persen memiliki BPJS PBI dan 37,01 persen memiliki BPJS Non-PBI), sementara di perdesaan hanya sekitar 74 dari 100 penduduk yang memiliki jaminan kesehatan berupa BPJS Kesehatan (Tabel 2.12). Persentase penduduk yang memiliki BPJS Kesehatan PBI lebih tinggi di perdesaan dibandingkan di perkotaan yaitu sebesar 51,49 persen di perdesaan dan 45,02 persen di perkotaan. Sebaliknya untuk BPJS Kesehatan Non-PBI, persentase kepemilikan jaminan kesehatan lebih tinggi di perkotaan dibandingkan di perdesaan. Pada Tabel 2.12 juga ditunjukkan perbedaan pola kepemilikan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan PBI dan Non-PBI menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Persentase kepemilikan jaminan kesehatan berupa BPJS Kesehatan Non-PBI semakin besar seiring semakin tingginya pendidikan terakhir yang ditamatkan.

Pada tahun 2023, ada 59,29 persen atau sekitar 59 dari 100 penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan dalam sebulan terakhir (Tabel 2.13). Dilihat dari penggunaan jaminan kesehatan, Kota Tomohon yang merupakan wilayah dengan persentase tertinggi penduduk yang memiliki jaminan kesehatan juga memiliki persentase tertinggi penduduk yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan dalam sebulan terakhir yaitu sebesar 85,04 persen. Hal ini menunjukkan sebagian besar penduduk yang memiliki jaminan kesehatan di Kota Tomohon telah cukup optimal dalam penggunaan jaminan kesehatan yang dimilikinya untuk berobat jalan. Persentase terendah penduduk yang berobat jalan dalam sebulan terakhir dengan menggunakan jaminan kesehatan terdapat di Kabupaten Bolaang Mongondow (27,08 persen).

Jenis jaminan kesehatan yang paling banyak digunakan oleh penduduk yang berobat jalan dalam sebulan terakhir adalah BPJS Kesehatan sebesar 57,33 persen. Penggunaan BPJS Kesehatan PBI oleh penduduk yang berobat jalan dalam sebulan terakhir lebih tinggi dibandingkan penggunaan BPJS Kesehatan Non-PBI yaitu 34,39 persen dibanding 22,94 persen (Gambar 2.13). Meskipun demikian, sebagian besar penduduk (40,71 persen) yang berobat jalan dalam sebulan terakhir ternyata tidak menggunakan jaminan kesehatan apapun.

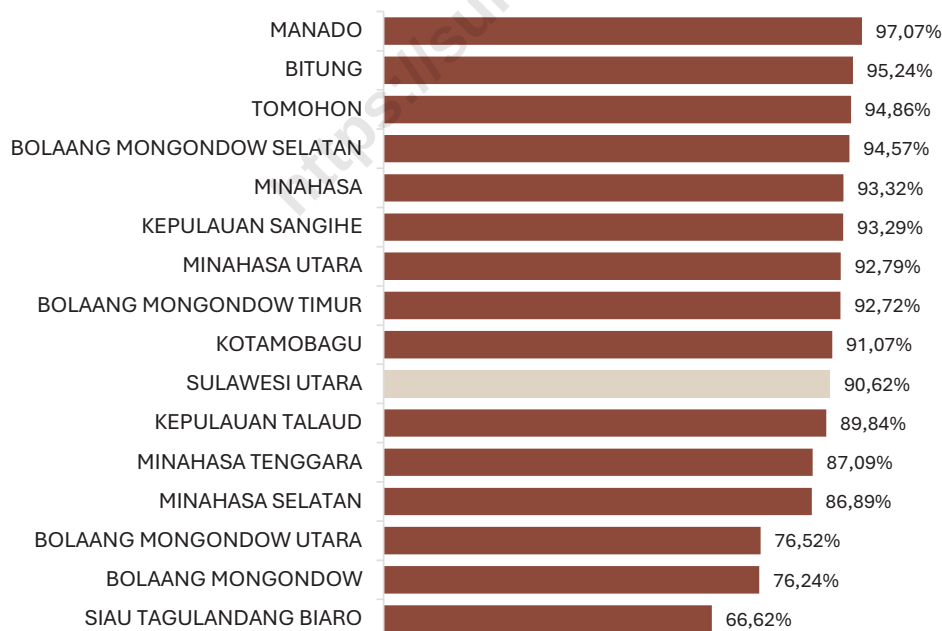


Gambar 2.13 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Jenis Jaminan Kesehatan yang Dimiliki, 2023

Tabel 2.14 memberikan informasi mengenai penggunaan jaminan kesehatan oleh penduduk untuk berobat jalan dalam sebulan terakhir berdasarkan beberapa karakteristik. Persentase penduduk yang berobat jalan dalam sebulan terakhir dan menggunakan jaminan kesehatan di perkotaan sebesar 71,67 persen, lebih tinggi dibandingkan di perdesaan yang hanya sebesar 44,41 persen. Persentase penduduk perdesaan yang berobat jalan dalam

sebulan terakhir menggunakan BPJS Kesehatan Non-PBI hanya sebesar 13,44 persen, jauh lebih rendah dibandingkan persentase di perkotaan yang mencapai 30,85 persen. Persentase penduduk perdesaan yang berobat jalan dalam sebulan terakhir menggunakan BPJS Kesehatan PBI juga jauh lebih rendah yaitu sebesar 30,05 persen sedangkan di perkotaan mencapai 38,00 persen. Persentase penggunaan jaminan kesehatan untuk berobat jalan dalam sebulan terakhir dilihat dari kelompok umur paling banyak pada kelompok umur 60 tahun ke atas yakni sebesar 71,78 persen. Jika ditinjau berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, persentase penduduk yang berobat jalan dalam sebulan terakhir dan menggunakan jaminan kesehatan semakin besar sejalan dengan peningkatan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

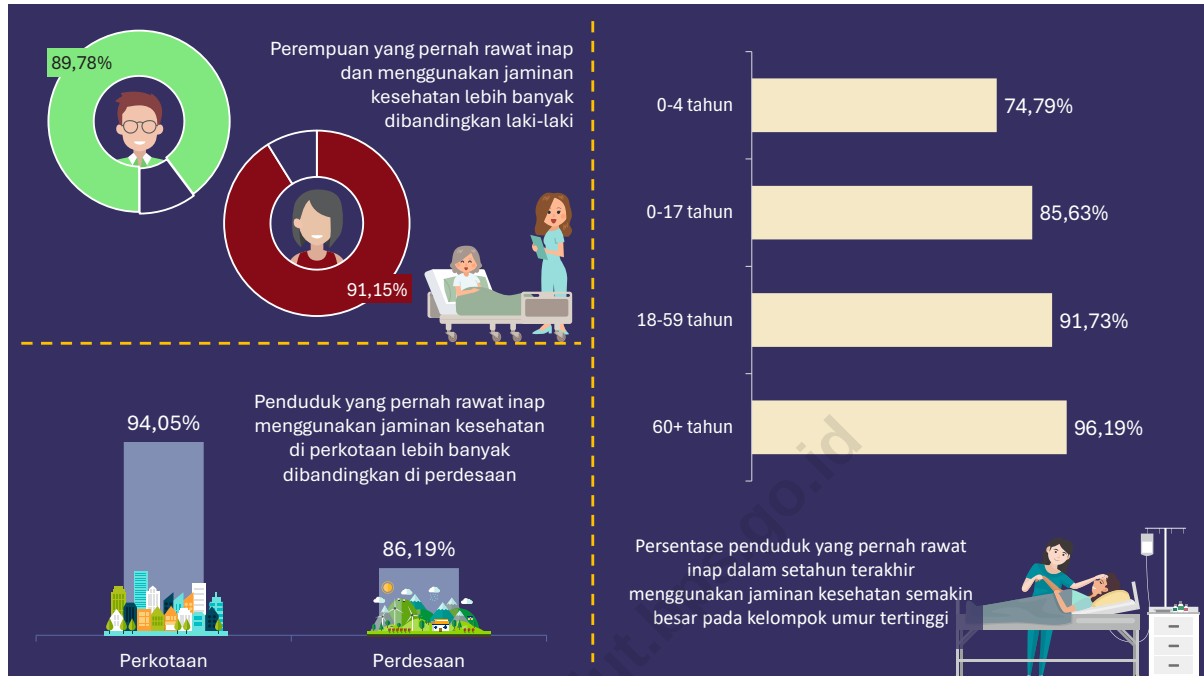
Sebagaimana pada rawat jalan, persentase penduduk yang pernah rawat inap dalam setahun terakhir menggunakan jaminan kesehatan pada tahun 2023 tercatat sebanyak 90,62 persen. Angka ini dapat diartikan sebagai sekitar 90 dari 100 penduduk yang pernah rawat inap dalam setahun terakhir menggunakan jaminan kesehatan. Kota Manado merupakan kabupaten/kota dengan persentase tertinggi penduduk yang pernah rawat inap dalam setahun terakhir menggunakan jaminan kesehatan yaitu sebesar 97,07 persen (Gambar 2.14). Persentase terendah terdapat di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro yaitu sebesar 66,62 persen.



Gambar 2.14 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota, 2023

Persentase perempuan yang pernah rawat inap dalam setahun terakhir menggunakan jaminan kesehatan sebesar 91,15 persen, lebih tinggi dibandingkan persentase laki-laki yang sebesar 89,78 persen. Berdasarkan klasifikasi desa, persentase penduduk yang pernah rawat

inap dalam setahun terakhir menggunakan jaminan kesehatan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Sebagaimana pola pada rawat jalan, persentase penduduk yang pernah rawat inap dalam setahun terakhir menggunakan jaminan kesehatan semakin besar pada kelompok umur tertinggi (60 tahun ke atas) yakni sebesar 96,19 persen.



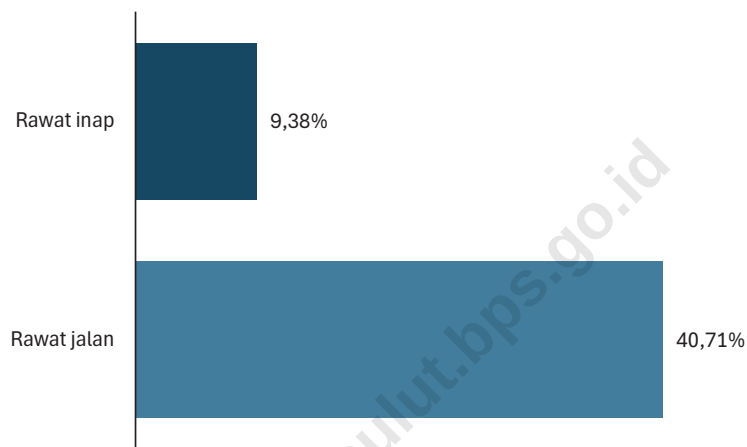
Gambar 2.15 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Karakteristik, 2023

Persentase penduduk yang pernah rawat inap dalam setahun terakhir menggunakan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan pada tahun 2023 sebesar 88,75 persen dengan persentase yang menggunakan BPJS Kesehatan PBI sebesar 50,79 persen sedangkan yang menggunakan BPJS Kesehatan Non-PBI sebesar 37,96 persen (Tabel 2.15). Kabupaten/kota dengan persentase penduduk yang pernah rawat inap dalam setahun terakhir menggunakan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan yang tertinggi adalah Kota Bitung yaitu sebesar 93,95 persen (58,96 persen menggunakan BPJS PBI dan 34,99 persen menggunakan BPJS Non-PBI) dan yang terendah adalah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro yaitu sebesar 66,62 persen (31,24 persen menggunakan BPJS PBI dan 35,38 persen menggunakan BPJS Non-PBI).

Persentase perempuan yang pernah rawat inap dalam setahun terakhir menggunakan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan sebesar 89,17 persen lebih tinggi dibandingkan persentase laki-laki yang sebesar 88,06 persen (Tabel 2.16). Berdasarkan klasifikasi desa, persentase penduduk yang pernah rawat inap dalam setahun terakhir menggunakan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Sebagaimana pola

pada rawat jalan, persentase penduduk yang pernah rawat inap dalam setahun terakhir menggunakan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan semakin besar pada kelompok umur tertinggi (60 tahun ke atas) yakni sebesar 96,19 persen.

Persentase penduduk yang pernah rawat inap dalam setahun terakhir namun tidak menggunakan jaminan kesehatan lebih rendah dibandingkan pada rawat jalan. Hanya sekitar 9 dari 100 penduduk yang pernah rawat inap dalam setahun terakhir tidak menggunakan jaminan kesehatan (Gambar 2.15). Hal ini menunjukkan penduduk Sulawesi Utara lebih banyak menggunakan jaminan kesehatan untuk rawat inap dibandingkan rawat jalan.



Gambar 2.16 Persentase Penduduk yang Tidak Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Rawat Jalan atau Rawat Inap, 2023

2.4 Kebiasaan Merokok di Provinsi Sulawesi Utara

Kebiasaan merokok dapat menyebabkan munculnya penyakit kronis pada usia produktif dan meningkatkan morbiditas serta kematian prematur yang tinggi. Penyebab utama kematian terkait kebiasaan merokok adalah penyakit jantung, kanker, *stroke* dan penyakit saluran pernapasan (WHO, 2020). Perilaku merokok menjadi tantangan serius dalam upaya menjaga kesehatan masyarakat. Meskipun telah ada langkah-langkah pencegahan dan kontrol, prevalensi merokok di Indonesia termasuk Sulawesi Utara masih tinggi, mempengaruhi berbagai kelompok usia dan lapisan masyarakat. Dampak kesehatan jangka panjang dari kebiasaan merokok, seperti peningkatan risiko penyakit jantung, kanker, dan gangguan pernapasan, menunjukkan urgensi untuk meningkatkan upaya pencegahan, pendidikan, serta regulasi yang lebih ketat terkait dengan tembakau.

Rokok elektrik atau yang dikenal dengan sebutan *vape* telah menjadi fenomena yang populer terutama di kalangan muda dalam beberapa tahun terakhir dan menciptakan dinamika baru dalam perilaku merokok. Meskipun dianggap sebagai alternatif yang lebih aman oleh sebagian orang, pemerintah dan lembaga kesehatan tetap menemukan adanya tantangan dalam mengelola fenomena ini. Sebagai bagian dari upaya menyeluruh untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, pemahaman yang mendalam terhadap fenomena rokok elektrik perlu terus diperbaharui untuk mendukung kebijakan yang efektif dan responsif terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat.

Persentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang merokok menggunakan rokok elektrik selama sebulan terakhir di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2023 sebesar 1,55 persen (Tabel 2.17). Persentase tertinggi penduduk umur 15 tahun ke atas yang merokok menggunakan rokok elektrik selama sebulan terakhir berada di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu sebesar 2,75 persen dan penggunaan rokok elektrik terendah berada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu sebesar 0,51 persen. Penelitian Pitriyanti et.al (2018) terhadap mahasiswa Universitas Udayana Bali menunjukkan bahwa alasan utama para mahasiswa menggunakan rokok elektrik adalah motivasi untuk berhenti merokok. Alasan lainnya adalah asumsi bahwa rokok elektrik lebih aman, alasan kesenangan, rasa ingin tahu, dan coba-coba.

Persentase penduduk umur 15 tahun ke atas yang merokok menggunakan rokok elektrik selama sebulan terakhir di perdesaan sebesar 1,71 persen, lebih tinggi dibandingkan di perkotaan yang sebesar 1,42 persen (Tabel 2.18). Jika ditinjau menurut kelompok umur, persentase tertinggi penduduk umur 15 tahun ke atas yang merokok menggunakan rokok elektrik selama sebulan terakhir terdapat pada kelompok umur 18-59 tahun yaitu 1,83 persen atau sekitar 1 dari 100 penduduk pada kelompok umur ini merokok menggunakan rokok elektrik selama sebulan terakhir. Tabel 2.18 juga menunjukkan bahwa perilaku merokok menggunakan rokok elektrik cenderung lebih banyak dilakukan oleh penduduk laki-laki dan pada pendidikan minimal SD.

Perilaku merokok menggunakan rokok tembakau lebih populer di masyarakat Indonesia termasuk Sulawesi Utara dibandingkan menggunakan rokok elektrik. Tabel 2.19 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 22 dari 100 penduduk umur 5 tahun ke atas merokok tembakau selama sebulan terakhir. Sebanyak 22,53 persen penduduk Sulawesi Utara pengguna rokok tembakau tersebut terdiri dari 18,79 persen penduduk yang merokok setiap hari dan 3,74 persen penduduk yang merokok tidak setiap hari. Jika dilihat berdasarkan kabupaten/

kota, wilayah dengan persentase tertinggi penduduk umur 5 tahun ke atas yang merokok tembakau selama sebulan terakhir pada tahun 2023 adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (30,58 persen) yang terdiri dari 27,64 persen penduduk yang merokok setiap hari dan 2,94 persen penduduk yang merokok tidak setiap hari. Kota Tomohon menjadi wilayah dengan persentase terendah yaitu sebesar 18,74 persen yang terdiri dari 14,97 persen penduduk yang merokok setiap hari dan 3,77 persen penduduk yang merokok tidak setiap hari.

Sejalan dengan perilaku merokok menggunakan rokok elektrik, pada Tabel 2.20 ditunjukkan persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang merokok tembakau selama sebulan terakhir lebih tinggi di perdesaan dibandingkan di perkotaan, yaitu 24,24 persen di perdesaan (20,21 persen penduduk yang merokok setiap hari dan 4,03 persen penduduk yang merokok tidak setiap hari) dibandingkan 21,13 persen di perkotaan (17,63 persen penduduk yang merokok setiap hari dan 3,50 persen penduduk yang merokok tidak setiap hari). Laki-laki usia 5 tahun ke atas yang merokok tembakau selama sebulan terakhir memiliki persentase jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan. Lebih dari separuh laki-laki usia 5 tahun ke atas merokok tembakau selama sebulan terakhir (42,43 persen), sementara untuk perempuan hanya 1 diantara 100 perempuan yang merokok tembakau selama sebulan terakhir (1,89 persen). Dilihat dari tingkat pendidikan, perilaku merokok menggunakan rokok tembakau cenderung lebih banyak dilakukan pada penduduk dengan pendidikan minimal SLTP yakni sebanyak 27,30 persen (23,08 persen penduduk yang merokok setiap hari dan 4,21 persen penduduk yang merokok tidak setiap hari).

Rata-rata batang rokok yang dihisap per hari oleh penduduk umur 15 tahun ke atas yang merokok selama sebulan terakhir di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2023 sebanyak 12 batang per hari. Sejalan dengan penjelasan sebelumnya, persentase perokok umur 15 tahun ke atas di perdesaan lebih besar dibandingkan di perkotaan. Data pada Gambar 2.17 menunjukkan bahwa rata-rata batang rokok yang dihisap per hari oleh penduduk umur 15 tahun ke atas yang merokok selama sebulan terakhir lebih besar di perdesaan (87 batang per minggu atau 12 batang per hari) dibandingkan di perkotaan (79 batang per minggu atau 11 batang per hari). Rata-rata batang rokok yang dihisap per hari oleh penduduk laki-laki berumur 15 tahun ke atas selama sebulan terakhir adalah 83 batang per minggu atau 12 batang per hari, lebih tinggi daripada perempuan yang memiliki rata-rata 70 batang per minggu atau 10 batang rokok per hari. Rata-rata batang rokok yang dihisap per hari oleh penduduk umur 15 tahun ke atas yang merokok selama sebulan terakhir paling banyak pada kelompok umur 18 sampai 59 tahun dan penduduk yang memiliki pendidikan terakhir setingkat Perguruan Tinggi.



Gambar 2.17 Rata-rata Jumlah Batang Rokok yang Dihisap per Minggu oleh Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Merokok selama Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2023

Tabel 2.1 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota, 2021–2023

No.	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bolaang Mongondow	16,27	29,23	20,97
2	Minahasa	37,17	27,19	34,99
3	Kepulauan Sangihe	16,93	19,69	22,17
4	Kepulauan Talaud	21,92	23,37	23,53
5	Minahasa Selatan	18,72	30,35	28,93
6	Minahasa Utara	13,67	23,92	27,31
7	Bolaang Mongondow Utara	21,46	28,65	24,73
8	Siau Tagulandang Biaro	16,95	17,99	15,13
9	Minahasa Tenggara	15,45	32,16	27,86
10	Bolaang Mongondow Selatan	20,15	33,87	22,20
11	Bolaang Mongondow Timur	21,17	26,61	27,89
12	Manado	31,09	8,22	20,63
13	Bitung	13,08	19,18	22,62
14	Tomohon	15,75	26,61	24,94
15	Kotamobagu	18,43	31,72	22,77
Sulawesi Utara		22,09	23,31	25,05

Tabel 2.2 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari Menurut Kabupaten/Kota, 2021–2023

No.	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bolaang Mongondow	8,15	14,27	11,70
2	Minahasa	13,19	7,80	12,70
3	Kepulauan Sangihe	10,99	14,48	15,00
4	Kepulauan Talaud	12,89	10,70	12,18
5	Minahasa Selatan	10,07	23,10	15,56
6	Minahasa Utara	8,04	13,81	11,83
7	Bolaang Mongondow Utara	10,25	15,50	10,94
8	Siau Tagulandang Biaro	6,32	9,66	7,81
9	Minahasa Tenggara	7,45	21,58	14,33
10	Bolaang Mongondow Selatan	10,69	12,98	14,80
11	Bolaang Mongondow Timur	9,14	13,98	13,88
12	Manado	12,46	4,18	7,47
13	Bitung	7,58	11,01	14,26
14	Tomohon	5,32	7,33	9,32
15	Kotamobagu	6,94	11,28	10,48
Sulawesi Utara		9,90	11,69	11,83

Tabel 2.3 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota, 2021–2023

No.	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bolaang Mongondow	50,96	45,97	48,35
2	Minahasa	35,27	28,80	28,02
3	Kepulauan Sangihe	69,31	66,08	59,62
4	Kepulauan Talaud	39,90	66,85	40,68
5	Minahasa Selatan	46,08	33,24	34,68
6	Minahasa Utara	37,66	38,80	50,71
7	Bolaang Mongondow Utara	42,82	66,15	44,70
8	Siau Tagulandang Biaro	35,23	79,32	37,80
9	Minahasa Tenggara	42,88	49,03	44,44
10	Bolaang Mongondow Selatan	27,63	76,67	19,72
11	Bolaang Mongondow Timur	32,04	79,33	24,64
12	Manado	42,03	33,47	33,50
13	Bitung	51,04	37,72	44,73
14	Tomohon	44,64	63,09	35,05
15	Kotamobagu	29,58	43,22	35,66
Sulawesi Utara		41,52	46,19	38,18

Tabel 2.4 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Tempat Rawat Jalan, 2023

No.	Kabupaten/Kota	Rumah Sakit Pemerintah	Rumah Sakit Swasta	Praktik Dokter/ Bidan	Klinik/ Praktik Dokter Bersama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bolaang Mongondow	3,89	–	62,39	10,04
2	Minahasa	19,74	9,70	26,82	9,93
3	Kepulauan Sangihe	7,67	–	38,07	24,29
4	Kepulauan Talaud	9,65	0,44	49,45	4,19
5	Minahasa Selatan	7,07	10,71	47,41	5,16
6	Minahasa Utara	12,17	12,92	28,23	6,07
7	Bolaang Mongondow Utara	7,88	–	20,68	11,26
8	Siau Tagulandang Biaro	9,18	0,24	20,61	13,45
9	Minahasa Tenggara	10,80	2,43	47,75	6,32
10	Bolaang Mongondow Selatan	16,11	–	7,26	15,00
11	Bolaang Mongondow Timur	6,25	1,72	45,66	3,92
12	Manado	15,31	9,78	29,80	15,32
13	Bitung	11,19	10,32	19,52	22,25
14	Tomohon	3,92	23,28	3,55	7,21
15	Kotamobagu	13,64	2,52	39,68	8,35
Sulawesi Utara		11,15	7,18	34,51	11,38

Lanjutan Tabel 2.4

No.	Kabupaten/Kota	Puskesmas/ Pustu	UKBM	Praktik Pengobatan Tradisional/ Alternatif	Lainnya
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Bolaang Mongondow	24,72	1,73	1,22	–
2	Minahasa	36,56	1,77	1,77	–
3	Kepulauan Sangihe	31,05	6,46	0,29	–
4	Kepulauan Talaud	35,57	1,73	1,00	0,80
5	Minahasa Selatan	32,94	–	1,07	–
6	Minahasa Utara	37,61	4,37	–	–
7	Bolaang Mongondow Utara	54,01	7,51	0,19	–
8	Siau Tagulandang Biaro	58,18	8,59	–	–
9	Minahasa Tenggara	31,97	3,66	1,22	–
10	Bolaang Mongondow Selatan	57,79	4,18	1,70	1,68
11	Bolaang Mongondow Timur	41,07	3,40	0,62	0,50
12	Manado	30,26	–	–	–
13	Bitung	38,49	0,33	1,08	–
14	Tomohon	64,48	2,62	1,04	–
15	Kotamobagu	35,18	7,73	–	0,62
Sulawesi Utara		36,23	2,69	0,78	0,09

Tabel 2.5 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik dan Tempat Rawat Jalan, 2023

Karakteristik	Rumah Sakit Pemerintah	Rumah Sakit Swasta	Praktik Dokter/ Bidan	Klinik/Praktik Dokter Bersama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	12,04	9,78	28,81	14,13
Perdesaan	10,08	4,06	41,36	8,08
Jenis Kelamin				
Laki-laki	11,15	7,44	35,18	10,81
Perempuan	11,15	6,95	33,88	11,92
Kelompok Umur				
0-4 tahun	4,76	5,86	42,44	8,75
0-17 tahun	7,91	7,19	33,30	14,35
18-59 tahun	12,44	7,05	34,44	11,06
60+ tahun	14,89	8,19	30,94	11,30
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	6,78	5,58	35,42	10,38
SD/Sederajat	11,61	7,90	36,99	8,20
SMP/Sederajat	14,91	6,72	32,23	13,59
SMA/Sederajat	12,64	8,06	33,02	12,88
Perguruan Tinggi	19,30	12,08	34,05	14,06
Sulawesi Utara	11,15	7,18	34,51	11,38

Lanjutan Tabel 2.5

Karakteristik	Puskesmas/ Pustu	UKBM	Praktik Pengobatan Tradisional/ Alternatif	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	36,28	1,46	0,73	0,08
Perdesaan	36,17	4,16	0,84	0,10
Jenis Kelamin				
Laki-laki	35,32	3,01	0,83	0,09
Perempuan	37,07	2,38	0,73	0,09
Kelompok Umur				
0-4 tahun	36,69	3,92	—	—
0-17 tahun	35,85	3,64	0,78	0,16
18-59 tahun	35,50	2,29	0,90	0,05
60+ tahun	37,56	1,98	1,01	0,15
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	41,32	3,23	0,67	0,12
SD/Sederajat	36,27	3,23	0,47	0,12
SMP/Sederajat	33,19	2,58	0,67	0,08
SMA/Sederajat	34,99	1,21	0,86	—
Perguruan Tinggi	20,71	3,65	2,03	0,16
Sulawesi Utara	36,23	2,69	0,78	0,09

Tabel 2.6 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Tidak Rawat Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Alasan Utama Tidak Rawat Jalan, 2023

No.	Kabupaten/Kota	Tidak Punya Biaya Berobat	Tidak Ada Biaya Transpor	Tidak Ada Sarana Transportasi	Waktu Tunggu Pelayanan Lama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bolaang Mongondow	0,60	—	—	—
2	Minahasa	0,57	0,37	0,10	0,02
3	Kepulauan Sangihe	—	0,52	0,72	—
4	Kepulauan Talaud	2,27	0,45	—	—
5	Minahasa Selatan	0,13	—	0,11	—
6	Minahasa Utara	0,85	—	—	—
7	Bolaang Mongondow Utara	0,33	0,35	—	—
8	Siau Tagulandang Biaro	1,74	—	—	—
9	Minahasa Tenggara	1,75	—	—	—
10	Bolaang Mongondow Selatan	0,17	2,59	—	0,38
11	Bolaang Mongondow Timur	—	—	—	—
12	Manado	0,34	0,04	—	0,29
13	Bitung	—	—	—	1,28
14	Tomohon	—	0,13	—	—
15	Kotamobagu	—	0,62	—	0,13
Sulawesi Utara		0,48	0,24	0,06	0,16

Lanjutan Tabel 2.6

No.	Kabupaten/Kota	Mengobati Sendiri	Tidak Ada yang Mendampingi	Merasa Tidak Perlu	Lainnya
(1)	(2)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Bolaang Mongondow	66,09	0,41	27,47	5,42
2	Minahasa	70,81	–	27,69	0,44
3	Kepulauan Sangihe	77,37	–	18,80	2,59
4	Kepulauan Talaud	87,37	–	7,33	2,57
5	Minahasa Selatan	45,78	–	52,77	1,21
6	Minahasa Utara	55,31	0,44	40,87	2,53
7	Bolaang Mongondow Utara	44,63	–	39,50	15,20
8	Siau Tagulandang Biaro	52,38	–	43,41	2,47
9	Minahasa Tenggara	37,08	–	54,64	6,53
10	Bolaang Mongondow Selatan	58,20	–	38,48	0,17
11	Bolaang Mongondow Timur	80,23	–	19,69	0,08
12	Manado	54,30	–	43,74	1,29
13	Bitung	70,20	0,54	25,95	2,04
14	Tomohon	56,03	–	41,27	2,57
15	Kotamobagu	78,64	–	20,28	0,32
Sulawesi Utara		62,33	0,10	34,46	2,17

Tabel 2.7 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Tidak Rawat Jalan Menurut Karakteristik dan Alasan Utama Tidak Rawat Jalan, 2023

Karakteristik	Tidak Punya Biaya Berobat	Tidak Ada Biaya Transpor	Tidak Ada Sarana Transportasi	Waktu Tunggu Pelayanan Lama
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	0,18	0,08	0,02	0,26
Perdesaan	0,87	0,46	0,10	0,03
Jenis Kelamin				
Laki-laki	0,52	0,24	0,04	0,23
Perempuan	0,45	0,25	0,06	0,10
Kelompok Umur				
0-4 tahun	0,78	0,84	—	—
0-17 tahun	0,30	0,21	—	0,10
18-59 tahun	0,39	—	0,02	0,17
60+ tahun	0,79	0,72	0,21	0,23
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	0,63	0,60	0,07	0,23
SD/Sederajat	0,32	0,09	0,12	0,33
SMP/Sederajat	0,83	0,24	—	0,16
SMA/Sederajat	0,20	0,02	0,04	—
Perguruan Tinggi	0,48	—	—	—
Sulawesi Utara	0,48	0,24	0,06	0,16

Lanjutan Tabel 2.7

Karakteristik	Mengobati Sendiri	Tidak Ada yang Mendampingi	Merasa Tidak Perlu	Lainnya
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	63,34	0,07	34,30	1,76
Perdesaan	61,04	0,14	34,68	2,69
Jenis Kelamin				
Laki-laki	61,93	0,08	34,93	2,02
Perempuan	62,69	0,11	34,04	2,31
Kelompok Umur				
0-4 tahun	66,71	–	29,56	2,12
0-17 tahun	62,20	–	34,66	2,52
18-59 tahun	62,70	0,07	34,55	2,10
60+ tahun	60,06	0,29	35,63	2,06
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	62,31	0,10	33,18	2,88
SD/Sederajat	60,44	0,16	36,86	1,67
SMP/Sederajat	65,34	0,23	31,47	1,74
SMA/Sederajat	59,92	–	37,75	2,06
Perguruan Tinggi	68,10	–	29,51	1,91
Sulawesi Utara	62,33	0,10	34,46	2,17

Tabel 2.8 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota, 2021–2023

No.	Kabupaten/Kota	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bolaang Mongondow	4,15	3,35	3,86
2	Minahasa	5,01	4,08	5,22
3	Kepulauan Sangihe	3,74	3,59	3,64
4	Kepulauan Talaud	3,82	2,93	3,40
5	Minahasa Selatan	4,33	3,94	5,65
6	Minahasa Utara	3,03	4,48	8,22
7	Bolaang Mongondow Utara	4,57	2,56	4,90
8	Siau Tagulandang Biaro	3,45	2,52	2,62
9	Minahasa Tenggara	3,29	3,33	4,61
10	Bolaang Mongondow Selatan	2,76	2,81	2,54
11	Bolaang Mongondow Timur	4,18	3,34	4,43
12	Manado	2,87	2,34	4,10
13	Bitung	3,45	4,50	5,88
14	Tomohon	4,48	4,60	3,44
15	Kotamobagu	4,19	3,53	4,44
Sulawesi Utara		3,82	3,52	4,76

Tabel 2.9 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menurut Karakteristik dan Tempat Rawat Inap, 2023

Karakteristik	RS Pemerintah	RS Swasta	Praktik Bidan
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	40,16	55,23	1,11
Perdesaan	44,00	40,50	0,88
Jenis Kelamin			
Laki-laki	44,12	48,26	–
Perempuan	40,39	49,15	1,65
Kelompok Umur			
0-4 tahun	31,65	60,37	1,16
0-17 tahun	47,39	44,85	–
18-59 tahun	41,20	47,85	1,39
60+ tahun	45,16	48,84	0,30
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	39,18	51,78	0,97
SD/Sederajat	41,68	45,98	0,14
SMP/Sederajat	45,39	47,44	0,80
SMA/Sederajat	42,41	48,27	1,73
Perguruan Tinggi	39,59	50,62	0,75
Sulawesi Utara	41,83	48,80	1,01

Lanjutan Tabel 2.9

Karakteristik	Klinik/Praktik dokter bersama	Puskesmas	Lainnya
(1)	(5)	(6)	(7)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	0,92	4,33	–
Perdesaan	4,57	11,86	0,06
Jenis Kelamin			
Laki-laki	1,54	8,37	–
Perempuan	3,13	7,14	0,04
Kelompok Umur			
0-4 tahun	4,37	3,03	–
0-17 tahun	1,24	8,57	0,26
18-59 tahun	3,11	8,46	–
60+ tahun	0,62	6,53	–
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	2,25	6,76	–
SD/Sederajat	3,85	9,51	0,16
SMP/Sederajat	1,70	7,07	–
SMA/Sederajat	1,02	8,47	–
Perguruan Tinggi	6,70	5,27	–
Sulawesi Utara	2,51	7,62	0,03

Tabel 2.10 Persentase Penduduk Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota, 2023

No.	Kabupaten/Kota	Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan	Memiliki Jaminan Kesehatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bolaang Mongondow	31,56	68,44
2	Minahasa	14,08	85,92
3	Kepulauan Sangihe	15,92	84,08
4	Kepulauan Talaud	21,54	78,46
5	Minahasa Selatan	26,93	73,07
6	Minahasa Utara	13,19	86,81
7	Bolaang Mongondow Utara	29,36	70,64
8	Siau Tagulandang Biaro	31,77	68,23
9	Minahasa Tenggara	29,30	70,70
10	Bolaang Mongondow Selatan	19,26	80,74
11	Bolaang Mongondow Timur	12,52	87,48
12	Manado	12,40	87,60
13	Bitung	9,64	90,36
14	Tomohon	8,84	91,16
15	Kotamobagu	24,79	75,21
Sulawesi Utara		18,56	81,44

Tabel 2.11 Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jaminan Kesehatan yang Dimiliki, 2023

No.	Kabupaten/Kota	BPJS PBI	BPJS Non-PBI	Jamkesda
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bolaang Mongondow	40,87	26,55	NA
2	Minahasa	45,30	39,55	NA
3	Kepulauan Sangihe	65,08	18,92	–
4	Kepulauan Talaud	52,19	25,59	NA
5	Minahasa Selatan	43,49	28,10	NA
6	Minahasa Utara	48,66	34,62	–
7	Bolaang Mongondow Utara	54,21	15,98	–
8	Siau Tagulandang Biaro	37,90	28,71	1,65
9	Minahasa Tenggara	38,65	26,67	5,62
10	Bolaang Mongondow Selatan	70,90	8,89	NA
11	Bolaang Mongondow Timur	59,05	20,83	9,08
12	Manado	39,08	41,93	–
13	Bitung	64,47	23,12	NA
14	Tomohon	56,86	30,97	NA
15	Kotamobagu	38,23	35,60	–
Sulawesi Utara		47,94	30,71	0,62

Lanjutan Tabel 2.11

No.	Kabupaten/Kota	Asuransi Swasta	Perusahaan/ Kantor	Tidak Menggunakan
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)
1	Bolaang Mongondow	NA	NA	31,56
2	Minahasa	NA	1,03	14,08
3	Kepulauan Sangihe	—	NA	15,92
4	Kepulauan Talaud	—	NA	21,54
5	Minahasa Selatan	NA	NA	26,93
6	Minahasa Utara	1,33	3,69	13,19
7	Bolaang Mongondow Utara	—	NA	29,36
8	Siau Tagulandang Biaro	—	—	31,77
9	Minahasa Tenggara	NA	0,48	29,30
10	Bolaang Mongondow Selatan	NA	NA	19,26
11	Bolaang Mongondow Timur	NA	0,80	12,52
12	Manado	NA	6,81	12,40
13	Bitung	NA	2,53	9,64
14	Tomohon	NA	2,81	8,84
15	Kotamobagu	—	1,51	24,79
Sulawesi Utara		0,19	2,30	18,56

Tabel 2.12 Persentase Penduduk Menurut Karakteristik dan Jaminan Kesehatan yang Dimiliki, 2023

Karakteristik	BPJS PBI	BPJS Non-PBI	Jamkesda
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	45,02	37,01	0,14
Perdesaan	51,49	23,05	1,20
Jenis Kelamin			
Laki-laki	48,09	29,81	0,65
Perempuan	47,78	31,65	0,58
Kelompok Umur			
0-4 tahun	21,70	30,68	0,78
0-17 tahun	45,61	28,58	0,68
18-59 tahun	51,25	30,63	0,59
60+ tahun	51,02	34,22	0,55
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	44,03	24,83	0,73
SD/Sederajat	63,41	18,54	0,83
SMP/Sederajat	57,71	23,05	0,66
SMA/Sederajat	43,80	38,33	0,40
Perguruan Tinggi	22,22	65,07	0,43
Sulawesi Utara	47,94	30,71	0,62

Lanjutan Tabel 2.12

Karakteristik	Asuransi Swasta	Perusahaan/Kantor	Tidak Punya
(1)	(5)	(6)	(7)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	0,25	3,51	14,39
Perdesaan	0,11	0,82	23,63
Jenis Kelamin			
Laki-laki	0,20	2,18	19,38
Perempuan	0,18	2,42	17,70
Kelompok Umur			
0-4 tahun	0,12	2,82	44,04
0-17 tahun	0,20	2,32	22,92
18-59 tahun	0,19	2,65	15,05
60+ tahun	0,20	0,48	13,70
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	0,14	1,79	28,71
SD/Sederajat	NA	0,95	16,26
SMP/Sederajat	NA	1,35	17,57
SMA/Sederajat	0,21	3,64	13,96
Perguruan Tinggi	0,67	4,27	7,94
Sulawesi Utara	0,19	2,30	18,56

Tabel 2.13 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Jaminan Kesehatan yang Dimiliki, 2023

No.	Kabupaten/Kota	Menggunakan			
		BPJS PBI	BPJS Non-PBI	Jamkesda	Perusahaan/ Kantor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bolaang Mongondow	15,17	11,89	—	NA
2	Minahasa	35,66	43,21	—	NA
3	Kepulauan Sangihe	40,14	8,60	—	—
4	Kepulauan Talaud	28,29	9,98	—	—
5	Minahasa Selatan	24,53	23,23	—	—
6	Minahasa Utara	37,60	26,32	—	3,59
7	Bolaang Mongondow Utara	33,07	10,47	—	NA
8	Siau Tagulandang Biaro	29,25	16,13	NA	—
9	Minahasa Tenggara	18,66	13,54	3,79	NA
10	Bolaang Mongondow Selatan	53,18	4,47	—	NA
11	Bolaang Mongondow Timur	32,79	7,29	5,23	—
12	Manado	36,79	29,79	—	8,53
13	Bitung	51,00	25,02	—	NA
14	Tomohon	62,70	22,35	—	—
15	Kotamobagu	33,80	24,63	—	NA
Sulawesi Utara		34,39	22,94	0,35	1,63

Lanjutan Tabel 2.13

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah yang menggunakan	Tidak Menggunakan
(1)	(2)	(7)	(8)
1	Bolaang Mongondow	27,08	72,92
2	Minahasa	79,24	20,76
3	Kepulauan Sangihe	48,74	51,26
4	Kepulauan Talaud	38,28	61,72
5	Minahasa Selatan	47,76	52,24
6	Minahasa Utara	67,52	32,48
7	Bolaang Mongondow Utara	44,16	55,84
8	Siau Tagulandang Biaro	47,81	52,19
9	Minahasa Tenggara	36,27	63,73
10	Bolaang Mongondow Selatan	59,67	40,33
11	Bolaang Mongondow Timur	44,15	55,85
12	Manado	75,10	24,90
13	Bitung	76,46	23,54
14	Tomohon	85,04	14,96
15	Kotamobagu	58,68	41,32
Sulawesi Utara		59,29	40,71

Tabel 2.14 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir menurut Karakteristik dan Jaminan Kesehatan yang Dimiliki, 2023

Karakteristik	Menggunakan			
	BPJS PBI	BPJS Non-PBI	Jamkesda	Perusahaan/ Kantor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	38,00	30,85	NA	2,77
Perdesaan	30,05	13,44	0,72	NA
Jenis Kelamin				
Laki-laki	32,97	23,29	0,20	1,53
Perempuan	35,71	22,62	0,50	1,72
Kelompok Umur				
0-4 tahun	15,08	17,99	NA	NA
0-17 tahun	32,49	21,03	NA	NA
18-59 tahun	39,07	20,16	0,31	2,06
60+ tahun	38,47	32,19	NA	NA
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	29,77	18,11	0,41	1,24
SD/Sederajat	45,78	13,19	NA	NA
SMP/Sederajat	42,07	14,19	NA	NA
SMA/Sederajat	34,35	32,90	NA	1,44
Perguruan Tinggi	14,31	58,52	—	NA
Sulawesi Utara	34,39	22,94	0,35	1,63

Lanjutan Tabel 2.14

Karakteristik	Jumlah yang menggunakan	Tidak Menggunakan
(1)	(6)	(7)
Klasifikasi Desa		
Perkotaan	71,67	28,33
Perdesaan	44,41	55,59
Jenis Kelamin		
Laki-laki	57,99	42,01
Perempuan	60,50	39,50
Kelompok Umur		
0-4 tahun	36,02	63,98
0-17 tahun	54,95	45,05
18-59 tahun	61,56	38,44
60+ tahun	71,78	28,22
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan		
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	49,47	50,53
SD/Sederajat	59,96	40,04
SMP/Sederajat	59,16	40,84
SMA/Sederajat	68,89	31,11
Perguruan Tinggi	77,89	22,11
Sulawesi Utara	59,29	40,71

Tabel 2.15 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan dalam Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota, 2023

No.	Kabupaten/Kota	BPJS PBI	BPJS Non-PBI	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bolaang Mongondow	39,93	36,30	76,23
2	Minahasa	53,87	38,76	92,63
3	Kepulauan Sangihe	81,85	11,44	93,29
4	Kepulauan Talaud	50,15	39,69	89,84
5	Minahasa Selatan	45,38	41,50	86,88
6	Minahasa Utara	41,97	46,92	88,89
7	Bolaang Mongondow Utara	49,09	24,83	73,92
8	Siau Tagulandang Biaro	31,24	35,38	66,62
9	Minahasa Tenggara	38,28	47,97	86,25
10	Bolaang Mongondow Selatan	69,77	22,68	92,45
11	Bolaang Mongondow Timur	54,52	33,76	88,28
12	Manado	52,80	39,39	92,19
13	Bitung	58,96	34,99	93,95
14	Tomohon	57,25	34,18	91,43
15	Kotamobagu	51,75	39,31	91,06
Sulawesi Utara		50,79	37,96	88,75

Tabel 2.16 Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan dalam Setahun Terakhir Menurut Karakteristik, 2023

Karakteristik	BPJS PBI	BPJS Non-PBI	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	48,22	43,29	91,51
Perdesaan	54,11	31,07	85,18
Jenis Kelamin			
Laki-laki	50,75	37,31	88,06
Perempuan	50,81	38,36	89,17
Kelompok Umur			
0-4 tahun	19,82	53,10	72,92
0-17 tahun	47,30	35,67	82,97
18-59 tahun	54,49	34,85	89,34
60+ tahun	54,13	42,06	96,19
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	43,74	39,45	83,19
SD/Sederajat	71,41	17,97	89,38
SMP/Sederajat	62,56	24,28	86,84
SMA/Sederajat	49,07	43,92	92,99
Perguruan Tinggi	19,09	71,99	91,08
Sulawesi Utara	50,79	37,96	88,75

Tabel 2.17 Persentase Penduduk yang Merokok Menggunakan Rokok Elektrik selama Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota, 2023

No.	Kabupaten/Kota	Umur 5 Tahun ke Atas	Umur 15 Tahun ke Atas
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bolaang Mongondow	2,24	2,75
2	Minahasa	0,96	1,12
3	Kepulauan Sangihe	0,81	0,95
4	Kepulauan Talaud	0,83	1,01
5	Minahasa Selatan	0,90	1,06
6	Minahasa Utara	1,59	1,90
7	Bolaang Mongondow Utara	1,46	1,84
8	Siau Tagulandang Biaro	2,23	2,62
9	Minahasa Tenggara	1,12	1,37
10	Bolaang Mongondow Selatan	0,40	0,51
11	Bolaang Mongondow Timur	1,59	1,95
12	Manado	1,45	1,71
13	Bitung	0,95	1,15
14	Tomohon	1,01	1,19
15	Kotamobagu	1,46	1,76
Sulawesi Utara		1,29	1,55

Tabel 2.18 Persentase Penduduk yang Merokok Menggunakan Rokok Elektrik selama Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2023

Karakteristik	Umur 5 Tahun ke Atas	Umur 15 Tahun ke Atas
(1)	(2)	(3)
Klasifikasi Desa		
Perkotaan	1,19	1,42
Perdesaan	1,42	1,71
Jenis Kelamin		
Laki-laki	2,40	2,87
Perempuan	0,15	0,18
Kelompok Umur		
0-4 tahun	—	—
0-17 tahun	0,06	0,25
18-59 tahun	1,83	1,83
60+ tahun	0,79	0,79
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan		
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	0,68	1,69
SD/Sederajat	1,58	1,92
SMP/Sederajat	1,24	1,25
SMA/Sederajat	1,56	1,56
Perguruan Tinggi	1,38	1,38
Sulawesi Utara	1,29	1,55

Tabel 2.19 Persentase Penduduk Umur 5 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Apakah Merokok Tembakau selama Sebulan Terakhir, 2023

No.	Kabupaten/Kota	Ya, Setiap Hari	Ya, Tidak Setiap Hari	Tidak	Tidak Tahu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bolaang Mongondow	20,56	4,77	71,37	3,30
2	Minahasa	18,42	4,13	76,67	0,78
3	Kepulauan Sangihe	16,18	4,10	79,10	0,62
4	Kepulauan Talaud	18,06	3,26	72,35	6,33
5	Minahasa Selatan	21,37	2,90	71,89	3,84
6	Minahasa Utara	16,84	3,50	77,74	1,92
7	Bolaang Mongondow Utara	24,42	3,15	70,38	2,06
8	Siau Tagulandang Biaro	16,69	2,70	78,73	1,88
9	Minahasa Tenggara	21,78	2,74	75,16	0,32
10	Bolaang Mongondow Selatan	24,09	4,28	70,82	0,81
11	Bolaang Mongondow Timur	27,64	2,94	68,64	0,78
12	Manado	15,28	4,25	75,29	5,18
13	Bitung	19,01	3,45	76,93	0,61
14	Tomohon	14,97	3,77	79,83	1,43
15	Kotamobagu	20,31	3,06	72,26	4,37
Sulawesi Utara		18,79	3,74	74,90	2,58

Tabel 2.20 Persentase Penduduk Umur 5 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik dan Apakah Merokok Tembakau selama Sebulan Terakhir, 2023

Karakteristik	Ya, Setiap Hari	Ya, Tidak Setiap Hari	Tidak	Tidak Tahu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Klasifikasi Desa				
Perkotaan	17,63	3,50	75,74	3,13
Perdesaan	20,21	4,03	73,86	1,90
Jenis Kelamin				
Laki-laki	35,53	6,90	55,57	2,00
Perempuan	1,43	0,46	94,93	3,18
Kelompok Umur				
0-4 tahun	—	—	—	—
0-17 tahun	0,53	0,18	95,77	3,52
18-59 tahun	25,63	5,01	66,95	2,41
60+ tahun	16,33	3,53	78,24	1,90
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan				
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	9,53	2,06	85,74	2,67
SD/Sederajat	22,15	4,13	71,37	2,35
SMP/Sederajat	23,08	4,21	70,33	2,37
SMA/Sederajat	22,16	4,71	70,60	2,53
Perguruan Tinggi	13,89	2,78	79,94	3,39
Sulawesi Utara	18,79	3,74	74,90	2,58

Tabel 2.21 *Sampling Error* Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jaminan Kesehatan yang Dimiliki, 2023

Kabupaten/Kota	BPJS PBI				
	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error	Selang Kepercayaan 95 Persen	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bolaang Mongondow	40,87	2,68	6,57	35,61	46,13
Minahasa	45,30	2,40	5,29	40,60	50,00
Kepulauan Sangihe	65,08	2,80	4,30	59,59	70,56
Kepulauan Talaud	52,19	2,48	4,75	47,33	57,06
Minahasa Selatan	43,49	2,33	5,36	38,92	48,06
Minahasa Utara	48,66	2,48	5,09	43,80	53,52
Bolaang Mongondow Utara	54,21	2,51	4,64	49,29	59,14
Siau Tagulandang Biaro	37,90	2,39	6,31	33,21	42,59
Minahasa Tenggara	38,65	2,37	6,12	34,01	43,30
Bolaang Mongondow Selatan	70,90	2,26	3,19	66,47	75,33
Bolaang Mongondow Timur	59,05	2,58	4,37	53,99	64,11
Manado	39,08	2,45	6,27	34,28	43,88
Bitung	64,47	2,29	3,55	59,98	68,95
Tomohon	56,86	2,95	5,18	51,08	62,64
Kotamobagu	38,23	2,49	6,51	33,35	43,11
Sulawesi Utara	47,94	0,76	1,59	46,44	49,43

Lanjutan Tabel 2.21

Kabupaten/Kota	BPJS Non-PBI				
	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error	Selang Kepercayaan 95 Persen	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bolaang Mongondow	26,55	2,60	9,80	21,45	31,66
Minahasa	39,55	2,49	6,30	34,67	44,44
Kepulauan Sangihe	18,92	2,44	12,90	14,14	23,71
Kepulauan Talaud	25,59	2,58	10,07	20,54	30,64
Minahasa Selatan	28,10	2,23	7,93	23,74	32,47
Minahasa Utara	34,62	2,50	7,21	29,72	39,52
Bolaang Mongondow Utara	15,98	2,16	13,51	11,75	20,22
Siau Tagulandang Biaro	28,71	2,23	7,75	24,35	33,07
Minahasa Tenggara	26,67	2,25	8,44	22,26	31,08
Bolaang Mongondow Selatan	8,89	1,47	16,53	6,01	11,77
Bolaang Mongondow Timur	20,83	2,16	10,38	16,59	25,07
Manado	41,93	2,57	6,12	36,89	46,96
Bitung	23,12	2,19	9,48	18,82	27,42
Tomohon	30,97	2,75	8,89	25,57	36,36
Kotamobagu	35,60	2,64	7,40	30,43	40,77
Sulawesi Utara	30,71	0,76	2,49	29,21	32,21

Lanjutan Tabel 2.21

Kabupaten/Kota	Jamkesda				
	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error	Selang Kepercayaan 95 Persen	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bolaang Mongondow	0,04	0,04	100,07	~0	0,11
Minahasa	0,11	0,11	99,94	~0	0,33
Kepulauan Sangihe	–	–	–	–	–
Kepulauan Talaud	0,14	0,09	64,92	~0	0,32
Minahasa Selatan	0,05	0,05	100,10	~0	0,14
Minahasa Utara	–	–	–	–	–
Bolaang Mongondow Utara	–	–	–	–	–
Siau Tagulandang Biaro	1,65	0,53	32,08	0,61	2,69
Minahasa Tenggara	5,62	0,99	17,61	3,68	7,55
Bolaang Mongondow Selatan	0,29	0,26	90,20	~0	0,80
Bolaang Mongondow Timur	9,08	1,38	15,14	6,39	11,78
Manado	–	–	–	–	–
Bitung	0,23	0,21	89,75	~0	0,64
Tomohon	0,37	0,21	56,53	~0	0,77
Kotamobagu	–	–	–	–	–
Sulawesi Utara	0,62	0,07	10,81	0,48	0,75

Lanjutan Tabel 2.21

Kabupaten/Kota	Asuransi Swasta				
	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error	Selang Kepercayaan 95 Persen	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bolaang Mongondow	0,17	0,17	99,61	~0	0,51
Minahasa	0,04	0,04	99,88	~0	0,12
Kepulauan Sangihe	—	—	—	—	—
Kepulauan Talaud	—	—	—	—	—
Minahasa Selatan	0,26	0,18	71,23	~0	0,61
Minahasa Utara	1,33	0,56	41,82	0,24	2,43
Bolaang Mongondow Utara	—	—	—	—	—
Siau Tagulandang Biaro	—	—	—	—	—
Minahasa Tenggara	0,08	0,08	100,11	~0	0,25
Bolaang Mongondow Selatan	0,07	0,07	100,13	~0	0,21
Bolaang Mongondow Timur	0,26	0,22	84,79	~0	0,70
Manado	0,08	0,06	75,78	~0	0,20
Bitung	0,02	0,02	100,17	~0	0,05
Tomohon	0,23	0,13	59,43	~0	0,49
Kotamobagu	—	—	—	—	—
Sulawesi Utara	0,19	0,05	27,89	0,09	0,29

Lanjutan Tabel 2.21

Kabupaten/Kota	Perusahaan/Kantor				
	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error	Selang Kepercayaan 95 Persen	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bolaang Mongondow	0,80	0,46	57,83	~0	1,71
Minahasa	1,03	0,44	42,79	0,17	1,89
Kepulauan Sangihe	0,08	0,08	100,09	~0	0,25
Kepulauan Talaud	0,53	0,36	68,10	~0	1,25
Minahasa Selatan	1,18	0,66	56,01	~0	2,47
Minahasa Utara	3,69	1,18	31,95	1,38	6,00
Bolaang Mongondow Utara	0,44	0,26	58,38	~0	0,95
Siau Tagulandang Biaro	—	—	—	—	—
Minahasa Tenggara	0,48	0,23	48,52	0,02	0,94
Bolaang Mongondow Selatan	0,61	0,42	67,70	~0	1,43
Bolaang Mongondow Timur	0,80	0,31	38,44	0,20	1,41
Manado	6,81	1,17	17,12	4,52	9,09
Bitung	2,53	0,66	26,17	1,23	3,83
Tomohon	2,81	0,99	35,13	0,87	4,74
Kotamobagu	1,51	0,39	25,59	0,75	2,27
Sulawesi Utara	2,30	0,26	11,12	1,79	2,80

Lanjutan Tabel 2.21

Kabupaten/Kota	Asuransi Swasta				
	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error	Selang Kepercayaan 95 Persen	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bolaang Mongondow	31,56	2,50	7,92	26,66	36,46
Minahasa	14,08	1,55	10,99	11,05	17,12
Kepulauan Sangihe	15,92	2,28	14,31	11,45	20,38
Kepulauan Talaud	21,54	1,74	8,09	18,13	24,96
Minahasa Selatan	26,93	1,99	7,41	23,02	30,84
Minahasa Utara	13,19	1,52	11,50	10,22	16,16
Bolaang Mongondow Utara	29,36	2,20	7,48	25,06	33,66
Siau Tagulandang Biaro	31,77	2,13	6,70	27,60	35,95
Minahasa Tenggara	29,30	2,51	8,58	24,37	34,22
Bolaang Mongondow Selatan	19,26	1,86	9,68	15,61	22,91
Bolaang Mongondow Timur	12,52	1,61	12,87	9,36	15,68
Manado	12,40	1,40	11,30	9,65	15,14
Bitung	9,64	1,15	11,97	7,38	11,90
Tomohon	8,84	1,59	18,03	5,72	11,97
Kotamobagu	24,79	2,27	9,17	20,33	29,25
Sulawesi Utara	18,56	0,55	2,94	17,49	19,63

Tabel 2.22 *Sampling Error* Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir menurut Kabupaten/Kota dan Jaminan Kesehatan yang Dimiliki, 2023

Kabupaten/Kota	BPJS PBI				
	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error	Selang Kepercayaan 95 Persen	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bolaang Mongondow	15,17	3,54	23,37	8,22	22,12
Minahasa	35,66	4,69	13,15	26,47	44,86
Kepulauan Sangihe	40,14	5,88	14,65	28,61	51,68
Kepulauan Talaud	28,29	5,38	19,01	17,74	38,84
Minahasa Selatan	24,53	5,14	20,94	14,45	34,60
Minahasa Utara	37,60	4,97	13,22	27,85	47,35
Bolaang Mongondow Utara	33,07	4,54	13,73	24,17	41,98
Siau Tagulandang Biaro	29,25	6,17	21,11	17,15	41,36
Minahasa Tenggara	18,66	3,44	18,44	11,92	25,41
Bolaang Mongondow Selatan	53,18	8,70	16,37	36,11	70,25
Bolaang Mongondow Timur	32,79	6,83	20,84	19,39	46,18
Manado	36,79	5,38	14,62	26,24	47,33
Bitung	51,00	6,37	12,49	38,51	63,49
Tomohon	62,70	5,47	8,73	51,96	73,43
Kotamobagu	33,80	6,54	19,34	20,98	46,61
Sulawesi Utara	34,39	1,58	4,58	31,30	37,48

Lanjutan Tabel 2.22

Kabupaten/Kota	BPJS Non-PBI				
	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error	Selang Kepercayaan 95 Persen	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bolaang Mongondow	11,89	3,49	29,35	5,05	18,74
Minahasa	43,21	5,69	13,16	32,05	54,36
Kepulauan Sangihe	8,60	3,11	36,19	2,50	14,70
Kepulauan Talaud	9,98	4,70	47,04	0,77	19,19
Minahasa Selatan	23,23	4,45	19,14	14,51	31,95
Minahasa Utara	26,32	4,66	17,71	17,18	35,46
Bolaang Mongondow Utara	10,47	2,83	27,01	4,92	16,02
Siau Tagulandang Biaro	16,13	4,87	30,21	6,57	25,68
Minahasa Tenggara	13,54	3,16	23,30	7,35	19,73
Bolaang Mongondow Selatan	4,47	2,62	58,58	~0	9,61
Bolaang Mongondow Timur	7,29	2,63	36,08	2,13	12,45
Manado	29,79	5,20	17,44	19,60	39,98
Bitung	25,02	6,07	24,26	13,12	36,93
Tomohon	22,35	4,72	21,12	13,09	31,60
Kotamobagu	24,63	5,15	20,91	14,53	34,74
Sulawesi Utara	22,94	1,54	6,72	19,92	25,97

Lanjutan Tabel 2.22

Kabupaten/Kota	Jamkesda				
	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error	Selang Kepercayaan 95 Persen	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bolaang Mongondow	—	NA	NA	—	—
Minahasa	—	NA	NA	—	—
Kepulauan Sangihe	—	NA	NA	—	—
Kepulauan Talaud	—	NA	NA	—	—
Minahasa Selatan	—	NA	NA	—	—
Minahasa Utara	—	NA	NA	—	—
Bolaang Mongondow Utara	—	NA	NA	—	—
Siau Tagulandang Biaro	2,43	1,88	77,15	~0	6,11
Minahasa Tenggara	3,79	1,82	48,20	0,21	7,36
Bolaang Mongondow Selatan	—	NA	NA	—	—
Bolaang Mongondow Timur	5,23	2,57	49,14	0,19	10,26
Manado	—	NA	NA	—	—
Bitung	—	NA	NA	—	—
Tomohon	—	NA	NA	—	—
Kotamobagu	—	NA	NA	—	—
Sulawesi Utara	0,35	0,12	33,22	0,12	0,58

Lanjutan Tabel 2.22

Kabupaten/Kota	Perusahaan/Kantor				
	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error	Selang Kepercayaan 95 Persen	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bolaang Mongondow	0,02	0,02	100,63	~0	0,05
Minahasa	0,37	0,37	100,32	~0	1,09
Kepulauan Sangihe	—	—	—	—	—
Kepulauan Talaud	—	—	—	—	—
Minahasa Selatan	—	—	—	—	—
Minahasa Utara	3,59	1,78	49,62	0,10	7,09
Bolaang Mongondow Utara	0,62	0,44	71,89	~0	1,49
Siau Tagulandang Biaro	—	—	—	—	—
Minahasa Tenggara	0,28	0,28	100,40	~0	0,82
Bolaang Mongondow Selatan	2,03	2,02	99,72	~0	5,99
Bolaang Mongondow Timur	—	—	—	—	—
Manado	8,53	3,46	40,57	1,74	15,31
Bitung	0,40	0,29	73,04	~0	0,97
Tomohon	—	—	—	—	—
Kotamobagu	0,25	0,25	100,69	~0	0,74
Sulawesi Utara	1,63	0,49	30,41	0,66	2,60

Lanjutan Tabel 2.22

Kabupaten/Kota	Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan				
	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error	Selang Kepercayaan 95 Persen	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bolaang Mongondow	72,92	4,59	6,30	63,91	81,93
Minahasa	20,76	4,63	22,32	11,67	29,85
Kepulauan Sangihe	51,26	6,15	12,00	39,19	63,32
Kepulauan Talaud	61,72	6,26	10,15	49,44	74,01
Minahasa Selatan	52,24	6,03	11,55	40,41	64,07
Minahasa Utara	32,48	4,85	14,93	22,97	41,99
Bolaang Mongondow Utara	55,84	5,21	9,34	45,62	66,07
Siau Tagulandang Biaro	52,19	6,25	11,97	39,94	64,44
Minahasa Tenggara	63,73	4,83	7,59	54,25	73,22
Bolaang Mongondow Selatan	40,33	9,08	22,51	22,52	58,13
Bolaang Mongondow Timur	55,85	7,80	13,97	40,54	71,15
Manado	24,90	4,56	18,31	15,96	33,84
Bitung	23,54	5,55	23,57	12,66	34,41
Tomohon	14,96	3,79	25,32	7,53	22,39
Kotamobagu	41,32	6,15	14,88	29,27	53,38
Sulawesi Utara	40,71	1,66	4,08	37,45	43,96

Catatan :

- Jika *Relative Standard Error* >25% tetapi ≤50%, estimasi harus digunakan dengan hati-hati.
- Jika *Relative Standard Error* >50%, estimasi dianggap tidak akurat.

Tabel 2.23 *Sampling Error* Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir Menggunakan Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota, 2023

Kabupaten/Kota	BPJS PBI				
	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error	Selang Kepercayaan 95 Persen	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bolaang Mongondow	39,93	7,53	18,86	25,15	54,71
Minahasa	53,87	6,08	11,28	41,94	65,79
Kepulauan Sangihe	81,85	6,14	7,51	69,80	93,91
Kepulauan Talaud	50,15	9,96	19,85	30,62	69,68
Minahasa Selatan	45,38	6,40	14,10	32,83	57,94
Minahasa Utara	41,97	5,52	13,16	31,13	52,80
Bolaang Mongondow Utara	49,09	9,19	18,72	31,06	67,13
Siau Tagulandang Biaro	31,24	7,24	23,17	17,04	45,44
Minahasa Tenggara	38,28	6,83	17,83	24,89	51,68
Bolaang Mongondow Selatan	69,77	10,06	14,42	50,03	89,51
Bolaang Mongondow Timur	54,52	6,64	12,19	41,48	67,55
Manado	52,80	6,70	12,68	39,66	65,94
Bitung	58,96	5,65	9,59	47,87	70,04
Tomohon	57,25	8,52	14,88	40,54	73,97
Kotamobagu	51,75	6,54	12,64	38,92	64,59
Sulawesi Utara	50,79	2,05	4,04	46,76	54,82

Lanjutan Tabel 2.23

Kabupaten/Kota	BPJS Non-PBI				
	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error	Selang Kepercayaan 95 Persen	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bolaang Mongondow	36,30	8,35	23,01	19,92	52,69
Minahasa	38,76	5,36	13,82	28,25	49,27
Kepulauan Sangihe	11,44	4,98	43,55	1,67	21,21
Kepulauan Talaud	39,69	10,66	26,85	18,78	60,61
Minahasa Selatan	41,50	6,24	15,04	29,26	53,75
Minahasa Utara	46,92	5,73	12,22	35,67	58,17
Bolaang Mongondow Utara	24,83	8,76	35,26	7,65	42,02
Siau Tagulandang Biaro	35,38	7,85	22,18	19,98	50,78
Minahasa Tenggara	47,97	6,99	14,57	34,26	61,68
Bolaang Mongondow Selatan	22,68	10,09	44,49	2,88	42,49
Bolaang Mongondow Timur	33,76	6,60	19,57	20,80	46,71
Manado	39,39	6,68	16,95	26,29	52,49
Bitung	34,99	5,50	15,71	24,20	45,78
Tomohon	34,18	8,17	23,89	18,16	50,20
Kotamobagu	39,31	6,48	16,47	26,61	52,02
Sulawesi Utara	37,96	1,99	5,25	34,04	41,87

Catatan :

- Jika *Relative Standard Error* >25% tetapi ≤50%, estimasi harus digunakan dengan hati-hati.
- Jika *Relative Standard Error* >50%, estimasi dianggap tidak akurat.

BAB 3

KESEHATAN ANAK: INVESTASI MENUJU SULUT HEBAT



**STATISTIK KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA
2023**

BAB 3

KESEHATAN ANAK: INVESTASI MENUJU SULUT HEBAT

Anak merupakan generasi penerus pembangunan suatu wilayah. Untuk keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan mutu anak yang baik. Salah satu kualitas sumber daya manusia adalah di bidang kesehatan. Dengan demikian, untuk mewujudkan keberlanjutan Sulut Hebat diperlukan investasi kesehatan anak. Kesehatan adalah investasi yang utama dan berharga dengan manfaat yang bertahan lama. Anak sebagai generasi penerus diharapkan memiliki kondisi kesehatan yang baik sehingga dapat menjadi motor penggerak pembangunan Sulawesi Utara menuju Sulut Hebat.

Kesehatan berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak yang sehat akan lebih mudah menerima rangsangan yang mendukung perkembangan motorik, intelektual, dan emosional. Sebaliknya, penurunan kondisi kesehatan anak akan menyulitkan mereka dalam menerima stimulus perkembangan. Selain itu, anak yang sakit juga dapat mengganggu aktivitas orang tua sehingga rutinitas rumah tangga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Misalnya, pekerjaan rumah tangga tidak dapat diselesaikan secara optimal, orang tua tidak dapat bekerja/mencari penghasilan, atau bahkan anggota keluarga yang lain turut terganggu kesehatannya karena harus mengurus anak yang sakit. Untuk menjaga anak tetap sehat diperlukan asupan gizi yang cukup. Gizi yang baik juga dapat mempercepat kesembuhan anak. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini, khususnya tumbuh kembang fisik, sangat dipengaruhi oleh nutrisi dari makanan dan minuman sehari-hari. Anak dengan asupan gizi yang baik tentunya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik juga. Bab III publikasi ini menyajikan gambaran kondisi kesehatan anak dan balita di Sulawesi Utara, di antaranya terkait keluhan kesehatan dan angka kesakitan pada anak, upaya kesehatan yang dilakukan pada anak-anak, jaminan kesehatan yang dimiliki, imunisasi, pemberian Air Susu Ibu (ASI) dan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) pada Baduta.

3.1 Gambaran Kesehatan Anak Sulawesi Utara

Kesehatan berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak yang sehat akan lebih mudah menerima rangsangan yang mendukung perkembangan motorik, intelektual, dan emosional. Indikator kesehatan penting yang dapat menggambarkan kondisi kesehatan balita dan anak di Sulawesi Utara, di antaranya adalah kondisi keluhan kesehatan serta angka kesakitan.



Berdasarkan data Susenas Maret 2023, sebanyak 25,45 persen anak umur 0-17 tahun mengalami keluhan kesehatan. Angka keluhan kesehatan pada anak umur 0-17 tahun di daerah perkotaan dan daerah perdesaan cenderung sama, dimana untuk daerah perkotaan sebesar 25,29 persen dan untuk daerah perdesaan sebesar 25,63 persen (Tabel 3.2). Berdasarkan kelompok umur, angka keluhan kesehatan pada anak semakin menurun seiring bertambahnya umur anak (Tabel 3.2). Keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya kegiatan sehari-hari disebut juga dengan angka kesakitan (morbiditas). Semakin tinggi morbiditas, menunjukkan derajat kesehatan penduduk semakin buruk. Sebaliknya semakin rendah morbiditas menunjukkan derajat kesehatan penduduk yang semakin baik. Angka kesakitan pada anak di Sulawesi Utara tahun 2023 adalah sebesar 13,58 persen (Tabel 3.5). Kabupaten Minahasa Selatan memiliki persentase angka kesakitan anak tertinggi (17,38 persen). Persentase anak di daerah perkotaan yang mengalami keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir dan terganggu kehidupan sehari-harinya lebih rendah bila dibandingkan dengan di wilayah perdesaan, namun jika dibandingkan menurut jenis kelamin tidak berbeda signifikan (Gambar 3.1).

Pada tahun 2023, persentase anak umur 0-17 tahun yang mempunyai keluhan kesehatan dan pernah mengobati sendiri dalam sebulan terakhir sebesar 67,46 persen (Tabel 3.9). Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat 6-7 dari 100 anak berumur 0-17 tahun yang mempunyai keluhan kesehatan dan pernah mengobati sendiri dalam sebulan terakhir. Dilihat dari klasifikasi desa, angka mengobati sendiri untuk daerah perkotaan sebesar 69,92 persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan perdesaan yang sebesar 64,65 persen (Tabel 3.9). Tabel 3.9 juga menunjukkan bahwa persentase anak laki-laki yang mempunyai keluhan kesehatan dan pernah mengobati sendiri sedikit lebih rendah dibandingkan anak perempuan. Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, angka mengobati sendiri paling rendah terdapat pada kelompok umur 0-4 tahun dan meningkat seiring dengan bertambahnya usia.

Salah satu pelayanan kesehatan yang diakses ketika anak mempunyai keluhan kesehatan adalah pelayanan rawat jalan. Pada tahun 2023, ada sekitar 43-44 dari 100 anak umur 0-17 tahun yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir dan pernah rawat jalan (Tabel 3.9). Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi kabupaten/kota dengan persentase tertinggi anak yang mempunyai keluhan kesehatan dan rawat jalan yaitu sebesar 74,14 persen. Sedangkan persentase terendah berada di kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu hanya sebesar 23,08 persen (Tabel 3.9).

Tabel 3.10 juga menunjukkan bahwa daerah perkotaan justru memiliki angka rawat jalan pada anak yang lebih rendah bila dibandingkan dengan daerah perdesaan, yaitu 42,10 persen di perkotaan dan 45,25 persen di perdesaan. Selanjutnya, jika dilihat berdasarkan kelompok umur, persentase anak yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir dan pernah rawat jalan paling tinggi terdapat pada kelompok umur 16-17 tahun, yaitu sebesar 41,15 persen (Tabel 3.10). Berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan kepala rumah tangga, persentase anak yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir dan pernah rawat jalan paling tinggi terdapat pada kelompok rumah tangga yang kepala rumah tangganya memiliki tingkat pendidikan terakhir perguruan tinggi, yaitu sebesar 47,49 persen (Tabel 3.10).

Selain rawat jalan, upaya kesehatan yang dilakukan adalah membawa anak yang memiliki keluhan kesehatan untuk menjalani rawat inap. Pada tingkat keparahan yang tinggi, pemantauan intensif dari tenaga kesehatan dilakukan melalui pelayanan rawat inap. Pada tahun 2023 persentase anak umur 0-17 tahun yang pernah rawat inap sebesar 3,18 persen. Persentase anak yang pernah rawat inap dalam setahun terakhir di daerah perkotaan sebesar 3,46 persen, lebih tinggi dibandingkan di daerah perdesaan yang sebesar 2,86 persen (Tabel 3.10). Sedangkan menurut kelompok umur, persentase anak yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir dan pernah rawat inap paling tinggi terdapat pada kelompok umur 0-4 tahun, yaitu sebesar 5,50 persen

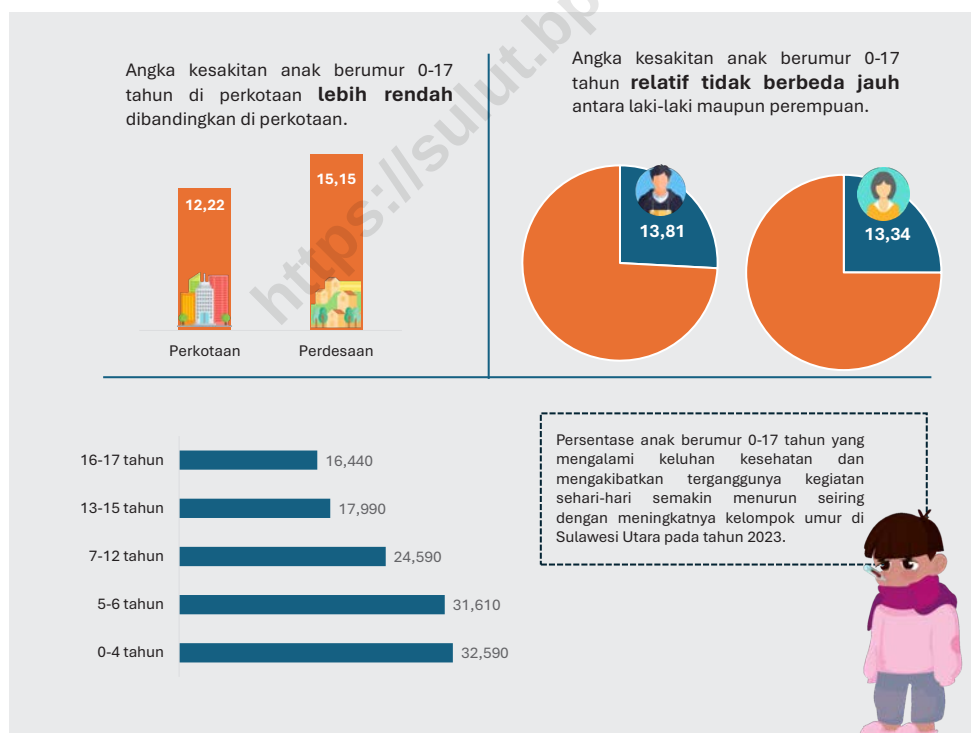
Angka keluhan kesehatan pada balita adalah sebesar 32,59 persen merupakan yang tertinggi diantara kelompok umur anak lainnya. Tabel 3.4 menunjukkan bahwa keluhan kesehatan lebih banyak dialami oleh balita di daerah perdesaan (34,53 persen) bila dibandingkan dengan perkotaan (30,86 persen). Keluhan kesehatan juga lebih banyak dialami oleh balita berjenis kelamin laki-laki (33,16 persen) bila dibandingkan dengan balita perempuan (32,01 persen). Pada tahun 2023, balita yang mempunyai keluhan kesehatan dan mengakibatkan terganggunya kegiatan sehari-hari sebanyak 18,57 persen (Tabel 3.7). Wilayah perkotaan memiliki persentase yang lebih rendah dibandingkan dengan perdesaan (Tabel 3.8).

Pada saat anak sakit, apalagi sampai mengakibatkan terganggunya kegiatan sehari-hari, orang tua atau orang dewasa yang tinggal bersama dengan anak tersebut melakukan beragam upaya mulai dari mengobati sendiri hingga membawa anak tersebut ke fasilitas kesehatan. Angka mengobati sendiri pada balita sebesar 58,45 persen. Kota Tomohon memiliki persentase angka mengobati sendiri pada balita yang tertinggi yaitu 85,27 persen sedangkan kabupaten Bolaang Mongondow menduduki peringkat terbawah yaitu sebesar 27,36 persen.

Persentase mengobati sendiri di daerah perkotaan sebesar 63,37 persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan perdesaan yang mencapai 53,53 persen (Tabel 3.11). Persentase balita dengan jenis kelamin laki-laki yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir dan mengobati sendiri lebih rendah dibandingkan dengan balita perempuan, yaitu 56,05 persen untuk balita laki-laki dan 60,98 persen pada balita perempuan.

Angka rawat jalan pada balita sebesar 56,61 persen. Berdasarkan klasifikasi desa, angka rawat jalan juga lebih rendah di perkotaan (52,43 persen) bila dibandingkan dengan perdesaan (60,80 persen). Balita dengan jenis kelamin laki-laki lebih tinggi persentasenya (58,24 persen) bila dibandingkan dengan balita perempuan (54,91 persen).

Sebanyak 5-6 dari 100 balita pernah rawat inap dalam setahun terakhir. Angka rawat inap balita hampir tidak ada perbedaan antara di daerah perkotaan (5,53 persen) dan perdesaan (5,46 persen). Begitu juga jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase balita laki-laki yang pernah rawat inap hampir tidak ada perbedaan (5,34 persen) bila dibandingkan balita perempuan (5,65 persen).



Gambar 3.1 Angka Kesakitan Anak Berumur 0–17 Tahun di Sulawesi Utara Menurut Karakteristik, 2023

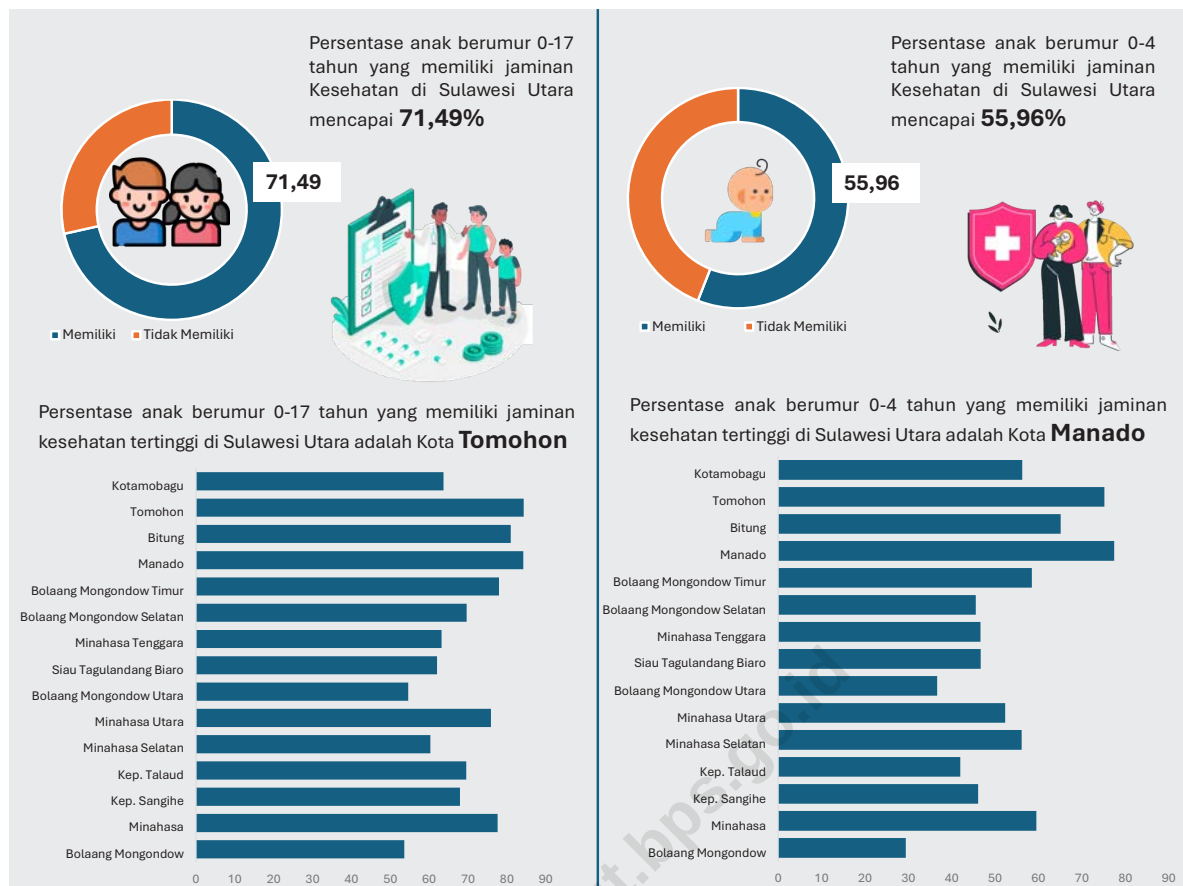
3.2 Jaminan Kesehatan Anak Sulawesi Utara

Setiap anak memiliki hak yang sama untuk kelangsungan hidup dan mendapatkan akses ke pelayanan kesehatan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah melalui Undang-

undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) memberlakukan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sejak tahun 2014. JKN yang dikembangkan di Indonesia merupakan bagian dari SJSN yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan yang bersifat wajib dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat, termasuk anak-anak, yang layak diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Kepemilikan jaminan kesehatan anak biasanya sangat tergantung pada kepemilikan jaminan kesehatan orang tua ataupun orang dewasa yang tinggal bersamanya. Pada tahun 2023, 71,49 persen atau sekitar 7 dari 10 anak umur 0-17 tahun memiliki jaminan kesehatan (Gambar 3.2). Persentase anak umur 0-17 tahun di Kota Tomohon yang memiliki jaminan kesehatan menduduki peringkat pertama di Sulawesi Utara yaitu sebesar 84,32 persen (Gambar 3.2). Di sisi lain, daerah dengan kepemilikan jaminan kesehatan anak terendah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu sebesar 53,61 persen (Gambar 3.2). Angka kepemilikan jaminan kesehatan pada anak di daerah perkotaan sebesar 78,53 persen, lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan yang sebesar 63,33 persen. Berdasarkan jenis kelamin, angka kepemilikan jaminan kesehatan pada anak laki-laki dan perempuan relatif sama. Sementara itu, berdasarkan kondisi sosial ekonomi lainnya, angka kepemilikan jaminan kesehatan pada anak meningkat seiring meningkatnya kelompok umur.

Jaminan kesehatan juga penting dimiliki oleh anak umur 0-4 tahun atau balita sebagai kelompok umur paling rentan di sebuah populasi. Pada tahun 2023 persentase kepemilikan jaminan kesehatan pada balita sebesar 55,96 persen (Gambar 3.2). Persentase anak umur 0-4 tahun di Kota Manado memiliki jaminan kesehatan paling tinggi di Sulawesi Utara yaitu sebesar 84,32 persen (Gambar 3.2), sedangkan daerah dengan kepemilikan jaminan kesehatan balita terendah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow yaitu sebesar 29,42 persen (Gambar 3.2). Persentase balita yang memiliki jaminan kesehatan di daerah perkotaan sebesar 66,48 persen, lebih tinggi dibandingkan di perdesaan yang sebesar 44,18 persen (Tabel 3.17). Angka kepemilikan jaminan kesehatan pada balita semakin besar seiring dengan meningkatnya pendidikan KRT.



Gambar 3.2 Persentase Kepemilikan Jaminan Kesehatan pada Anak Berumur 0-17 Tahun dan Anak Berumur 0-4 Tahun di Sulawesi Utara Menurut Kabupaten/Kota, 2023

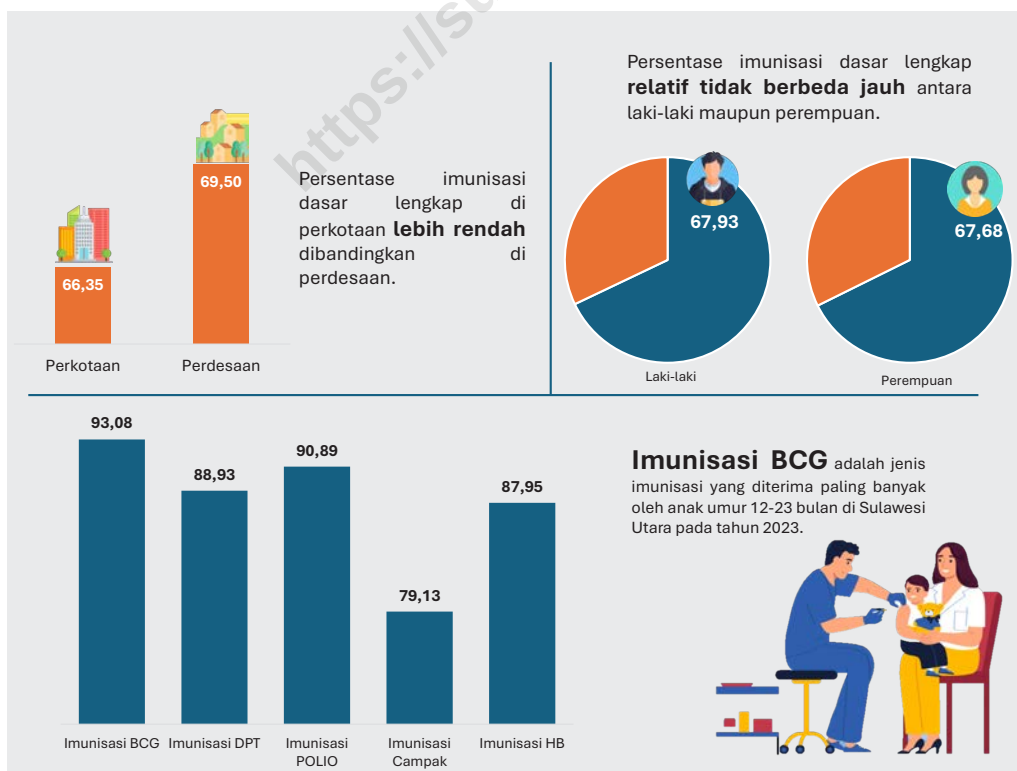
3.3 Imunisasi Adalah Hak Sekaligus Perisai Anak

Imunisasi merupakan salah satu hak anak yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan, bahkan diakui secara internasional melalui Konvensi Hak Anak. Pemerintah Indonesia, melalui Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 132 juga menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan untuk mencegah terjadinya penyakit yang dapat dihindari melalui imunisasi. Program pemerintah memfasilitasi pelayanan imunisasi yang diberikan secara rutin pada bayi dan anak meliputi imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Imunisasi dasar lengkap adalah imunisasi dasar yang diterima setiap bayi/anak umur 12-23 bulan dan meliputi 1 (satu) kali imunisasi BCG, 3 (tiga) kali imunisasi polio, 3 (tiga) kali imunisasi DPT, 3 (tiga) kali imunisasi hepatitis B dan 1 (satu) kali imunisasi campak.

Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap pada tahun 2023 di Sulawesi Utara adalah sebesar 67,80 persen. Daerah perkotaan memiliki persentase yang lebih rendah (66,35 persen) bila dibandingkan perdesaan (69,50 persen). Jika dilihat

menurut jenis kelamin, hampir tidak ada perbedaan antara persentase anak berumur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap di daerah perkotaan (67,93 persen) maupun di daerah perdesaan (67,68 persen).

Persentase imunisasi dasar lengkap tertinggi anak umur 12-23 bulan berada di kabupaten Minahasa Selatan, yaitu sebesar 87,33 persen (Tabel 3.19). Persentase imunisasi dasar lengkap yang terendah di Sulawesi Utara terdapat di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro yaitu sebesar 50,19 persen (Tabel 3.19). Hal tersebut berarti bahwa hanya separuh anak di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro yang menerima imunisasi dasar lengkap. Padahal, pemberian imunisasi dasar lengkap berguna untuk member perlindungan menyeluruh terhadap penyakit-penyakit yang berbahaya. Dengan memberikan imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal, tubuh bayi dirangsang untuk memiliki kekebalan sehingga tubuhnya mampu bertahan melawan serangan penyakit berbahaya. Masih rendahnya capaian persentase imunisasi dasar lengkap yang diterima oleh anak harus diatasi dengan berbagai sinergi baik dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan maupun masyarakat melalui peningkatan kesadaran di kalangan pengasuh tentang pentingnya imunisasi, kemudahan akses ke layanan imunisasi, termasuk di daerah yang sulit dijangkau, dan memperkuat sistem rantai pasokan imunisasi untuk menjaga kualitas dan kemanjuran vaksin.



Gambar 3.3 Persentase Anak Berumur 12–23 Bulan yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap di Sulawesi Utara Menurut Karakteristik, 2023

Jika dilihat menurut jenis imunisasi yang diterima oleh anak umur 12-23 bulan di Sulawesi Utara, imunisasi BCG merupakan imunisasi dengan capaian tertinggi dibandingkan jenis imunisasi lainnya, yaitu sebesar 93,08 persen (Gambar 3.3). Jenis imunisasi yang persentase penerima paling rendah di Sulawesi Utara adalah imunisasi campak, yaitu sebesar 79,13 persen (Gambar 3.3).

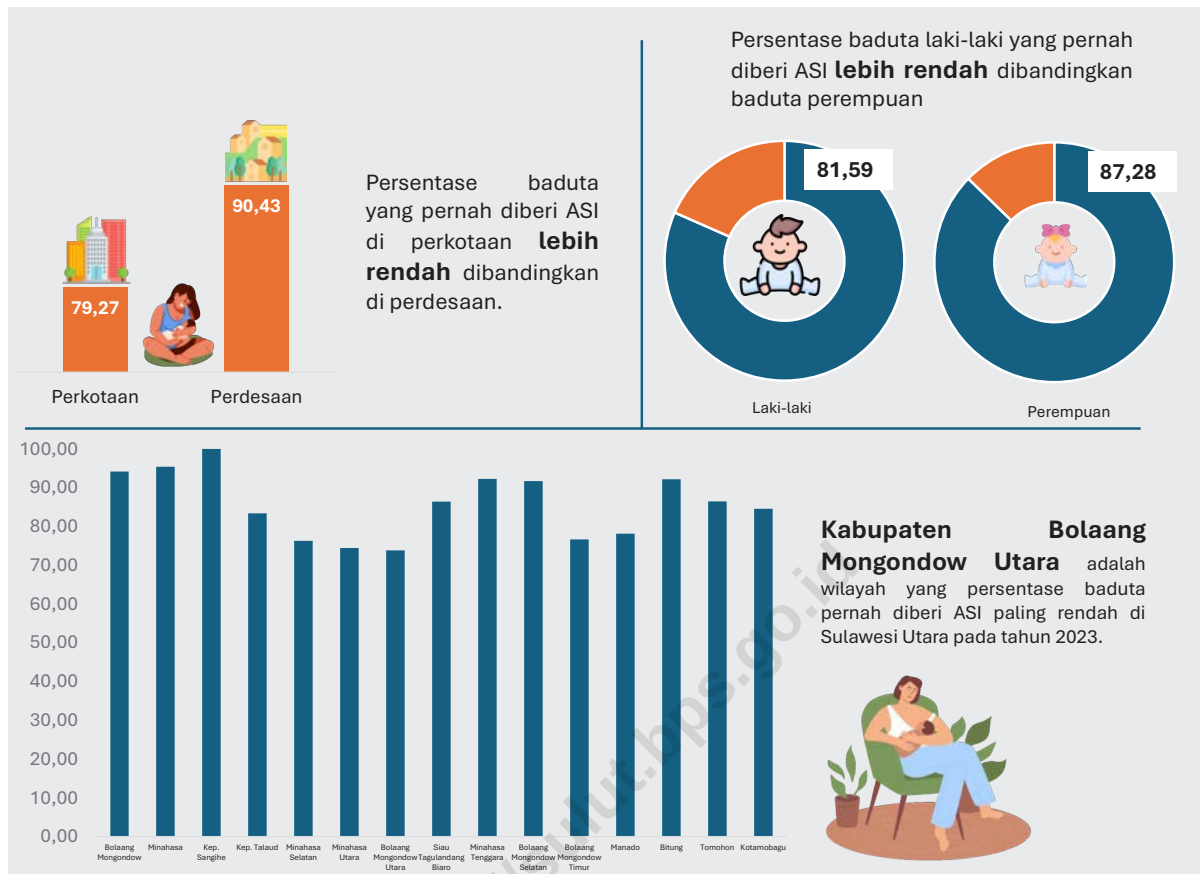
3.4 Menjawab Permasalahan Gizi melalui Pemberian ASI pada Baduta

Stunting dan *wasting* masih menjadi persoalan serius pada anak di Indonesia hingga saat ini. *Stunting* merupakan tanda kekurangan gizi di masa lalu atau kronis dan tidak dapat mengukur perubahan kekurangan gizi dalam jangka pendek. Sementara itu, *wasting* terjadi ketika berat badan seorang anak turun secara signifikan di bawah berat badan yang diharapkan dari seorang anak dengan panjang dan tinggi badan yang sama. *Wasting* menunjukkan kekurangan gizi saat ini atau akut akibat kegagalan untuk menambah berat badan atau penurunan berat badan yang diharapkan. Penyebab utama *wasting* adalah asupan makanan yang tidak memadai, praktik pemberian makan yang tidak tepat, dan infeksi, atau seringkali merupakan kombinasi dari ketiga faktor tersebut. *Wasting*, atau rendahnya berat badan dibandingkan tinggi badan, membantu mengidentifikasi anak-anak yang menderita kekurangan gizi saat ini atau akut. Air Susu Ibu (ASI) merupakan satu-satunya makanan terbaik bagi bayi sebagai sumber nutrisi yang paling sesuai dan memiliki komposisi gizi yang paling lengkap yang berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi. Manfaat ASI eksklusif begitu besar sehingga dapat mencegah bayi menderita *wasting* dan juga *stunting*. Mengingat begitu penting dan banyaknya manfaat ASI, WHO merekomendasikan pemberian ASI harus dimulai pada jam pertama kelahiran, bayi harus diberikan ASI eksklusif selama enam bulan pertama dan terus menyusui hingga usia dua tahun atau lebih.

Pada tahun 2023, persentase anak berumur kurang dari 2 tahun (baduta) yang pernah diberi ASI di Sulawesi Utara mencapai 84,54 persen. Kabupaten Kepulauan Talaud memiliki persentase pemberian ASI pada baduta paling tinggi, sedangkan kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah kabupaten dengan pemberian ASI pada baduta paling rendah (Gambar 3.4).

Berdasarkan klasifikasi desa, baduta di daerah perdesaan lebih banyak menerima ASI dibandingkan baduta yang ada di daerah perkotaan. Lebih tingginya pemberian ASI pada baduta di daerah perdesaan jika dibandingkan dengan perkotaan ini sejalan dengan penelitian dari Paramashanti dkk (2022) yang menyatakan bahwa ibu di perkotaan mempunyai pengetahuan dan persepsi yang lebih baik tentang menyusui serta lebih banyak akses terhadap sumber

informasi menyusui. Namun praktik pemberian ASI eksklusif lebih sering dilakukan oleh ibu-ibu di pedesaan.

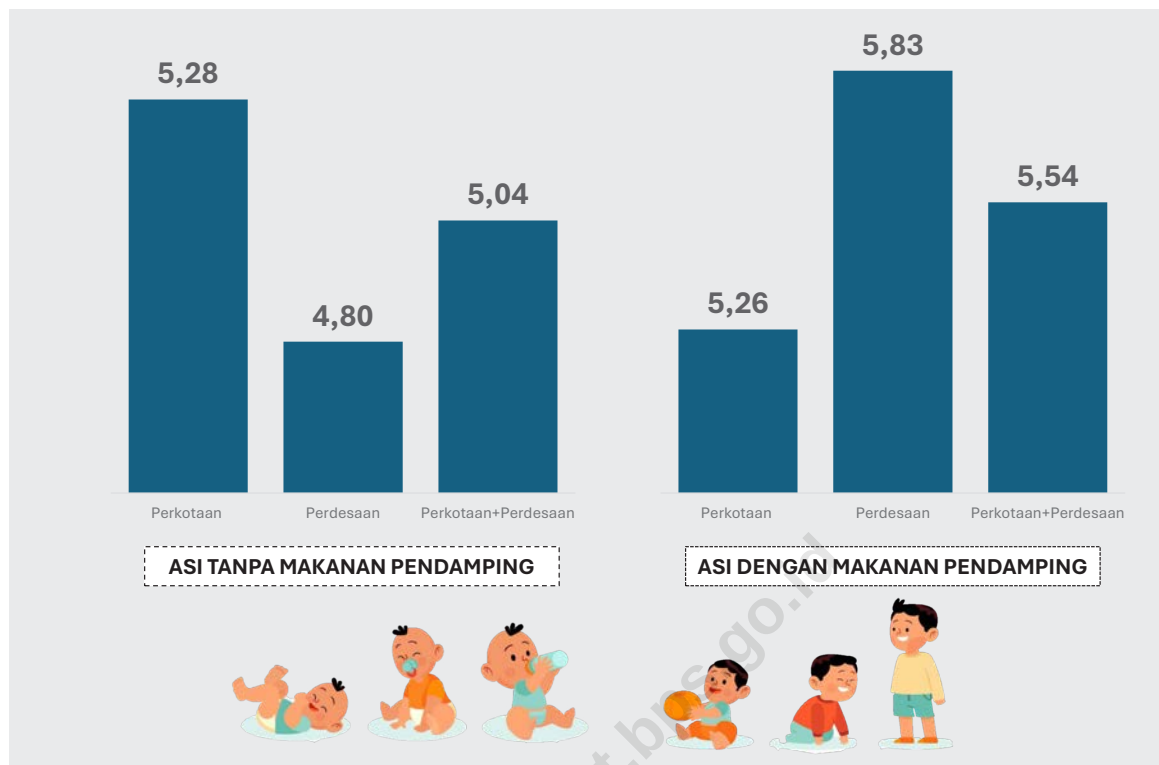


Gambar 3.4 Persentase Baduta yang Pernah Diberi ASI di Sulawesi Utara Menurut Karakteristik, 2023

Pola dan lama pemberian ASI memberikan pengaruh yang sangat positif pada kondisi kesehatan dan proses tumbuh kembang balita secara optimal. Tingkat kecerdasan anak dipengaruhi oleh kualitas makanan yang diberikan pada saat anak berusia balita dan lamanya pemberian ASI. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2023, terlihat bahwa rata-rata lama pemberian ASI anak baduta di Sulawesi Utara sudah mencapai 10 bulan (Tabel 3.25). Di sisi lain, rata-rata lama pemberian ASI di daerah perkotaan hampir tidak ada perbedaan dibandingkan di daerah pedesaan. Begitu juga jika dibandingkan menurut jenis kelamin.

Pemerintah menganjurkan agar seorang ibu dapat memberikan ASI eksklusif kepada bayi sejak dilahirkan sampai 6 bulan ke depan, tanpa menambahkan atau mengganti dengan makanan/minuman lain. Pemberian ASI eksklusif dipercaya karena mempunyai manfaat yang sangat besar baik bagi ibu sebagai suatu bentuk wujud kasih sayang, maupun bagi bayi untuk kesehatannya. Selanjutnya setelah bayi berumur 6 bulan ke atas dapat dilanjutkan pemberian makanan tambahan bersama dengan ASI hingga umur 2 tahun. Pemberian makanan tambahan

tersebut diharapkan dapat mendukung pertumbuhan bayi dan memenuhi kebutuhan gizi sesuai dengan perkembangan dan usianya.



Gambar 3.5 Rata-rata Lama Pemberian ASI Tanpa Makanan Pendamping dan ASI dengan Makanan Pendamping (Bulan) Anak Berumur Kurang dari 2 Tahun (Baduta) menurut Klasifikasi Desa di Sulawesi Utara, 2023

Gambar 3.5 menyajikan rata-rata lama pemberian ASI tanpa makanan pendamping selama 5,04 bulan. Hal ini menunjukkan pola pemberian ASI tanpa makanan pendamping masih belum memenuhi target 6 bulan. Sementara itu, rata-rata pemberian ASI dengan makanan pendamping hanya sekitar 5,54 bulan. Rata-rata lama pemberian ASI tanpa makanan pendamping dan ASI dengan makanan pendamping menunjukkan pola yang berbeda untuk penduduk perkotaan dan perdesaan.

Tabel 3.1 Persentase Penduduk Umur 0–17 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2023

No.	Kabupaten/Kota	Mempunyai Keluhan Kesehatan
(1)	(2)	(3)
1	Bolaang Mongondow	20,30
2	Minahasa	32,70
3	Kepulauan Sangihe	23,13
4	Kepulauan Talaud	25,76
5	Minahasa Selatan	27,98
6	Minahasa Utara	31,61
7	Bolaang Mongondow Utara	23,06
8	Siau Tagulandang Biaro	14,85
9	Minahasa Tenggara	29,87
10	Bolaang Mongondow Selatan	23,34
11	Bolaang Mongondow Timur	29,21
12	Manado	20,80
13	Bitung	23,83
14	Tomohon	27,16
15	Kotamobagu	26,46
Sulawesi Utara		25,45

Tabel 3.2 Persentase Penduduk Umur 0–17 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik di Sulawesi Utara, 2023

Karakteristik	Mempunyai Keluhan Kesehatan
(1)	(2)
Klasifikasi Desa	
Perkotaan	25,29
Perdesaan	25,63
Jenis Kelamin	
Laki-laki	25,85
Perempuan	25,03
Kelompok Umur	32,59
0-4 Tahun	31,61
5-6 Tahun	24,59
7-12 Tahun	17,99
13-15 Tahun	16,44
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan KRT	
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	23,28
SD/Sederajat	24,84
SMP/Sederajat	25,46
SMA/Sederajat	25,22
Perguruan Tinggi	29,08
Sulawesi Utara	25,45

Tabel 3.3 Persentase Penduduk Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2023

No.	Kabupaten/Kota	Mempunyai Keluhan Kesehatan
(1)	(2)	(3)
1	Bolaang Mongondow	24,68
2	Minahasa	35,69
3	Kepulauan Sangihe	26,63
4	Kepulauan Talaud	36,51
5	Minahasa Selatan	41,88
6	Minahasa Utara	41,33
7	Bolaang Mongondow Utara	25,29
8	Siau Tagulandang Biaro	17,47
9	Minahasa Tenggara	47,18
10	Bolaang Mongondow Selatan	33,56
11	Bolaang Mongondow Timur	39,70
12	Manado	27,10
13	Bitung	28,42
14	Tomohon	32,54
15	Kotamobagu	35,84
Sulawesi Utara		32,59

Tabel 3.4 Persentase Penduduk Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik di Sulawesi Utara, 2023

Karakteristik	Mempunyai Keluhan Kesehatan
(1)	(2)
Klasifikasi Desa	
Perkotaan	30,86
Perdesaan	34,53
Jenis Kelamin	
Laki-laki	33,16
Perempuan	32,01
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	29,81
SD/Sederajat	32,28
SMP/Sederajat	34,08
SMA/Sederajat	32,03
Perguruan Tinggi	34,44
Sulawesi Utara	32,59

Tabel 3.5 Persentase Penduduk Umur 0–17 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2023

No.	Kabupaten/Kota	Angka Morbiditas
(1)	(2)	(3)
1	Bolaang Mongondow	12,30
2	Minahasa	14,69
3	Kepulauan Sangihe	16,98
4	Kepulauan Talaud	11,35
5	Minahasa Selatan	17,38
6	Minahasa Utara	15,21
7	Bolaang Mongondow Utara	11,12
8	Siau Tagulandang Biaro	NA
9	Minahasa Tenggara	15,14
10	Bolaang Mongondow Selatan	17,21
11	Bolaang Mongondow Timur	16,64
12	Manado	9,16
13	Bitung	16,41
14	Tomohon	13,69
15	Kotamobagu	12,02
Sulawesi Utara		13,58

Tabel 3.6 Persentase Penduduk Umur 0–17 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari Menurut Karakteristik di Sulawesi Utara, 2023

Karakteristik	Angka Morbiditas
(1)	(2)
Klasifikasi Desa	
Perkotaan	12,22
Perdesaan	15,15
Jenis Kelamin	
Laki-laki	13,81
Perempuan	13,34
Kelompok Umur	
0-4 Tahun	18,57
5-6 Tahun	19,13
7-12 Tahun	12,26
13-15 Tahun	7,82
16-17 Tahun	8,89
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan KRT	
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	12,57
SD/Sederajat	13,77
SMP/Sederajat	14,55
SMA/Sederajat	12,89
Perguruan Tinggi	14,25
Sulawesi Utara	13,58

Tabel 3.7 Persentase Penduduk Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2023

No.	Kabupaten/Kota	Angka Morbiditas
(1)	(2)	(3)
1	Bolaang Mongondow	19,69
2	Minahasa	19,94
3	Kepulauan Sangihe	18,72
4	Kepulauan Talaud	17,12
5	Minahasa Selatan	32,84
6	Minahasa Utara	22,13
7	Bolaang Mongondow Utara	15,39
8	Siau Tagulandang Biaro	5,11
9	Minahasa Tenggara	18,81
10	Bolaang Mongondow Selatan	24,55
11	Bolaang Mongondow Timur	23,82
12	Manado	10,06
13	Bitung	16,98
14	Tomohon	17,71
15	Kotamobagu	18,08
Sulawesi Utara		18,57

Tabel 3.8 Persentase Penduduk Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari Menurut Karakteristik di Sulawesi Utara, 2023

Karakteristik	Angka Morbiditas
(1)	(2)
Klasifikasi Desa	
Perkotaan	14,62
Perdesaan	23,00
Jenis Kelamin	
Laki-laki	19,57
Perempuan	17,56
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	17,67
SD/Sederajat	17,01
SMP/Sederajat	21,63
SMA/Sederajat	19,13
Perguruan Tinggi	15,38
Sulawesi Utara	18,57

Tabel 3.9 Persentase Penduduk Umur 0–17 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Upaya Perawatan di Sulawesi Utara, 2023

No.	Kabupaten/Kota	Jenis Upaya Perawatan		
		Pernah Mengobati Sendiri	Pernah Rawat Jalan	Pernah Rawat Inap
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bolaang Mongondow	43,46	55,95	2,01
2	Minahasa	79,65	34,08	3,55
3	Kepulauan Sangihe	52,59	74,14	2,07
4	Kepulauan Talaud	70,93	36,14	1,28
5	Minahasa Selatan	69,99	41,14	3,22
6	Minahasa Utara	54,03	55,95	7,27
7	Bolaang Mongondow Utara	73,20	51,51	2,46
8	Siau Tagulandang Biaro	59,11	47,42	1,59
9	Minahasa Tenggara	62,88	47,50	3,24
10	Bolaang Mongondow Selatan	78,22	23,08	0,70
11	Bolaang Mongondow Timur	81,15	25,38	2,84
12	Manado	76,99	34,86	3,48
13	Bitung	53,67	57,11	2,77
14	Tomohon	85,31	37,25	2,39
15	Kotamobagu	73,65	32,35	4,22
Sulawesi Utara		67,46	43,57	3,18

Tabel 3.10 Persentase Penduduk Umur 0–17 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari Menurut Karakteristik dan Jenis Upaya Perawatan di Sulawesi Utara, 2023

Karakteristik	Jenis Upaya Perawatan		
	Pernah Mengobati Sendiri	Pernah Rawat Jalan	Pernah Rawat Inap
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	69,92	42,10	3,46
Perdesaan	64,65	45,25	2,86
Jenis Kelamin			
Laki-laki	66,71	43,76	3,19
Perempuan	68,27	43,37	3,17
Kelompok Umur			
0-4 Tahun	58,45	56,61	5,50
5-6 Tahun	67,91	40,95	2,43
7-12 Tahun	72,24	36,99	2,01
13-15 Tahun	77,71	29,14	1,68
16-17 Tahun	70,34	41,15	4,24
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan KRT			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	72,18	42,09	4,17
SD/Sederajat	65,47	42,24	2,36
SMP/Sederajat	65,16	46,16	3,04
SMA/Sederajat	68,65	41,58	3,26
Perguruan Tinggi	68,22	47,49	3,89
Sulawesi Utara	67,46	43,57	3,18

Tabel 3.11 Persentase Penduduk Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Upaya Perawatan di Sulawesi Utara, 2023

No.	Kabupaten/Kota	Jenis Upaya Perawatan		
		Pernah Mengobati Sendiri	Pernah Rawat Jalan	Pernah Rawat Inap
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bolaang Mongondow	27,36	75,98	NA
2	Minahasa	66,83	50,82	7,05
3	Kepulauan Sangihe	42,36	88,38	NA
4	Kepulauan Talaud	60,04	47,76	NA
5	Minahasa Selatan	55,18	60,97	6,14
6	Minahasa Utara	35,16	78,22	17,92
7	Bolaang Mongondow Utara	71,14	67,19	3,65
8	Siau Tagulandang Biaro	50,62	45,72	3,27
9	Minahasa Tenggara	63,09	54,14	8,24
10	Bolaang Mongondow Selatan	75,02	33,92	NA
11	Bolaang Mongondow Timur	74,52	36,17	NA
12	Manado	69,59	42,07	NA
13	Bitung	57,47	64,90	4,33
14	Tomohon	85,27	46,32	NA
15	Kotamobagu	63,94	41,41	5,06
Sulawesi Utara		58,45	56,61	5,50

Tabel 3.12 Persentase Penduduk Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari Menurut Karakteristik dan Jenis Upaya Perawatan di Sulawesi Utara, 2023

Karakteristik	Jenis Upaya Perawatan		
	Pernah Mengobati Sendiri	Pernah Rawat Jalan	Pernah Rawat Inap
(1)	(2)	(3)	(4)
Klasifikasi Desa			
Perkotaan	63,37	52,43	5,53
Perdesaan	53,53	60,80	5,46
Jenis Kelamin			
Laki-laki	56,05	58,24	5,34
Perempuan	60,98	54,91	5,65
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan KRT			
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	52,03	56,19	7,62
SD/Sederajat	61,74	49,39	4,14
SMP/Sederajat	55,26	61,61	5,08
SMA/Sederajat	57,85	58,98	5,82
Perguruan Tinggi	64,00	54,55	6,08
Sulawesi Utara	58,45	56,61	5,50

Tabel 3.13 Persentase Penduduk Umur 0–17 Tahun yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2023

No.	Kabupaten/Kota	Kepemilikan Jaminan Kesehatan
(1)	(2)	(3)
1	Bolaang Mongondow	53,61
2	Minahasa	77,62
3	Kepulauan Sangihe	67,96
4	Kepulauan Talaud	69,55
5	Minahasa Selatan	60,34
6	Minahasa Utara	75,92
7	Bolaang Mongondow Utara	54,61
8	Siau Tagulandang Biaro	62,05
9	Minahasa Tenggara	63,18
10	Bolaang Mongondow Selatan	69,65
11	Bolaang Mongondow Timur	77,96
12	Manado	84,26
13	Bitung	81,02
14	Tomohon	84,32
15	Kotamobagu	63,72
Sulawesi Utara		71,49

Tabel 3.14 Persentase Penduduk Umur 0–17 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari Menurut Karakteristik dan Jenis Upaya Perawatan di Sulawesi Utara, 2023

Karakteristik	Pernah Mengobati Sendiri
(1)	(2)
Klasifikasi Desa	
Perkotaan	78,53
Perdesaan	63,33
Jenis Kelamin	
Laki-laki	71,45
Perempuan	71,55
Kelompok Umur	
0-4 Tahun	55,96
5-6 Tahun	63,60
7-12 Tahun	75,89
13-15 Tahun	83,99
16-17 Tahun	83,78
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan KRT	
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	64,15
SD/Sederajat	62,28
SMP/Sederajat	67,17
SMA/Sederajat	75,71
Perguruan Tinggi	89,94
Sulawesi Utara	71,49

Tabel 3.15 Persentase Penduduk Umur 0–4 Tahun yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2023

No.	Kabupaten/Kota	Kepemilikan Jaminan Kesehatan
(1)	(2)	(3)
1	Bolaang Mongondow	29,42
2	Minahasa	59,52
3	Kepulauan Sangihe	46,11
4	Kepulauan Talaud	42,00
5	Minahasa Selatan	56,12
6	Minahasa Utara	52,33
7	Bolaang Mongondow Utara	36,67
8	Siau Tagulandang Biaro	46,70
9	Minahasa Tenggara	46,63
10	Bolaang Mongondow Selatan	45,58
11	Bolaang Mongondow Timur	58,50
12	Manado	77,45
13	Bitung	65,15
14	Tomohon	75,20
15	Kotamobagu	56,26
Sulawesi Utara		55,56

Tabel 3.16 Persentase Penduduk Umur 0–4 Tahun yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Karakteristik di Sulawesi Utara, 2023

Karakteristik	Kepemilikan Jaminan Kesehatan
(1)	(2)
Klasifikasi Desa	
Perkotaan	66,48
Perdesaan	44,18
Jenis Kelamin	
Laki-laki	56,08
Perempuan	55,83
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan KRT	
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	36,85
SD/Sederajat	41,80
SMP/Sederajat	46,45
SMA/Sederajat	66,85
Perguruan Tinggi	80,49
Sulawesi Utara	55,96

Tabel 3.17 Persentase Anak Umur 12–23 Bulan yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2023

No.	Kabupaten/Kota	Persentase Menerima Imunisasi Dasar Lengkap
(1)	(2)	(3)
1	Bolaang Mongondow	64,12
2	Minahasa	61,12
3	Kepulauan Sangihe	78,73
4	Kepulauan Talaud	79,90
5	Minahasa Selatan	87,33
6	Minahasa Utara	66,80
7	Bolaang Mongondow Utara	64,02
8	Siau Tagulandang Biaro	50,19
9	Minahasa Tenggara	62,61
10	Bolaang Mongondow Selatan	65,04
11	Bolaang Mongondow Timur	80,50
12	Manado	63,63
13	Bitung	55,02
14	Tomohon	73,51
15	Kotamobagu	86,37
Sulawesi Utara		67,80

Tabel 3.18 Persentase Anak Umur 12–23 Bulan yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Karakteristik di Sulawesi Utara, 2023

Karakteristik	Persentase Menerima Imunisasi Dasar Lengkap
(1)	(2)
Klasifikasi Desa	
Perkotaan	66,35
Perdesaan	69,50
Jenis Kelamin	
Laki-laki	67,93
Perempuan	67,68
Kelompok Umur	
0-4 Tahun	71,83
5-6 Tahun	55,66
7-12 Tahun	69,49
13-15 Tahun	68,41
16-17 Tahun	81,42
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan KRT	
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	66,35
SD/Sederajat	69,50
SMP/Sederajat	67,80
SMA/Sederajat	67,93
Perguruan Tinggi	67,68
Sulawesi Utara	67,80

Tabel 3.19 Persentase Anak Umur 12–23 Bulan yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Jenis Imunisasi yang Diterima dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2023

No.	Kabupaten/Kota	Imunisasi BCG	Imunisasi DPT	Imunisasi Polio	Imunisasi Campak	Imunisasi HB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bolaang Mongondow	91,32	79,60	85,12	70,19	84,63
2	Minahasa	100,00	89,86	100,00	78,92	89,86
3	Kepulauan Sangihe	96,00	91,97	96,00	91,97	91,97
4	Kepulauan Talaud	81,79	90,41	90,41	87,40	90,41
5	Minahasa Selatan	99,32	91,11	100,00	88,00	91,11
6	Minahasa Utara	92,79	90,50	92,79	71,34	92,79
7	Bolaang Mongondow Utara	95,53	86,83	95,53	83,76	91,01
8	Siau Tagulandang Biaro	72,54	89,82	91,53	67,39	91,53
9	Minahasa Tenggara	78,89	78,89	78,89	66,40	78,89
10	Bolaang Mongondow Selatan	88,00	88,55	90,88	73,78	86,87
11	Bolaang Mongondow Timur	91,50	91,50	90,23	88,23	90,23
12	Manado	96,52	90,26	84,50	85,32	82,44
13	Bitung	97,24	97,24	94,58	74,88	91,53
14	Tomohon	89,21	89,21	89,21	73,51	89,21
15	Kotamobagu	86,37	86,37	86,37	86,37	86,37
	Sulawesi Utara	93,08	88,93	90,89	79,13	87,95

Tabel 3.20 Persentase Anak Umur 12–23 Bulan yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Jenis Imunisasi yang Diterima dan Karakteristik di Sulawesi Utara, 2023

Karakteristik	Imunisasi BCG	Imunisasi DPT	Imunisasi Polio	Imunisasi Campak	Imunisasi HB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Klasifikasi Desa					
Perkotaan	94,64	90,59	90,49	81,81	87,33
Perdesaan	91,24	86,97	91,37	75,99	88,67
Jenis Kelamin					
Laki-laki	91,77	90,71	89,29	80,48	87,38
Perempuan	94,26	87,33	92,33	77,92	88,46
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan KRT					
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	95,08	93,05	94,29	82,08	89,27
SD/Sederajat	88,86	87,40	88,51	66,66	87,73
SMP/Sederajat	92,55	79,64	86,98	78,64	80,54
SMA/Sederajat	94,03	92,27	94,92	85,31	92,68
Perguruan Tinggi	97,63	97,63	89,84	85,05	89,84
Sulawesi Utara	93,08	88,93	90,89	79,13	87,95

Tabel 3.21 Persentase Anak Umur 0–23 Bulan yang Pernah Diberi ASI Menurut Kabupaten/ Kota di Sulawesi Utara, 2023

No.	Kabupaten/Kota	Persentase Pernah Diberi ASI
(1)	(2)	(3)
1	Bolaang Mongondow	94,16
2	Minahasa	95,39
3	Kepulauan Sangihe	100,00
4	Kepulauan Talaud	83,36
5	Minahasa Selatan	76,31
6	Minahasa Utara	74,45
7	Bolaang Mongondow Utara	73,81
8	Siau Tagulandang Biaro	86,43
9	Minahasa Tenggara	92,26
10	Bolaang Mongondow Selatan	92,67
11	Bolaang Mongondow Timur	91,69
12	Manado	76,65
13	Bitung	78,13
14	Tomohon	92,15
15	Kotamobagu	86,45
Sulawesi Utara		84,54

Tabel 3.22 Persentase Anak Umur 0–23 Bulan yang Pernah Diberi ASI Menurut Karakteristik di Sulawesi Utara, 2023

Karakteristik	Imunisasi BCG
(1)	(2)
Klasifikasi Desa	
Perkotaan	79,27
Perdesaan	90,43
Jenis Kelamin	
Laki-laki	81,59
Perempuan	87,28
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan KRT	
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	98,55
SD/Sederajat	79,71
SMP/Sederajat	84,77
SMA/Sederajat	83,31
Perguruan Tinggi	83,73
Sulawesi Utara	84,54

Tabel 3.23 Rata-rata Lama Pernah Diberi ASI Anak Umur 0–23 Bulan Menurut Karakteristik di Sulawesi Utara, 2023

Karakteristik	Imunisasi BCG
(1)	(2)
Klasifikasi Desa	
Perkotaan	10,54
Perdesaan	10,63
Jenis Kelamin	
Laki-laki	10,87
Perempuan	10,33
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan KRT	
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	9,54
SD/Sederajat	9,94
SMP/Sederajat	11,54
SMA/Sederajat	10,60
Perguruan Tinggi	10,96
Sulawesi Utara	10,58

Tabel 3.24 *Sampling Error* Persentase Anak Umur 0–17 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota, 2023

Karakteristik	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error	Selang Kepercayaan 95 Persen	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bolaang Mongondow	20,30	2,36	11,61	15,68	24,92
Minahasa	32,70	3,35	10,24	26,14	39,27
Kepulauan Sangihe	23,13	2,80	12,09	17,65	28,61
Kepulauan Talaud	25,76	2,87	11,13	20,14	31,38
Minahasa Selatan	27,98	3,07	10,98	21,96	34,00
Minahasa Utara	31,61	3,18	10,06	25,38	37,85
Bolaang Mongondow Utara	23,06	2,57	11,13	18,03	28,09
Siau Tagulandang Biaro	14,85	2,31	15,54	10,32	19,37
Minahasa Tenggara	29,87	2,78	9,29	24,43	35,31
Bolaang Mongondow Selatan	23,34	2,36	10,10	18,72	27,95
Bolaang Mongondow Timur	29,21	3,77	12,90	21,82	36,59
Manado	20,80	2,27	10,89	16,36	25,24
Bitung	23,83	2,88	12,07	18,19	29,47
Tomohon	27,16	3,20	11,79	20,88	33,43
Kotamobagu	26,46	2,49	9,43	21,57	31,35
Sulawesi Utara	25,45	0,83	3,27	23,82	27,08

Tabel 3.25 *Sampling Error* Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota, 2023

Karakteristik	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error	Selang Kepercayaan 95 Persen	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bolaang Mongondow	24,68	4,15	16,81	16,54	32,81
Minahasa	35,69	6,20	17,36	23,53	47,84
Kepulauan Sangihe	26,63	5,66	21,27	15,52	37,73
Kepulauan Talaud	36,51	5,23	14,31	26,26	46,76
Minahasa Selatan	41,88	6,72	16,04	28,70	55,06
Minahasa Utara	41,33	5,87	14,20	29,82	52,84
Bolaang Mongondow Utara	25,29	4,56	18,01	16,35	34,22
Siau Tagulandang Biaro	17,47	4,36	24,95	8,92	26,03
Minahasa Tenggara	47,18	5,51	11,68	36,37	57,99
Bolaang Mongondow Selatan	33,56	4,98	14,85	23,79	43,34
Bolaang Mongondow Timur	39,70	5,90	14,86	28,13	51,27
Manado	27,10	4,77	17,61	17,74	36,46
Bitung	28,42	5,12	18,00	18,39	38,46
Tomohon	32,54	6,07	18,66	20,63	44,44
Kotamobagu	35,84	4,84	13,51	26,34	45,33
Sulawesi Utara	32,59	1,60	4,92	29,45	35,73

Tabel 3.26 *Sampling Error* Persentase Anak Umur 0–17 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2023

Karakteristik	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error	Selang Kepercayaan 95 Persen	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bolaang Mongondow	12,30	1,78	14,44	8,82	15,78
Minahasa	14,69	2,74	18,68	9,31	20,07
Kepulauan Sangihe	16,98	2,51	14,81	12,05	21,91
Kepulauan Talaud	11,35	2,19	19,28	7,06	15,64
Minahasa Selatan	17,38	2,64	15,19	12,20	22,55
Minahasa Utara	15,21	2,39	15,70	10,53	19,90
Bolaang Mongondow Utara	11,12	1,89	17,01	7,41	14,83
Siau Tagulandang Biaro	7,01	1,78	25,40	3,52	10,50
Minahasa Tenggara	15,14	2,10	13,84	11,03	19,25
Bolaang Mongondow Selatan	17,21	2,22	12,92	12,85	21,58
Bolaang Mongondow Timur	16,64	2,63	15,79	11,49	21,80
Manado	9,16	1,41	15,34	6,41	11,91
Bitung	16,41	2,62	15,99	11,27	21,56
Tomohon	13,69	2,49	18,20	8,81	18,58
Kotamobagu	12,02	1,66	13,84	8,76	15,28
Sulawesi Utara	13,58	0,64	4,74	12,31	14,84

Tabel 3.27 *Sampling Error* Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2023

Karakteristik	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error	Selang Kepercayaan 95 Persen	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bolaang Mongondow	19,69	3,93	19,95	11,99	27,40
Minahasa	19,94	5,29	26,51	9,57	30,31
Kepulauan Sangihe	18,72	4,94	26,40	9,03	28,41
Kepulauan Talaud	17,12	4,04	23,59	9,19	25,04
Minahasa Selatan	32,84	6,54	19,91	20,02	45,67
Minahasa Utara	22,13	4,97	22,46	12,38	31,88
Bolaang Mongondow Utara	15,39	3,78	24,56	7,98	22,80
Siau Tagulandang Biaro	NA	2,82	55,29	–	–
Minahasa Tenggara	18,81	4,20	22,32	10,58	27,05
Bolaang Mongondow Selatan	24,55	4,74	19,32	15,25	33,86
Bolaang Mongondow Timur	23,82	4,71	19,79	14,57	33,07
Manado	10,06	2,90	28,79	4,38	15,74
Bitung	16,98	4,17	24,54	8,81	25,15
Tomohon	17,71	4,94	27,88	8,02	27,39
Kotamobagu	18,08	3,88	21,46	10,47	25,69
Sulawesi Utara	18,57	1,31	7,08	15,99	21,15

Tabel 3.28 *Sampling Error* Persentase Anak Umur 0–17 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Mengobati Sendiri Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2023

Karakteristik	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error	Selang Kepercayaan 95 Persen	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bolaang Mongondow	43,46	6,16	14,17	31,38	55,54
Minahasa	79,65	4,47	5,62	70,88	88,43
Kepulauan Sangihe	52,59	7,19	13,68	38,48	66,70
Kepulauan Talaud	70,93	5,45	7,68	60,25	81,62
Minahasa Selatan	69,99	6,06	8,66	58,11	81,88
Minahasa Utara	54,03	6,43	11,90	41,43	66,64
Bolaang Mongondow Utara	73,20	5,03	6,88	63,33	83,08
Siau Tagulandang Biaro	59,11	7,98	13,50	43,45	74,77
Minahasa Tenggara	62,88	5,68	9,03	51,75	74,02
Bolaang Mongondow Selatan	78,22	4,99	6,38	68,43	88,01
Bolaang Mongondow Timur	81,15	5,55	6,84	70,27	92,03
Manado	76,99	4,92	6,38	67,35	86,63
Bitung	53,67	7,29	13,59	39,36	67,98
Tomohon	85,31	4,23	4,96	77,01	93,61
Kotamobagu	73,65	4,79	6,50	64,26	83,04
Sulawesi Utara	67,46	1,76	2,61	64,01	70,92

Tabel 3.29 *Sampling Error* Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Mengobati Sendiri Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2023

Karakteristik	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error	Selang Kepercayaan 95 Persen	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bolaang Mongondow	27,36	8,81	32,20	10,05	44,67
Minahasa	66,83	8,19	12,25	50,74	82,92
Kepulauan Sangihe	42,36	12,67	29,90	17,48	67,25
Kepulauan Talaud	60,04	8,51	14,18	43,32	76,77
Minahasa Selatan	55,18	10,69	19,37	34,18	76,18
Minahasa Utara	35,16	8,66	24,64	18,14	52,17
Bolaang Mongondow Utara	71,14	8,30	11,67	54,82	87,45
Siau Tagulandang Biaro	50,62	13,79	27,24	23,54	77,71
Minahasa Tenggara	63,09	7,60	12,05	48,16	78,02
Bolaang Mongondow Selatan	75,02	7,15	9,54	60,97	89,07
Bolaang Mongondow Timur	74,52	7,50	10,06	59,79	89,25
Manado	69,59	8,57	12,31	52,76	86,42
Bitung	57,47	10,40	18,09	37,05	77,89
Tomohon	85,27	6,33	7,42	72,83	97,70
Kotamobagu	63,94	7,88	12,33	48,45	79,42
Sulawesi Utara	58,45	2,79	4,77	52,98	63,92

Tabel 3.30 *Sampling Error* Persentase Anak Umur 0–17 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2023

Karakteristik	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error	Selang Kepercayaan 95 Persen	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bolaang Mongondow	55,95	6,18	11,05	43,82	68,08
Minahasa	34,08	5,38	15,79	23,53	44,64
Kepulauan Sangihe	74,14	5,62	7,59	63,10	85,17
Kepulauan Talaud	36,14	5,08	14,06	26,17	46,11
Minahasa Selatan	41,14	6,49	15,78	28,40	53,87
Minahasa Utara	55,95	6,32	11,30	43,55	68,35
Bolaang Mongondow Utara	51,51	6,12	11,88	39,50	63,51
Siau Tagulandang Biaro	47,42	8,41	17,74	30,92	63,92
Minahasa Tenggara	47,50	5,66	11,92	36,40	58,61
Bolaang Mongondow Selatan	23,08	4,61	19,99	14,03	32,13
Bolaang Mongondow Timur	25,38	6,15	24,21	13,33	37,43
Manado	34,86	5,80	16,63	23,49	46,23
Bitung	57,11	6,72	11,77	43,92	70,30
Tomohon	37,25	6,29	16,88	24,92	49,58
Kotamobagu	32,35	4,90	15,15	22,73	41,96
Sulawesi Utara	43,57	1,86	4,27	39,93	47,22

Tabel 3.31 *Sampling Error* Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2023

Karakteristik	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error	Selang Kepercayaan 95 Persen	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bolaang Mongondow	75,98	8,50	11,18	59,28	92,67
Minahasa	50,82	8,41	16,55	34,30	67,34
Kepulauan Sangihe	88,38	6,98	7,90	74,66	102,09
Kepulauan Talaud	47,76	8,63	18,08	30,80	64,72
Minahasa Selatan	60,97	9,68	15,87	41,96	79,98
Minahasa Utara	78,22	7,32	9,36	63,83	92,60
Bolaang Mongondow Utara	67,19	10,02	14,91	47,51	86,88
Siau Tagulandang Biaro	45,72	13,54	29,61	19,12	72,31
Minahasa Tenggara	54,14	7,72	14,25	38,98	69,30
Bolaang Mongondow Selatan	33,92	8,02	23,65	18,16	49,67
Bolaang Mongondow Timur	36,17	9,06	25,05	18,37	53,97
Manado	42,07	9,64	22,93	23,12	61,01
Bitung	64,90	9,61	14,80	46,03	83,77
Tomohon	46,32	10,33	22,29	26,03	66,60
Kotamobagu	41,41	7,81	18,85	26,08	56,74
Sulawesi Utara	56,61	2,78	4,90	51,14	62,08

Tabel 3.32 *Sampling Error* Persentase Anak Umur 0–17 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Inap Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2023

Karakteristik	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error	Selang Kepercayaan 95 Persen	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bolaang Mongondow	2,01	0,71	35,23	0,62	3,40
Minahasa	3,55	0,94	26,56	1,70	5,40
Kepulauan Sangihe	2,07	0,68	33,01	0,73	3,41
Kepulauan Talaud	1,28	0,63	48,87	0,05	2,51
Minahasa Selatan	3,22	0,91	28,36	1,43	5,01
Minahasa Utara	7,27	1,80	24,75	3,74	10,79
Bolaang Mongondow Utara	2,46	0,83	33,92	0,82	4,09
Siau Tagulandang Biaro	1,59	0,55	34,49	0,52	2,67
Minahasa Tenggara	3,24	0,79	24,38	1,69	4,80
Bolaang Mongondow Selatan	0,70	0,34	48,29	0,04	1,36
Bolaang Mongondow Timur	2,84	0,80	28,22	1,27	4,41
Manado	3,48	1,05	30,28	1,41	5,54
Bitung	2,77	0,71	25,80	1,37	4,17
Tomohon	2,39	0,78	32,73	0,86	3,92
Kotamobagu	4,22	1,06	25,16	2,14	6,30
Sulawesi Utara	3,18	0,30	9,41	2,60	3,77

Tabel 3.33 *Sampling Error* Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Inap Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2023

Karakteristik	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error	Selang Kepercayaan 95 Persen	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bolaang Mongondow	NA	2,37	51,74	–	–
Minahasa	7,05	2,66	37,72	1,83	12,27
Kepulauan Sangihe	NA	1,46	53,46	–	–
Kepulauan Talaud	NA	2,10	67,97	–	–
Minahasa Selatan	6,14	2,74	44,62	0,77	11,52
Minahasa Utara	17,92	4,95	27,65	8,20	27,64
Bolaang Mongondow Utara	3,65	1,71	46,87	0,29	7,01
Siau Tagulandang Biaro	3,27	1,43	43,87	0,46	6,08
Minahasa Tenggara	8,24	2,58	31,33	3,18	13,31
Bolaang Mongondow Selatan	NA	0,95	70,04	–	–
Bolaang Mongondow Timur	NA	1,59	52,39	–	–
Manado	NA	1,87	73,47	–	–
Bitung	4,33	1,81	41,87	0,77	7,88
Tomohon	NA	1,96	55,29	–	–
Kotamobagu	5,06	2,34	46,37	0,46	9,66
Sulawesi Utara	5,50	0,76	13,89	4,00	6,99

Tabel 3.34 *Sampling Error* Persentase Anak Umur 0–17 Tahun yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2023

Karakteristik	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error	Selang Kepercayaan 95 Persen	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bolaang Mongondow	53,61	3,22	6,01	47,30	59,93
Minahasa	77,62	3,18	4,09	71,39	83,85
Kepulauan Sangihe	67,96	3,81	5,60	60,50	75,43
Kepulauan Talaud	69,55	2,58	3,70	64,50	74,60
Minahasa Selatan	60,34	3,43	5,69	53,61	67,07
Minahasa Utara	75,92	2,64	3,48	70,74	81,10
Bolaang Mongondow Utara	54,61	3,23	5,91	48,28	60,94
Siau Tagulandang Biaro	62,05	3,15	5,08	55,87	68,24
Minahasa Tenggara	63,18	3,32	5,26	56,66	69,69
Bolaang Mongondow Selatan	69,65	2,93	4,21	63,90	75,40
Bolaang Mongondow Timur	77,96	2,80	3,59	72,47	83,45
Manado	84,26	2,10	2,49	80,14	88,37
Bitung	81,02	2,31	2,85	76,49	85,54
Tomohon	84,32	2,71	3,21	79,01	89,63
Kotamobagu	63,72	3,12	4,90	57,60	69,84
Sulawesi Utara	71,49	0,88	1,23	69,78	73,21

Tabel 3.35 *Sampling Error* Persentase Anak Umur 0–4 Tahun yang Memiliki Jaminan Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2023

Karakteristik	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error	Selang Kepercayaan 95 Persen	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bolaang Mongondow	29,42	4,75	16,13	20,11	38,72
Minahasa	59,52	6,38	10,72	47,00	72,04
Kepulauan Sangihe	46,11	6,46	14,02	33,43	58,79
Kepulauan Talaud	42,00	5,43	12,93	31,34	52,65
Minahasa Selatan	56,12	6,60	11,76	43,18	69,07
Minahasa Utara	52,33	5,37	10,26	41,79	62,86
Bolaang Mongondow Utara	36,67	5,58	15,23	25,72	47,62
Siau Tagulandang Biaro	46,70	5,63	12,05	35,66	57,75
Minahasa Tenggara	46,63	5,65	12,12	35,55	57,71
Bolaang Mongondow Selatan	45,58	5,35	11,74	35,08	56,08
Bolaang Mongondow Timur	58,50	5,76	9,84	47,21	69,79
Manado	77,45	4,55	5,87	68,53	86,36
Bitung	65,15	5,03	7,73	55,27	75,02
Tomohon	75,20	4,75	6,31	65,89	84,51
Kotamobagu	56,26	5,20	9,24	46,07	66,46
Sulawesi Utara	55,96	1,68	3,01	52,66	59,26

Tabel 3.36 *Sampling Error* Persentase Anak Umur 12–23 Bulan yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2023

Karakteristik	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error	Selang Kepercayaan 95 Persen	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bolaang Mongondow	64,12	9,88	15,41	44,69	83,55
Minahasa	61,12	13,73	22,46	34,13	88,12
Kepulauan Sangihe	78,73	12,57	15,97	54,01	103,45
Kepulauan Talaud	79,90	8,63	10,81	62,92	96,88
Minahasa Selatan	87,33	8,74	10,00	70,15	104,50
Minahasa Utara	66,80	12,46	18,65	42,31	91,30
Bolaang Mongondow Utara	64,02	10,68	16,68	43,02	85,02
Siau Tagulandang Biaro	50,19	11,36	22,64	27,84	72,53
Minahasa Tenggara	62,61	12,10	19,32	38,82	86,40
Bolaang Mongondow Selatan	65,04	9,13	14,04	47,09	83,00
Bolaang Mongondow Timur	80,50	8,22	10,21	64,34	96,66
Manado	63,63	10,96	17,23	42,07	85,19
Bitung	55,02	10,29	18,70	34,78	75,26
Tomohon	73,51	10,51	14,29	52,85	94,17
Kotamobagu	86,37	6,25	7,24	74,08	98,67
Sulawesi Utara	67,80	3,38	4,99	61,14	74,45

Tabel 3.37 *Sampling Error* Persentase Bayi Umur 0–23 Bulan yang Pernah Diberi ASI Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara, 2023

Karakteristik	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error	Selang Kepercayaan 95 Persen	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bolaang Mongondow	94,16	3,02	3,21	88,22	100,10
Minahasa	95,39	2,76	2,90	89,96	100,82
Kepulauan Sangihe	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kepulauan Talaud	83,36	6,29	7,54	71,01	95,71
Minahasa Selatan	76,31	7,68	10,07	61,22	91,40
Minahasa Utara	74,45	9,58	12,87	55,63	93,26
Bolaang Mongondow Utara	73,81	7,85	10,63	58,40	89,22
Siau Tagulandang Biaro	86,43	5,45	6,31	75,73	97,13
Minahasa Tenggara	92,26	4,24	4,60	83,94	100,59
Bolaang Mongondow Selatan	92,67	3,26	3,52	86,27	99,08
Bolaang Mongondow Timur	91,69	4,04	4,40	83,76	99,62
Manado	76,65	7,91	10,32	61,12	92,19
Bitung	78,13	7,03	9,00	64,33	91,94
Tomohon	92,15	4,74	5,14	82,84	101,45
Kotamobagu	86,45	5,28	6,11	76,07	96,82
Sulawesi Utara	84,54	2,06	2,43	80,49	88,58

BAB 4

MEMBANGUN KESEHATAN IBU SEBAGAI UPAYA CIPTAKAN GENERASI EMAS



**STATISTIK KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA
2023**

BAB 4

MEMBANGUN KESEHATAN IBU SEBAGAI UPAYA CIPTAKAN GENERASI EMAS

Kecerdasan seorang anak diturunkan oleh Ibu. Menurut riset, 20-50 persen kecerdasan anak didominasi berasal dari seorang ibu. Hal ini disebabkan oleh kecerdasan yang terletak pada kromosom x dan ditemukan lebih banyak pada perempuan dibandingkan laki-laki. Ibu yang memiliki asupan gizi cukup sejak mengandung hingga seribu hari pertama anak dilahirkan, akan mempengaruhi kualitas kelahiran. Ketika seorang Ibu dituntut untuk melahirkan anak-anak cerdas untuk menjadi generasi emas, maka penting untuk dipersiapkan Ibu yang sehat. Mengejar ketercapaian RPJMN Tahun 2020-2024, salah satunya pada indikator mengenai Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Neonatal, cakupan persalinan, dan persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK). Pada dasarnya semua berkaitan kuat dengan kesehatan ibu sehingga penting untuk memperhatikan bagaimana perempuan sebagai ibu serta calon ibu saat ini mendapat kesetaraan akses kesehatan.

Seorang ibu yang memiliki asupan gizi yang cukup, menjaga kesehatan sejak masa mengandung janin hingga kelahiran diharapkan dapat mencegah kelahiran bayi stunting. Stunting memberikan berbagai dampak yang akan mempengaruhi kecerdasan itu sendiri, dan tidak hanya kecerdasan atau IQ namun intelegensia juga akan terpengaruh. Kesehatan ibu yang baik juga berdampak pada pencegahan penyakit menular dan tidak menular, serta meminimalisir risiko komplikasi yang bisa mempengaruhi kualitas hidup anak. Selain kesehatan fisik, penting juga untuk menjaga kesehatan mental seorang ibu. Generasi emas akan lahir dari rahim perempuan yang secara mental siap menjadi ibu sehingga dukungan keluarga juga mempengaruhi untuk melahirkan anak sehat generasi cerdas. Perlu untuk menciptakan lingkungan yang harmonis untuk ibu yang sedang mengandung selain asupan gizi yang cukup dan memadai. Kesehatan ibu yang optimal berhubungan langsung dengan kualitas kehidupan anak dan keluarganya. Ibu yang sehat memiliki kemungkinan lebih besar untuk melahirkan anak yang sehat, memberikan perawatan yang baik selama masa awal kehidupan, serta mendukung perkembangan anak secara fisik dan emosional.

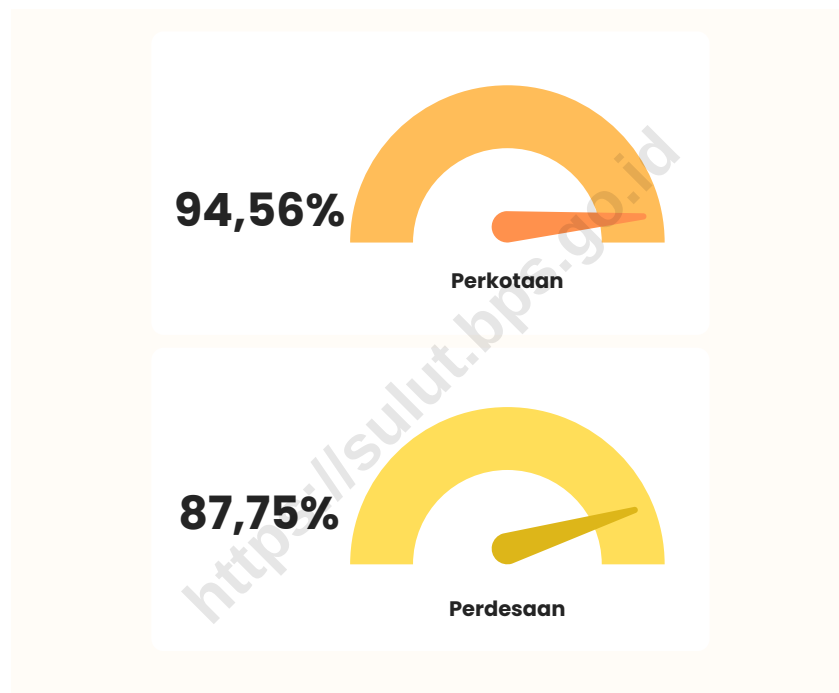
4.1 Umur Perkawinan Pertama Perempuan Usia Subur dan Kesehatan Persalinan Ibu

Umur perkawinan pertama dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan salah satunya yaitu kesehatan reproduksi bagi perempuan. Umur perkawinan pada usia yang sangat muda dapat meningkatkan berbagai resiko kesehatan misalnya pada masa kehamilan yang tidak ideal, kelahiran prematur, bayi dengan berat badan lahir rendah, dan sebagainya. Hal tersebut terkait dengan kesiapan organ reproduksi yaitu disebabkan oleh kondisi tubuh yang belum matang secara fisik dibandingkan ketika umur perkawinan pada usia perempuan yang lebih tua.

Di Provinsi Sulawesi Utara, rata-rata perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun melakukan perkawinan pertama pada umur 21 tahun (Tabel 4.1). Rata-rata umur perkawinan pertama perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun di daerah perkotaan adalah 22 tahun. Sementara di daerah perdesaan rata-rata umur perkawinan pertama pada perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun lebih rendah dibandingkan perkotaan, yaitu umur 21 tahun (Tabel 4.2). Dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan maka rata-rata umur perkawinan pertama pada perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun juga semakin tinggi. Begitupun sebaliknya, semakin rendah pendidikan yang ditamatkan maka rata-rata umur perkawinan pertama pada perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun juga semakin rendah (Tabel 4.2). Pada level kabupaten/kota di Sulawesi Utara, rata-rata umur perkawinan pertama perempuan pernah kawin 15-49 tahun tertinggi yaitu di Kota Tomohon dan terendah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, masing-masing berada pada umur 22 tahun dan 20 tahun.

Rata-rata umur kehamilan pertama perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah hamil di Provinsi Sulawesi Utara adalah 22 tahun (Tabel 4.3). Di perkotaan, rata-rata umur kehamilan pertama pada perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah hamil adalah 22 tahun. Sementara itu, rata-rata umur kehamilan pertama pada perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah hamil di perdesaan lebih rendah, yaitu 21 tahun (Tabel 4.4). Kabupaten/kota dengan rata-rata umur kehamilan pertama perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah hamil tertinggi adalah Kota Tomohon dan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro yaitu 22 tahun, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Bolaang Mongondow Selatan yaitu 20 tahun (Tabel 4.3). Rata-rata tertinggi umur kehamilan pertama terdapat pada perempuan yang saat ini berusia 45-49 tahun.

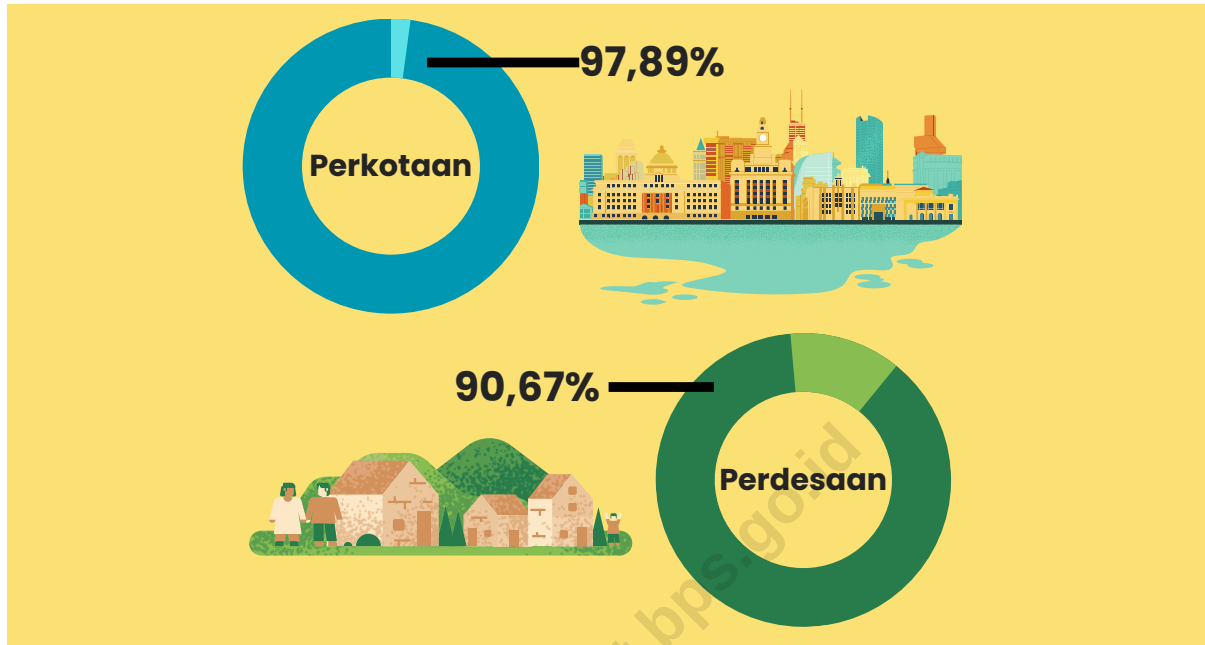
Proses persalinan menjadi hal yang paling penting dan krusial bagi ibu dan anak. Adanya fasilitas kesehatan yang memadai, memungkinkan pemantauan intensif terhadap kondisi ibu dan bayi dalam kandungan selama masa persalinan maupun pasca persalinan. Selain itu, dukungan profesional oleh tenaga kesehatan juga merupakan hal yang tidak kalah penting. Persalinan tanpa bantuan tenaga kesehatan dapat meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi karena adanya kemungkinan timbul permasalahan seperti pendarahan, infeksi, dan komplikasi persalinan sehingga membutuhkan penanganan secara profesional. Di Provinsi Sulawesi Utara, persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir dan anak lahir hidup yang terakhir dilahirkan di Fasilitas Kesehatan pada tahun 2023 sebesar 91,39 persen.



Gambar 4.1 Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Lahir Hidup yang Terakhir Dilahirkan di Fasilitas Kesehatan Menurut Karakteristik Wilayah, 2023

Dilihat berdasarkan karakteristik wilayah, di perkotaan 94,56 persen perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir, melahirkan anak lahir hidup yang terakhir di fasilitas kesehatan. Sementara itu di perdesaan, persentasenya baru mencapai 87,75 persen (Gambar 4.1). Hampir seluruh perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir di wilayah perkotaan seperti Kota Manado dan Kota Tomohon melahirkan anak lahir hidup yang terakhir di fasilitas kesehatan. Sementara itu, di Kabupaten Kepulauan Talaud, baru

sekitar 74.90 persen perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup yang terakhir di fasilitas kesehatan, sisanya masih ada sekitar 25,10 persen perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir, melahirkan anak lahir hidup yang terakhir bukan di fasilitas kesehatan (Tabel 4.5).

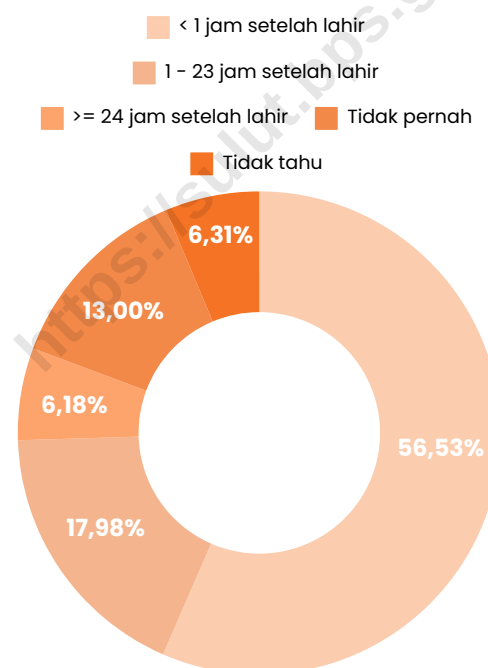


Gambar 4.2 Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Lahir Hidup yang Terakhir Dilahirkan dengan Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Menurut Karakteristik Wilayah, 2023

Di sisi lain, persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir di Sulawesi Utara melahirkan anak lahir hidup yang terakhir dengan ditolong oleh tenaga kesehatan pada tahun 2023 sebesar 94,53 persen (Tabel 4.6). Anak dikatakan dilahirkan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan apabila penolong proses kelahiran terakhir adalah dokter kandungan, dokter umum, bidan, atau perawat. Berdasarkan karakteristik wilayah, di perkotaan 97,89 persen perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir, melahirkan anak lahir hidup yang terakhir dengan ditolong oleh tenaga kesehatan. Sementara itu di perdesaan, persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir yang melahirkan anak lahir hidup yang terakhir dengan ditolong oleh tenaga kesehatan pada sebesar 90,67 persen (Gambar 4.2).

Selanjutnya terkait Inisiasi Menyusu Dini (IMD) atau praktik menyusui bayi sesegera mungkin setelah kelahiran dengan meletakkan bayi menempel di dada atau perut ibu segera setelah lahir, memiliki keterkaitan yang signifikan dengan kesehatan ibu dan anak. Praktik

IMD bermanfaat untuk mengurangi resiko pasca persalinan bagi ibu dan bayi, meningkatkan produksi ASI, dan juga membentuk dasar bagi hubungan emosional antara ibu dan bayi. Praktik IMD juga memiliki potensi untuk meningkatkan sistem kekebalan bayi, memberikan perlindungan terhadap infeksi, dan mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi agar optimal. Maka dari itu, peningkatan kesadaran dan dukungan terhadap praktik IMD menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan kesehatan bayi dan ibu. Di provinsi Sulawesi Utara, persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup terakhir dalam dua tahun terakhir dan diletakkan di atas dada ibu secara langsung kurang dari satu jam setelah dilahirkan sebesar 56,53 persen. Dengan kata lain, sekitar 56 dari 100 perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup terakhir dalam dua tahun terakhir telah melakukan praktik IMD. Sementara itu, masih terdapat 13 persen perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup dalam dua tahun terakhir, anak lahir hidup terakhir tidak diletakkan di atas dada ibu dengan bersentuhan kulit secara langsung setelah dilahirkan (Gambar 4.3).



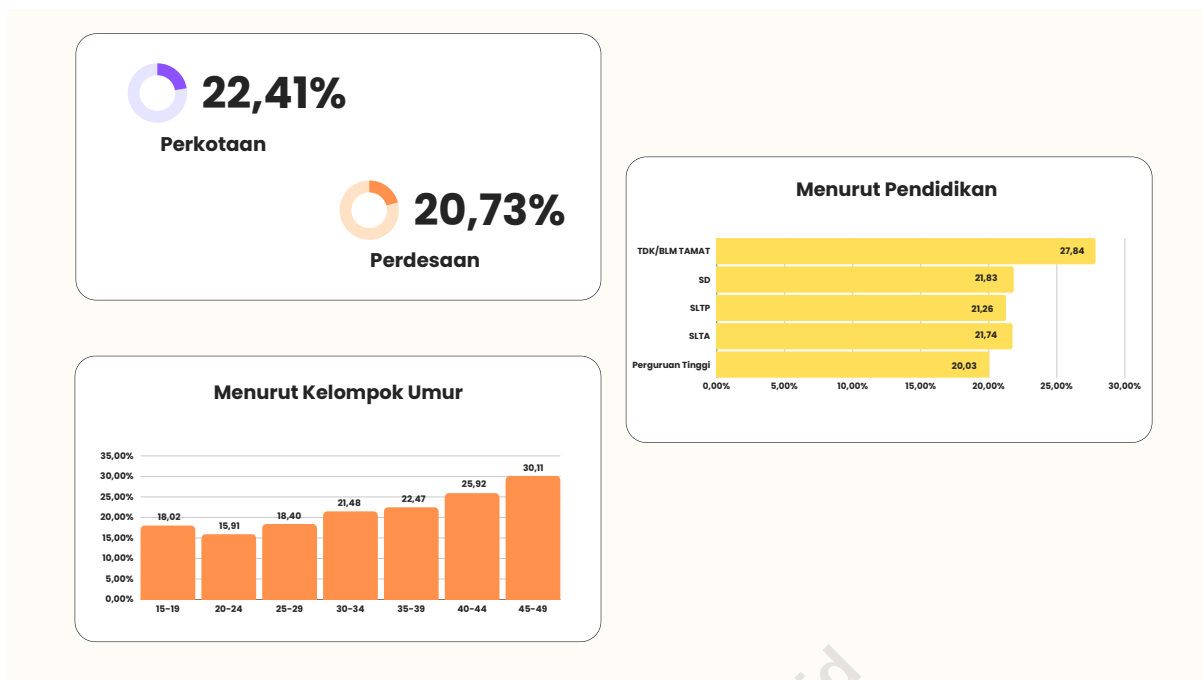
Gambar 4.3 Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Lahir Hidup Terakhir Menurut Lamanya Waktu Diletakkan di Atas Dada Ibu dengan Bersentuhan Kulit secara Langsung Saat Dilahirkan, 2023

BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) merupakan kondisi di mana bayi lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram atau 2,5 kg meskipun usia kehamilan sudah cukup. Bayi dengan BBLR lebih rentan terhadap komplikasi medis dan berisiko mengalami keterlambatan

pertumbuhan fisik serta perkembangan kognitif dan motorik. Program pencegahan BBLR seringkali melibatkan peningkatan kesehatan ibu melalui perawatan prenatal yang baik, nutrisi yang tepat, dan pengelolaan kondisi kesehatan. Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup dalam 2 (dua) tahun terakhir dan anak lahir hidup yang terakhir dilahirkan dengan BBLR pada tahun 2023 di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 10,95 persen (Tabel 4.7). Jika dikaji dari karakteristik pendidikan, persentase terendah terlihat pada tingkat pendidikan tertinggi. Di sisi lain, persentase menurut kelompok umur menunjukkan pola hampir seperti huruf U, dimana persentase menunjukkan penurunan hingga kelompok umur tertentu dan kemudian meningkat kembali seiring dengan peningkatan umur (Tabel 4.8).

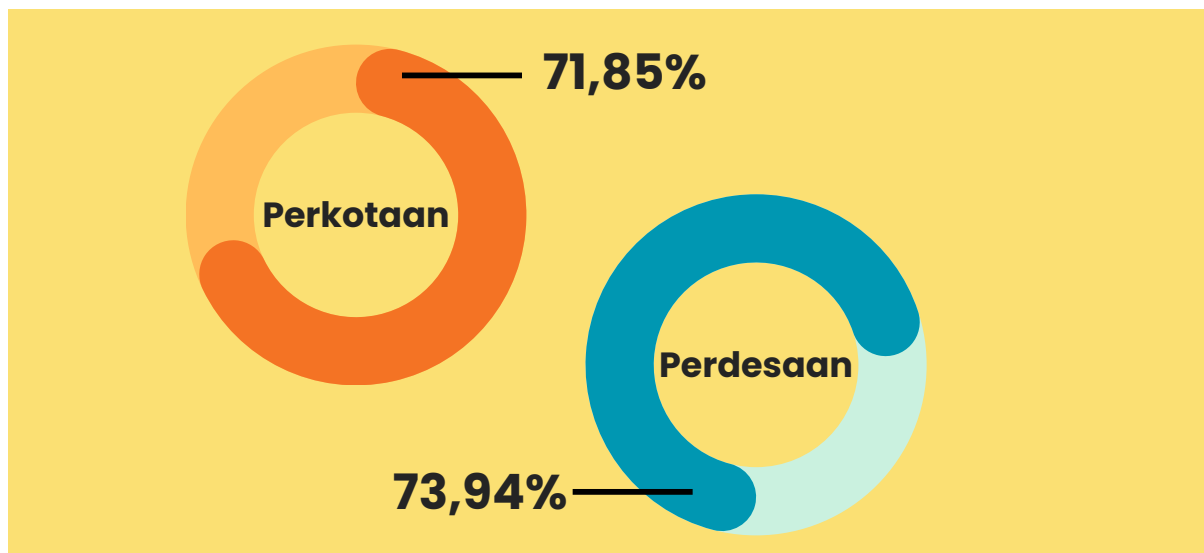
4.2 Keluhan dan Upaya Kesehatan yang Dilakukan Perempuan Usia Subur

Ketika seorang perempuan dapat memperoleh kesehatan yang lebih baik, maka semakin besar peluangnya untuk melahirkan generasi lebih baik. Dari seorang ibu yang sehat secara fisik maupun mental, akan tercipta juga anak yang sehat dan cerdas. Untuk menyongsong generasi emas 2045 yang kini tengah digaungkan oleh pemerintah, dibutuhkan sinergi semua pihak untuk mengetahui kondisi keluarga terutama ibu maupun calon ibu. Persentase perempuan umur 15-49 tahun yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2023 sebesar 21,69 persen (Tabel 4.9). Keluhan kesehatan yang dimaksud ialah berasal dari persepsi perempuan umur 15-49 tahun tersebut dan bukan berdasarkan hasil pemeriksaan tenaga kesehatan. Persentase perempuan umur 15-49 tahun yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir di perkotaan lebih tinggi dibandingkan di perdesaan. Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, semakin bertambahnya umur semakin tinggi pula persentase perempuan yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir. Sementara itu, dilihat dari karakteristik pendidikan yang ditamatkan, persentase terendah terlihat pada tingkat pendidikan tertinggi yaitu perguruan tinggi (Gambar 4.4). Kabupaten Minahasa merupakan wilayah dengan persentase tertinggi perempuan umur 15-49 tahun yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir yaitu sebesar 32,64 persen, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten Siau Tagulandang Biaro yaitu sebesar 10,38 persen (Tabel 4.9).



Gambar 4.4 Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik, 2023

Angka kesakitan/ Morbiditas dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Indikator tersebut diukur melalui persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir dan mengakibatkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Terganggunya kegiatan sehari-hari yang dimaksud adalah ketika seseorang tidak dapat melakukan kegiatan bekerja, sekolah, atau kegiatan sehari-hari secara normal sebagaimana biasanya akibat mempunyai keluhan kesehatan. Di tahun 2023, 10 dari 100 perempuan umur 15-49 tahun di Provinsi Sulawesi Utara mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir dan mengakibatkan terganggunya kegiatan sehari-hari (Tabel 4.11). Secara umum, persentase perempuan umur 15-49 tahun yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir maupun persentase perempuan umur 15-49 tahun yang mempunyai keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir dan mengakibatkan terganggunya kegiatan sehari-hari menurut beberapa karakteristik menunjukkan pola yang hampir sama. Karakteristik tersebut yaitu terkait dengan pendidikan dan kelompok umur (Tabel 4.10 dan Tabel 4.12).



Gambar 4.5 Persentase Perempuan Umur 15–49 Tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Mengobati Sendiri dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik Wilayah, 2023

Untuk mengobati keluhan kesehatan yang dialami dalam sebulan terakhir, pada tahun 2023 sebanyak 72,71 persen perempuan umur 15-49 tahun mengobati sendiri keluhan kesehatan yang mereka alami (Tabel 4.13). Dalam hal ini, mengobati sendiri ialah perempuan umur 15-49 tahun yang mempunyai keluhan kesehatan tersebut menentukan sendiri jenis obat yang dikonsumsi tanpa resep ataupun saran dari tenaga kesehatan atau pengobatan tradisional. Di Provinsi Sulawesi Utara, persentase untuk daerah perdesaan menunjukkan angka yang lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan (Gambar 4.5). Di samping itu, terdapat 33,7 persen perempuan umur 15-49 tahun yang mempunyai keluhan kesehatan, pernah melakukan rawat jalan dalam sebulan terakhir (Tabel 4.14). Dengan adanya ketersediaan akses kesehatan yang merata bagi ibu serta calon ibu untuk berobat di seluruh wilayah perkotaan maupun perdesaan, tentunya akan memberikan dampak yang positif bagi ibu itu sendiri dan anak serta keluarga.

Tabel 4.1 Rata-Rata Umur Perkawinan Pertama Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

No.	Kabupaten/Kota	Rata-rata umur (tahun)
(1)	(2)	(3)
1	Bolaang Mongondow	20,02
2	Minahasa	21,56
3	Kepulauan Sangihe	21,92
4	Kepulauan Talaud	21,14
5	Minahasa Selatan	21,39
6	Minahasa Utara	21,24
7	Bolaang Mongondow Utara	20,35
8	Siau Tagulandang Biaro	22,20
9	Minahasa Tenggara	20,51
10	Bolaang Mongondow Selatan	19,98
11	Bolaang Mongondow Timur	20,06
12	Manado	21,89
13	Bitung	21,24
14	Tomohon	22,40
15	Kotamobagu	20,75
Sulawesi Utara		21,20

Tabel 4.2 Rata-Rata Umur Perkawinan Pertama Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun Menurut Karakteristik Tahun 2023

Karakteristik	Rata-rata umur (tahun)
(1)	(2)
Klasifikasi Desa	
Perkotaan	21,65
Perdesaan	20,68
Kelompok Umur	
15-19 tahun	16,30
20-24 tahun	18,68
25-29 tahun	20,63
30-34 tahun	21,34
35-39 tahun	21,44
40-44 tahun	21,86
45-49 tahun	21,98
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan KRT	
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	19,15
SD/Sederajat	19,80
SMP/Sederajat	19,78
SMA/Sederajat	21,77
Perguruan Tinggi	23,85
Sulawesi Utara	21,20

Tabel 4.3 Rata-Rata Umur Kehamilan Pertama Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Pernah Hamil Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

No.	Kabupaten/Kota	Rata-rata umur (tahun)
(1)	(2)	(3)
1	Bolaang Mongondow	20,45
2	Minahasa	21,80
3	Kepulauan Sangihe	21,95
4	Kepulauan Talaud	21,69
5	Minahasa Selatan	21,58
6	Minahasa Utara	21,50
7	Bolaang Mongondow Utara	20,93
8	Siau Tagulandang Biaro	22,55
9	Minahasa Tenggara	20,95
10	Bolaang Mongondow Selatan	20,42
11	Bolaang Mongondow Timur	20,69
12	Manado	22,18
13	Bitung	21,47
14	Tomohon	22,37
15	Kotamobagu	21,12
Sulawesi Utara		21,51

Tabel 4.4 Rata-Rata Umur Kehamilan Pertama Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Pernah Hamil Menurut Karakteristik Tahun 2023

Karakteristik	Rata-rata umur (tahun)
(1)	(2)
Klasifikasi Desa	
Perkotaan	21,89
Perdesaan	21,05
Kelompok Umur	
15-19 tahun	16,41
20-24 tahun	18,79
25-29 tahun	20,72
30-34 tahun	21,64
35-39 tahun	21,75
40-44 tahun	22,15
45-49 tahun	22,48
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan KRT	
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	19,64
SD/Sederajat	20,22
SMP/Sederajat	20,21
SMA/Sederajat	21,97
Perguruan Tinggi	24,19
Sulawesi Utara	21,51

Tabel 4.5 Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 tahun yang melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Lahir Hidup yang Terakhir Dilahirkan di Fasilitas Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

No.	Kabupaten/Kota	Persentase
(1)	(2)	(3)
1	Bolaang Mongondow	77,43
2	Minahasa	93,80
3	Kepulauan Sangihe	83,88
4	Kepulauan Talaud	74,90
5	Minahasa Selatan	88,50
6	Minahasa Utara	91,11
7	Bolaang Mongondow Utara	97,94
8	Siau Tagulandang Biaro	89,46
9	Minahasa Tenggara	100,00
10	Bolaang Mongondow Selatan	82,70
11	Bolaang Mongondow Timur	87,08
12	Manado	100,00
13	Bitung	92,56
14	Tomohon	100,00
15	Kotamobagu	98,46
Sulawesi Utara		91,39

Tabel 4.6 Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 tahun yang melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Lahir Hidup yang Terakhir Dilahirkan dengan Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

No.	Kabupaten/Kota	Persentase
(1)	(2)	(3)
1	Bolaang Mongondow	87,66
2	Minahasa	93,80
3	Kepulauan Sangihe	86,54
4	Kepulauan Talaud	87,62
5	Minahasa Selatan	94,03
6	Minahasa Utara	90,26
7	Bolaang Mongondow Utara	99,49
8	Siau Tagulandang Biaro	99,01
9	Minahasa Tenggara	100,00
10	Bolaang Mongondow Selatan	87,36
11	Bolaang Mongondow Timur	92,31
12	Manado	100,00
13	Bitung	95,90
14	Tomohon	100,00
15	Kotamobagu	100,00
Sulawesi Utara		94,53

Tabel 4.7 Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 tahun yang melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Lahir Hidup yang Terakhir Dilahirkan dengan Berat Badan Lahir Rendah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

No.	Kabupaten/Kota	Persentase
(1)	(2)	(3)
1	Bolaang Mongondow	4,74
2	Minahasa	8,42
3	Kepulauan Sangihe	12,49
4	Kepulauan Talaud	5,63
5	Minahasa Selatan	14,68
6	Minahasa Utara	21,66
7	Bolaang Mongondow Utara	4,80
8	Siau Tagulandang Biaro	–
9	Minahasa Tenggara	4,50
10	Bolaang Mongondow Selatan	–
11	Bolaang Mongondow Timur	4,41
12	Manado	23,17
13	Bitung	8,91
14	Tomohon	–
15	Kotamobagu	5,60
Sulawesi Utara		10,95

Tabel 4.8 Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 tahun yang melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Lahir Hidup yang Terakhir Dilahirkan dengan Berat Badan Lahir Rendah Menurut Karakteristik Tahun 2023

Karakteristik	Persentase
(1)	(2)
Klasifikasi Desa	
Perkotaan	15,73
Perdesaan	5,47
Kelompok Umur	
15-19 tahun	16,73
20-24 tahun	9,71
25-29 tahun	11,69
30-34 tahun	10,58
35-39 tahun	11,27
40-44 tahun	5,98
45-49 tahun	17,18
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan KRT	
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	5,03
SD/Sederajat	5,20
SMP/Sederajat	13,36
SMA/Sederajat	14,14
Perguruan Tinggi	4,92
Sulawesi Utara	10,95

Tabel 4.9 Persentase Perempuan Umur 15–49 tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

No.	Kabupaten/Kota	Persentase
(1)	(2)	(3)
1	Bolaang Mongondow	19,08
2	Minahasa	32,64
3	Kepulauan Sangihe	18,61
4	Kepulauan Talaud	18,37
5	Minahasa Selatan	25,05
6	Minahasa Utara	24,45
7	Bolaang Mongondow Utara	21,09
8	Siau Tagulandang Biaro	10,38
9	Minahasa Tenggara	23,72
10	Bolaang Mongondow Selatan	16,71
11	Bolaang Mongondow Timur	26,50
12	Manado	16,40
13	Bitung	21,75
14	Tomohon	23,97
15	Kotamobagu	18,01
Sulawesi Utara		21,69

Tabel 4.10 Persentase Perempuan Umur 15–49 tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Karakteristik Tahun 2023

Karakteristik	Persentase
(1)	(2)
Klasifikasi Desa	
Perkotaan	22,41
Perdesaan	20,73
Kelompok Umur	
15-19 tahun	18,02
20-24 tahun	15,91
25-29 tahun	18,40
30-34 tahun	21,48
35-39 tahun	22,47
40-44 tahun	25,92
45-49 tahun	30,11
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan KRT	
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	27,84
SD/Sederajat	21,83
SMP/Sederajat	21,26
SMA/Sederajat	21,74
Perguruan Tinggi	20,03
Sulawesi Utara	21,69

Tabel 4.11 Persentase Perempuan Umur 15–49 tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

No.	Kabupaten/Kota	Persentase
(1)	(2)	(3)
1	Bolaang Mongondow	10,63
2	Minahasa	12,60
3	Kepulauan Sangihe	11,02
4	Kepulauan Talaud	8,14
5	Minahasa Selatan	12,78
6	Minahasa Utara	8,37
7	Bolaang Mongondow Utara	7,90
8	Siau Tagulandang Biaro	5,80
9	Minahasa Tenggara	11,68
10	Bolaang Mongondow Selatan	11,07
11	Bolaang Mongondow Timur	11,94
12	Manado	6,16
13	Bitung	12,36
14	Tomohon	6,34
15	Kotamobagu	7,11
Sulawesi Utara		9,60

Tabel 4.12 Persentase Perempuan Umur 15–49 tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari Menurut Karakteristik Tahun 2023

Karakteristik	Persentase
(1)	(2)
Klasifikasi Desa	
Perkotaan	9,58
Perdesaan	9,62
Kelompok Umur	
15-19 tahun	9,08
20-24 tahun	6,34
25-29 tahun	7,13
30-34 tahun	9,18
35-39 tahun	11,20
40-44 tahun	11,20
45-49 tahun	13,31
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan KRT	
Tidak/Belum Pernah Sekolah dan Tidak Tamat SD	15,25
SD/Sederajat	9,90
SMP/Sederajat	10,17
SMA/Sederajat	8,56
Perguruan Tinggi	9,20
Sulawesi Utara	9,60

Tabel 4.13 Persentase Perempuan Umur 15–49 tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Mengobati Sendiri dalam Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2023

No.	Kabupaten/Kota	Persentase
(1)	(2)	(3)
1	Bolaang Mongondow	67,62
2	Minahasa	80,06
3	Kepulauan Sangihe	60,72
4	Kepulauan Talaud	83,24
5	Minahasa Selatan	77,12
6	Minahasa Utara	65,83
7	Bolaang Mongondow Utara	84,78
8	Siau Tagulandang Biaro	81,92
9	Minahasa Tenggara	57,79
10	Bolaang Mongondow Selatan	80,03
11	Bolaang Mongondow Timur	89,78
12	Manado	67,14
13	Bitung	63,31
14	Tomohon	81,97
15	Kotamobagu	75,17
Sulawesi Utara		72,71

Tabel 4.14 Persentase Perempuan Umur 15–49 tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

No.	Kabupaten/Kota	Persentase
(1)	(2)	(3)
1	Bolaang Mongondow	40,65
2	Minahasa	26,52
3	Kepulauan Sangihe	53,20
4	Kepulauan Talaud	28,64
5	Minahasa Selatan	31,83
6	Minahasa Utara	38,93
7	Bolaang Mongondow Utara	37,29
8	Siau Tagulandang Biaro	32,12
9	Minahasa Tenggara	45,71
10	Bolaang Mongondow Selatan	9,70
11	Bolaang Mongondow Timur	16,17
12	Manado	32,40
13	Bitung	43,58
14	Tomohon	27,71
15	Kotamobagu	29,52
Sulawesi Utara		33,70

Tabel 4.15 *Sampling Error* Rata-Rata Umur Perkawinan Pertama Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Rata-Rata Umur Perkawinan Pertama				
	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error	Selang Kepercayaan 95 Persen	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bolaang Mongondow	20,02	0,27	1,35	19,49	20,55
Minahasa	21,56	0,31	1,45	20,95	22,17
Kepulauan Sangihe	21,92	0,32	1,48	21,29	22,56
Kepulauan Talaud	21,14	0,24	1,15	20,66	21,62
Minahasa Selatan	21,39	0,27	1,25	20,86	21,91
Minahasa Utara	21,24	0,35	1,66	20,55	21,93
Bolaang Mongondow Utara	20,35	0,27	1,32	19,82	20,87
Siau Tagulandang Biaro	22,20	0,29	1,31	21,63	22,77
Minahasa Tenggara	20,51	0,27	1,32	19,98	21,04
Bolaang Mongondow Selatan	19,98	0,21	1,07	19,56	20,40
Bolaang Mongondow Timur	20,06	0,30	1,48	19,48	20,64
Manado	21,89	0,29	1,34	21,31	22,47
Bitung	21,24	0,26	1,21	20,73	21,74
Tomohon	22,40	0,32	1,43	21,77	23,03
Kotamobagu	20,75	0,25	1,20	20,26	21,23
Sulawesi Utara	21,20	0,09	0,41	21,03	21,38

Tabel 4.16 *Sampling Error* Rata-Rata Umur Kehamilan Pertama Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 Tahun yang Pernah Hamil Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Rata-Rata Umur Kehamilan Pertama				
	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error	Selang Kepercayaan 95 Persen	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bolaang Mongondow	20,45	0,27	1,34	19,92	20,99
Minahasa	21,80	0,27	1,26	21,26	22,34
Kepulauan Sangihe	21,95	0,34	1,55	21,28	22,62
Kepulauan Talaud	21,69	0,27	1,24	21,16	22,22
Minahasa Selatan	21,58	0,26	1,21	21,07	22,10
Minahasa Utara	21,50	0,29	1,33	20,94	22,06
Bolaang Mongondow Utara	20,93	0,27	1,27	20,41	21,45
Siau Tagulandang Biaro	22,55	0,27	1,21	22,01	23,08
Minahasa Tenggara	20,95	0,28	1,35	20,40	21,51
Bolaang Mongondow Selatan	20,42	0,24	1,17	19,95	20,89
Bolaang Mongondow Timur	20,69	0,31	1,48	20,09	21,29
Manado	22,18	0,29	1,30	21,61	22,74
Bitung	21,47	0,26	1,19	20,97	21,98
Tomohon	22,37	0,31	1,37	21,77	22,97
Kotamobagu	21,12	0,26	1,25	20,60	21,64
Sulawesi Utara	21,51	0,08	0,39	21,34	21,67

Tabel 4.17 *Sampling Error* Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 tahun yang melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Lahir Hidup yang Terakhir Dilahirkan di Fasilitas Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Melahirkan di Fasilitas Kesehatan				
	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error	Selang Kepercayaan 95 Persen	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bolaang Mongondow	77,43	8,72	11,26	60,32	94,55
Minahasa	93,80	4,07	4,34	85,80	101,80
Kepulauan Sangihe	83,88	7,32	8,72	69,52	98,25
Kepulauan Talaud	74,90	7,41	9,89	60,35	89,44
Minahasa Selatan	88,50	5,15	5,82	78,39	98,62
Minahasa Utara	91,11	4,25	4,66	82,78	99,45
Bolaang Mongondow Utara	97,94	1,63	1,66	94,74	101,14
Siau Tagulandang Biaro	89,46	4,64	5,19	80,34	98,57
Minahasa Tenggara	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Bolaang Mongondow Selatan	82,70	4,64	5,61	73,58	91,81
Bolaang Mongondow Timur	87,08	5,79	6,65	75,71	98,46
Manado	100,00	–	–	100,00	100,00
Bitung	92,56	3,29	3,55	86,11	99,01
Tomohon	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kotamobagu	98,46	1,44	1,46	95,64	101,29
Sulawesi Utara	91,39	1,46	1,59	88,53	94,25

Tabel 4.18 *Sampling Error* Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 tahun yang melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Lahir Hidup yang Terakhir Dilahirkan dengan Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Melahirkan Ditolong oleh Tenaga Kesehatan				
	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error	Selang Kepercayaan 95 Persen	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bolaang Mongondow	87,66	5,80	6,62	76,28	99,05
Minahasa	93,80	4,07	4,34	85,80	101,80
Kepulauan Sangihe	86,54	6,97	8,06	72,85	100,22
Kepulauan Talaud	87,62	5,84	6,67	76,15	99,09
Minahasa Selatan	94,03	3,39	3,60	87,38	100,69
Minahasa Utara	90,26	4,57	5,06	81,29	99,24
Bolaang Mongondow Utara	99,49	0,51	0,52	98,49	100,50
Siau Tagulandang Biaro	99,01	0,99	1,00	97,06	100,96
Minahasa Tenggara	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Bolaang Mongondow Selatan	87,36	3,92	4,48	79,67	95,05
Bolaang Mongondow Timur	92,31	3,46	3,75	85,52	99,10
Manado	100,00	–	–	100,00	100,00
Bitung	95,90	2,36	2,46	91,27	100,52
Tomohon	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kotamobagu	100,00	–	–	100,00	100,00
Sulawesi Utara	94,53	1,04	1,10	92,49	96,57

Tabel 4.19 *Sampling Error* Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 15–49 tahun yang melahirkan Anak Lahir Hidup dalam Dua Tahun Terakhir dan Anak Lahir Hidup yang Terakhir Dilahirkan dengan Berat Badan Lahir Rendah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Melahirkan Berat Badan Lahir Rendah				
	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error	Selang Kepercayaan 95 Persen	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bolaang Mongondow	NA	3,39	71,59	~0	11,40
Minahasa	8,42	4,01	47,64	0,54	16,29
Kepulauan Sangihe	NA	8,07	64,61	~0	28,33
Kepulauan Talaud	NA	5,41	96,07	~0	16,26
Minahasa Selatan	14,68	6,25	42,53	2,42	26,95
Minahasa Utara	21,66	7,31	33,77	7,30	36,02
Bolaang Mongondow Utara	NA	4,62	96,25	~0	13,87
Siau Tagulandang Biaro	–	–	–	–	–
Minahasa Tenggara	NA	4,36	96,86	~0	13,06
Bolaang Mongondow Selatan	–	–	–	–	–
Bolaang Mongondow Timur	NA	4,26	96,73	~0	12,78
Manado	23,17	7,41	32,00	8,61	37,73
Bitung	NA	4,47	50,14	0,14	17,69
Tomohon	–	–	–	–	–
Kotamobagu	NA	5,36	95,75	~0	16,13
Sulawesi Utara	10,95	1,84	16,78	7,34	14,56

Tabel 4.20 *Sampling Error* Persentase Perempuan Umur 15–49 tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir				
	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error	Selang Kepercayaan 95 Persen	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bolaang Mongondow	19,08	2,48	13,00	14,22	23,94
Minahasa	32,64	3,00	9,18	26,77	38,52
Kepulauan Sangihe	18,61	2,60	13,98	13,51	23,71
Kepulauan Talaud	18,37	2,46	13,42	13,54	23,20
Minahasa Selatan	25,05	2,71	10,82	19,74	30,36
Minahasa Utara	24,45	2,76	11,27	19,05	29,86
Bolaang Mongondow Utara	21,09	2,23	10,58	16,71	25,46
Siau Tagulandang Biaro	10,38	2,29	22,02	5,90	14,86
Minahasa Tenggara	23,72	2,73	11,49	18,38	29,07
Bolaang Mongondow Selatan	16,71	2,19	13,10	12,42	21,00
Bolaang Mongondow Timur	26,50	2,90	10,93	20,82	32,18
Manado	16,40	1,82	11,09	12,83	19,96
Bitung	21,75	2,37	10,91	17,10	26,40
Tomohon	23,97	3,15	13,16	17,78	30,15
Kotamobagu	18,01	2,07	11,47	13,96	22,06
Sulawesi Utara	21,69	0,75	3,47	20,21	23,16

Tabel 4.21 *Sampling Error* Persentase Perempuan Umur 15–49 tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Mengakibatkan Terganggunya Kegiatan Sehari-hari				
	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error	Selang Kepercayaan 95 Persen	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bolaang Mongondow	10,63	2,07	19,50	6,57	14,69
Minahasa	12,60	2,12	16,86	8,44	16,77
Kepulauan Sangihe	11,02	2,07	18,79	6,96	15,08
Kepulauan Talaud	8,14	1,60	19,63	5,01	11,28
Minahasa Selatan	12,78	1,98	15,48	8,90	16,65
Minahasa Utara	8,37	1,87	22,32	4,71	12,03
Bolaang Mongondow Utara	7,90	1,49	18,88	4,98	10,82
Siau Tagulandang Biaro	5,80	1,71	29,44	2,45	9,15
Minahasa Tenggara	11,68	2,28	19,53	7,21	16,15
Bolaang Mongondow Selatan	11,07	1,99	17,99	7,17	14,98
Bolaang Mongondow Timur	11,94	2,18	18,30	7,66	16,22
Manado	6,16	1,14	18,51	3,92	8,39
Bitung	12,36	1,95	15,77	8,54	16,19
Tomohon	6,34	1,33	20,98	3,73	8,94
Kotamobagu	7,11	1,35	19,04	4,46	9,77
Sulawesi Utara	9,60	0,53	5,55	8,56	10,64

Tabel 4.22 *Sampling Error* Persentase Perempuan Umur 15-49 tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Mengobati Sendiri dalam Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir dan Pernah Mengobati Sendiri				
	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error	Selang Kepercayaan 95 Persen	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bolaang Mongondow	67,62	6,36	9,40	55,15	80,08
Minahasa	80,06	4,10	5,12	72,03	88,09
Kepulauan Sangihe	60,72	7,61	12,53	45,79	75,64
Kepulauan Talaud	83,24	5,07	6,09	73,30	93,17
Minahasa Selatan	77,12	4,82	6,25	67,67	86,58
Minahasa Utara	65,83	6,21	9,44	53,65	78,02
Bolaang Mongondow Utara	84,78	3,59	4,23	77,74	91,81
Siau Tagulandang Biaro	81,92	7,10	8,67	67,98	95,85
Minahasa Tenggara	57,79	7,28	12,59	43,52	72,07
Bolaang Mongondow Selatan	80,03	6,58	8,22	67,13	92,94
Bolaang Mongondow Timur	89,78	3,89	4,34	82,15	97,42
Manado	67,14	6,02	8,97	55,32	78,96
Bitung	63,31	6,10	9,64	51,34	75,28
Tomohon	81,97	4,79	5,84	72,58	91,36
Kotamobagu	75,17	5,39	7,17	64,60	85,73
Sulawesi Utara	72,71	1,73	2,38	69,31	76,10

Tabel 4.23 *Sampling Error* Persentase Perempuan Umur 15–49 tahun yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Pernah Rawat Jalan dalam Sebulan Terakhir Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Mempunyai Keluhan Kesehatan dalam Sebulan Terakhir				
	Estimasi	Standard Error	Relative Standard Error	Selang Kepercayaan 95 Persen	
				Batas Bawah	Batas Atas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bolaang Mongondow	40,65	6,71	16,50	27,49	53,81
Minahasa	26,52	4,67	17,62	17,36	35,69
Kepulauan Sangihe	53,20	7,55	14,20	38,38	68,02
Kepulauan Talaud	28,64	6,33	22,11	16,22	41,07
Minahasa Selatan	31,83	5,66	17,76	20,74	42,93
Minahasa Utara	38,93	6,68	17,15	25,84	52,03
Bolaang Mongondow Utara	37,29	5,42	14,52	26,66	47,91
Siau Tagulandang Biaro	32,12	9,81	30,55	12,87	51,36
Minahasa Tenggara	45,71	6,97	15,25	32,04	59,39
Bolaang Mongondow Selatan	9,70	3,63	37,40	2,58	16,81
Bolaang Mongondow Timur	16,17	4,44	27,47	7,46	24,89
Manado	32,40	5,78	17,82	21,07	43,74
Bitung	43,58	6,29	14,43	31,24	55,91
Tomohon	27,71	5,71	20,61	16,51	38,91
Kotamobagu	29,52	5,59	18,93	18,56	40,48
Sulawesi Utara	33,70	1,82	5,39	30,14	37,26

BAB 5

POLA PENGELUARAN KESEHATAN PENDUDUK SULAWESI UTARA

**STATISTIK KESEHATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA
2023**



BAB 5

POLA PENGELUARAN KESEHATAN PENDUDUK SULAWESI UTARA

Dalam tiga tahun terakhir, pembangunan kesehatan di Sulawesi Utara menunjukkan capaian yang baik. Beberapa indikator yang menunjukkan perbaikan signifikan dalam periode tersebut di antaranya umur harapan hidup saat lahir (UHH) yang meningkat dari sebelumnya 71,76 pada tahun 2021, kemudian meningkat menjadi 72,08 pada tahun 2022, dan terus bertambah menjadi 72,40 pada tahun 2023. Kemudian, berdasarkan Hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020 Sulawesi Utara, penurunan Angka Kematian Bayi dalam 50 tahun terakhir mencapai 85 persen. Dalam sepuluh tahun terakhir, Angka Kematian Bayi (IMR) Sulawesi Utara cenderung menurun dari 25 per 1.000 kelahiran hidup berdasarkan Sensus Penduduk 2010, menjadi 17,23 per 1.000 kelahiran hidup berdasarkan pendataan *Long Form* Sensus Penduduk 2020.

Untuk mencapai kondisi kesehatan yang prima, dipengaruhi oleh kesadaran dan kemampuan. Kesadaran akan pentingnya kesehatan dapat diperoleh dari jenjang pendidikan yang ditamatkan. Bersumber dari Susenas Maret, Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk Sulawesi Utara usia 7 tahun ke atas meningkat dari 12,95 pada tahun 2022, menjadi 12,96 pada tahun 2023. Kemudian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk Sulawesi Utara usia 25 tahun ke atas meningkat dari 9,68 di tahun 2022, kemudian 9,77 di tahun 2023.

Kemampuan untuk mengakses pelayanan kesehatan dapat dicapai apabila penduduk dapat produktif kerja, sehingga menghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, terutama gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jumlah penduduk yang bekerja menurut Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2023 adalah sebanyak 1,25 juta, lebih banyak 90.000 orang dibandingkan keadaan di Agustus 2022. Selain itu, peningkatan pendapatan tercermin dalam meningkatnya pengeluaran masyarakat yang sebelumnya Rp1.236.706 pada tahun 2022, menjadi Rp1.315.176 pada tahun 2023.

Studi terkait hubungan antara tingkat pendidikan maupun kesejahteraan dengan kondisi kesehatan penduduk telah banyak dilakukan. Raghupathi (2020) memperkuat keyakinan bahwa penduduk dengan tingkat pendidikan lebih tinggi memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik dan umur panjang dibandingkan penduduk dengan tingkat pendidikan lebih rendah. Pendidikan tinggi terutama berpengaruh kuat pada AKB, UHH, dan imunisasi.

Sementara itu, dalam jurnal kesehatan yang ditulis oleh Xiaodong Cui dan Cher-Ter Chang (2021) mengatakan bahwa semakin tinggi pendapatan, akan menambah waktu kerja dan stres, namun dapat meningkatkan kesehatan. Artinya, secara tidak langsung, pendapatan dapat membuat kesehatan menjadi lebih baik. Hal ini juga dikuatkan oleh Markus (2015) dan Safren (2020) yang mengatakan bahwa orang berada memiliki pengetahuan yang kritis, sehingga mampu menghindari risiko dan penyakit. Ternyata, hal ini berlaku sebaliknya, Halliday (2007) mengatakan bahwa kesehatan berpengaruh terhadap pendapatan.

Faktor yang juga berpengaruh terhadap derajat kesehatan penduduk adalah pengeluaran kesehatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun rumah tangga, dampak positif dari peningkatan alokasi belanja kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dapat langsung terlihat antara lain melalui pembangunan fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, dan lain-lain yang secara langsung akan berdampak pada membaiknya status kesehatan masyarakat. Studi terbaru oleh Anwar dkk. (2023) di negara-negara anggota OECD menemukan bahwa pengeluaran kesehatan pemerintah berdampak positif terhadap umur harapan hidup.

Sementara itu di sisi lain, pengeluaran kesehatan yang dilakukan oleh penduduk memberikan indikasi akan perilaku penduduk dalam upaya meningkatkan maupun menjaga kesehatan. Jenis barang/jasa kesehatan yang dikonsumsi oleh penduduk dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu pengeluaran untuk pelayanan pengobatan/kuratif, pelayanan pencegahan/preventif, dan biaya obat. Bab ini akan menguraikan pola pengeluaran kesehatan yang dilakukan oleh rumah tangga pada tahun 2023 menurut beberapa karakteristik dan diuraikan pada bagian-bagian selanjutnya.

5.1 Pola Pengeluaran Penduduk

Pengeluaran penduduk Indonesia yang dihitung melalui Susenas menunjukkan bahwa proporsi pengeluaran yang dilakukan untuk mengonsumsi makanan dan bukan makanan cukup berimbang. Pada tahun 2023, rata-rata pengeluaran per kapita yang dilakukan penduduk Sulawesi Utara selama sebulan adalah Rp1.315.176 dan sekitar 48,98 persennya merupakan pengeluaran bukan makanan. Proporsi pengeluaran bukan makanan ini sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 sebanyak 45,49 persen.

Pengeluaran bukan makanan ini mencakup beberapa kelompok peruntukan, antara lain perumahan dan fasilitas rumah tangga; pakaian, alas kaki, dan tutup kepala; barang-barang tahan lama; aneka barang dan jasa; termasuk pengeluaran untuk kesehatan. Jika dilihat

menurut kelompok-kelompok tersebut, pengeluaran bukan makanan terbesar yang dilakukan oleh penduduk adalah untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga dengan proporsi terhadap pengeluaran bukan makanan sebesar 49,96 persen di tahun 2023. Tabel 5.1 memuat informasi pengeluaran per kapita sebulan penduduk menurut jenis pengeluarannya

5.2 Pola Pengeluaran Kesehatan

Informasi pengeluaran kesehatan yang dikumpulkan dalam Susenas mencakup pengeluaran yang dikeluarkan dari kantong sendiri (*Out of Pocket/OOP*) dan pengeluaran total untuk kesehatan yang seharusnya dikeluarkan oleh rumah tangga dalam setahun terakhir. Pengeluaran kesehatan OOP merupakan pengeluaran yang benar-benar dilakukan oleh rumah tangga untuk pelayanan kesehatan, termasuk biaya konsultasi dokter, pembelian obat, retribusi pelayanan kesehatan, pengobatan alternatif/tradisional, uang gratifikasi atau pembayaran ke praktisi kesehatan atau fasilitas kesehatan, baik yang dikeluarkan secara tunai maupun menggunakan kartu debit, kredit, atau uang yang berasal dari pinjaman/hutang. Sementara itu, pengeluaran total untuk kesehatan meliputi seluruh pengeluaran kesehatan termasuk yang dibayarkan oleh pihak ketiga seperti asuransi kesehatan (termasuk Jaminan kesehatan Nasional/JKN), keluarga, tetangga, teman, kantor, atau pihak lainnya.

Secara total, rata-rata pengeluaran untuk kesehatan yang dilakukan oleh penduduk selama sebulan di tahun 2023 sebesar Rp18.236. Pengeluaran ini mencakup sekitar 0,9 persen dari total pengeluaran non makanan.



Gambar 5.1 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Penduduk Sebulan untuk Kesehatan menurut Wilayah (Rupiah), 2023

Jika dibagi menurut sumber pembiayaannya, Susenas mencatat lebih dari setengah pengeluaran kesehatan penduduk Indonesia dibayar dari kantong sendiri (OOP), yaitu sebanyak 55,11 persen di tahun 2023. Angka tersebut sangat besar dan jauh dari batasan

yang ditetapkan WHO yaitu sebesar maksimal 20 persen. Gambar 5.2 menunjukkan proporsi pengeluaran kesehatan penduduk menurut sumber pembayarannya pada tahun 2023.



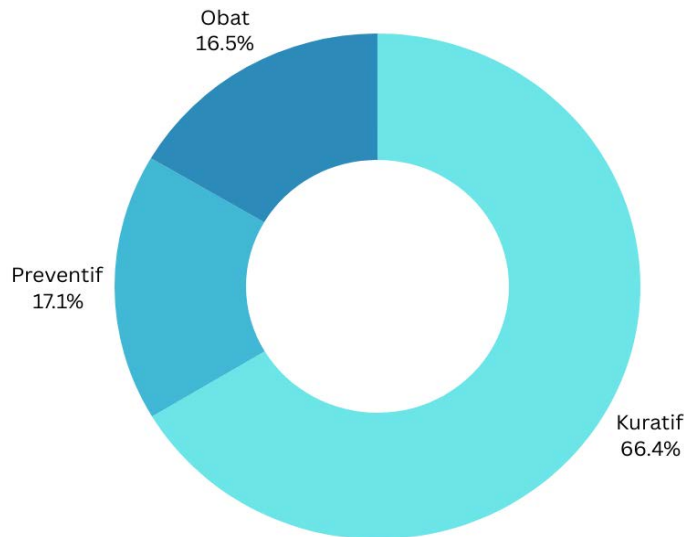
Gambar 5.2 Proporsi Pengeluaran per Kapita Penduduk Sebulan untuk Kesehatan menurut Sumber Pembiayaan

Data yang disajikan dalam gambar di atas sejalan dengan temuan Tandon dkk. (2016) yang menyimpulkan bahwa meskipun JKN telah diterapkan, kepesertaannya diperluas, serta jumlah pembiayaan publik ditingkatkan, pengeluaran OOP penduduk juga cenderung meningkat secara simultan. Kajian yang dilakukan Lembaga Penelitian dan Advokasi Kebijakan “Prakarsa” menyebutkan bahwa tingginya OOP pada pengeluaran kesehatan penduduk Indonesia paling banyak dikontribusi oleh biaya obat dan jasa kesehatan. Hal tersebut antara lain karena JKN belum mencakup semua jenis obat dan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan sehingga mendorong penduduk untuk mengeluarkan uang dari kantong sendiri agar mendapatkan jenis obat yang lebih mahal maupun layanan kesehatan yang lebih baik.

Sejalan dengan studi dan kajian di atas, WHO dalam Mahendradhata dkk (2017) menyebutkan bahwa proporsi tertinggi dari pengeluaran OOP biaya kesehatan biasanya adalah pengeluaran langsung (*direct payment*) yang merupakan berupa biaya obat, baik yang dibeli sendiri maupun obat-obatan yang ada di luar daftar dari yang dicakup oleh JKN. Studi lanjutan diperlukan untuk mengurai lebih komprehensif mengenai penyebab tingginya OOP yang dilakukan oleh penduduk Indonesia ini.

5.3 Komposisi Pengeluaran Kesehatan

Pengeluaran kesehatan yang dicatat dalam Susenas terbagi menjadi tiga jenis, yaitu: 1) biaya pelayanan pengobatan/kuratif; 2) biaya pelayanan pencegahan/preventif; dan 3) biaya obat. Pada tahun 2023, proporsi pengeluaran kesehatan yang dilakukan penduduk untuk biaya pelayanan pengobatan/kuratif selalu mendominasi (Gambar 5.3), yaitu mencapai 66,4 persen. Hal tersebut terjadi baik pada penduduk di perkotaan maupun di perdesaan (Tabel 5.2 s.d. Tabel 5.4).



Gambar 5.3 Proporsi Pengeluaran per Kapita Penduduk Sebulan untuk Kesehatan menurut Jenis Pengeluaran Kesehatan, 2023

5.3.1 Biaya Pelayanan Pengobatan/Kuratif

Biaya pelayanan pengobatan/kuratif mencakup pengeluaran yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas kesehatan terjaga seoptimal mungkin. Dalam Susenas, biaya pelayanan pengobatan/kuratif ini mencakup pengeluaran untuk pengobatan di RS pemerintah, RS swasta, puskesmas/puskesmas pembantu/polindes/posyandu, praktek pengobatan tradisional, dan dukun penolong persalinan.

Pada tahun 2023, rata-rata biaya pelayanan pengobatan/kuratif yang dilakukan penduduk selama sebulan sebesar Rp 12.109, dengan pengeluaran terbesar dilakukan untuk biaya pelayanan di RS swasta. Untuk tahun yang sama, pengeluaran yang dilakukan penduduk di perkotaan untuk biaya pelayanan pengobatan/kuratif ini sebesar Rp11.132, lebih rendah daripada yang dikeluarkan oleh penduduk di perdesaan yang sebesar Rp13.296 per kapita sebulan. Jika dirinci menurut tempat melakukannya, penduduk di perkotaan paling banyak mengeluarkan biaya pelayanan pengobatan/kuratif di RS swasta, sementara untuk penduduk perdesaan paling banyak di RS pemerintah (Tabel 5.2 s.d. Tabel 5.3).

5.3.2 Biaya Pelayanan Pencegahan

Biaya pelayanan pencegahan/preventif mencakup pengeluaran untuk tindakan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit. Dalam Susenas, pengeluaran yang masuk dalam kategori ini adalah biaya untuk keluarga berencana (alat/cara kontrasepsi,

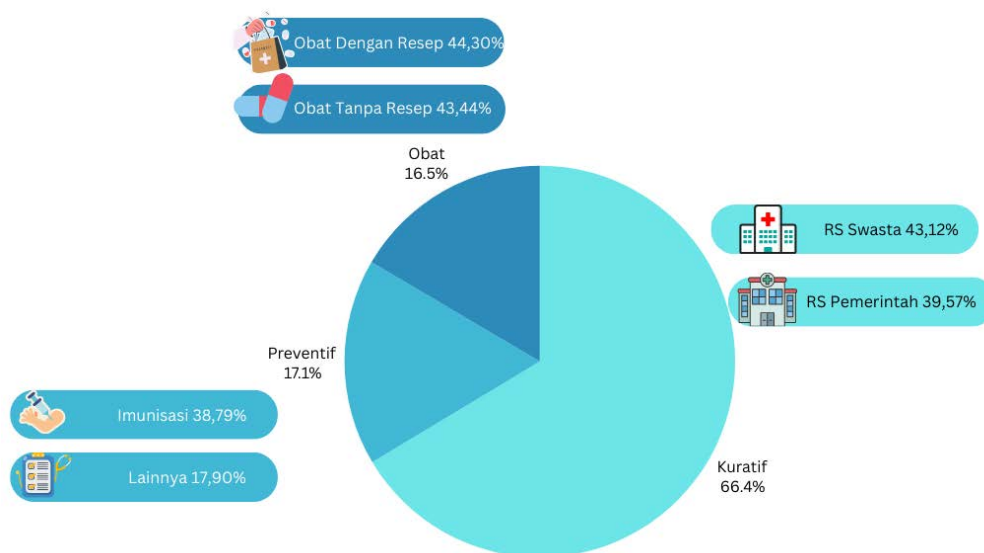
konsultasi, dsb), pemeriksaan kehamilan, tes kesehatan/deteksi dini/*medical check-up*, imunisasi, dan biaya pemeliharaan kesehatan lainnya (urut, *fitness*, bekam, *detox*, yoga, futsal, senam kebugaran, vitamin, jamu untuk menjaga kesehatan, dsb).

Pada tahun 2023, rata-rata biaya pelayanan pencegahan/preventif yang dikeluarkan oleh penduduk selama sebulan sebesar Rp 3.112 (sekitar 17,06 persen dari total pengeluaran kesehatan sebulan). Besarnya proporsi pengeluaran untuk biaya pelayanan pencegahan/preventif paling banyak digunakan untuk biaya imunisasi dan biaya pemeliharaan kesehatan lainnya. Sejalan dengan paradigma bahwa "mencegah lebih baik daripada mengobati", Pemerintah RI melalui Kementerian Kesehatan dalam beberapa tahun terakhir semakin gencar melakukan promosi upaya kesehatan pencegahan/preventif dibandingkan dengan pengobatan/kuratif. Hal tersebut tercermin diantaranya melalui JKN yang sebelumnya hanya mencakup layanan pengobatan/kuratif, saat ini juga telah mencakup 14 jenis *skrining* kesehatan mulai dari yang sederhana seperti pengecekan kadar kolesterol dalam darah dan gula darah hingga *genome sequencing*. Jika dilihat menurut jenis pengeluaran untuk pelayanan pencegahan/preventif, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pengeluaran untuk imunisasi, keluarga berencana, dan pemeliharaan kesehatan lainnya berturut-turut mendominasi proporsi pengeluaran pelayanan pencegahan.

5.3.3 Biaya Obat

Jenis pengeluaran kesehatan yang terakhir adalah biaya obat. Pada tahun 2023, rata-rata pengeluaran penduduk untuk biaya obat dalam sebulan adalah Rp 3.016 dengan proporsi terbesar dilakukan untuk biaya obat modern yang dibeli tanpa resep dari tenaga kesehatan untuk masyarakat perkotaan, sedangkan untuk masyarakat perdesaan paling banyak mengeluarkan biaya untuk obat yang diresepkan oleh tenaga kesehatan.

Jika dirinci menurut jenis obat yang dibeli, sebagian besar pengeluaran untuk biaya obat digunakan untuk obat modern yang dibeli tanpa resep dari tenaga kesehatan dan obat yang dibeli dengan resep dari tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat). Gabungan keduanya mencakup hampir 90 persen dari total pengeluaran penduduk untuk biaya membeli obat dalam sebulan.



Gambar 5.4 Proporsi Pengeluaran per Kapita Penduduk Sebulan untuk Kesehatan (dalam persen) menurut Dua Jenis Pengeluaran Terbesar per Kelompok Pengeluaran Kesehatan

5.4 Pengeluaran Kesehatan OOP

Bagian ini mendalami pengeluaran OOP yang dilakukan oleh penduduk Indonesia. Sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal bab ini, sebagian besar pengeluaran kesehatan yang dilakukan penduduk Indonesia dibayar dari kantong sendiri (OOP). Pada tahun 2023, proporsi pengeluaran kesehatan penduduk yang dibayar secara OOP adalah sekitar 55,12 persen atau jauh lebih besar daripada batas yang direkomendasikan oleh WHO. Studi terkait batasan (*threshold*) untuk OOP yang dilakukan oleh Rashidian, dkk. (2018) di Iran dan Brazil menyimpulkan bahwa proporsi OOP terhadap total pengeluaran kesehatan katastrofik, studi tersebut juga merekomendasikan batasan 35 persen.

Jika dilihat proporsinya terhadap total pengeluaran kesehatan, penduduk di perdesaan memiliki porsi OOP kesehatan yang lebih besar daripada penduduk di perkotaan, yaitu 57,68 persen dibandingkan dengan 52,84 persen. Demikian pula, jika dibandingkan dengan total pengeluaran sebulan, proporsi OOP kesehatan untuk penduduk perkotaan dan perdesaan sekitar 0,33 persen dari total pengeluaran sebulan di perkotaan, dan 0,46 persen di wilayah perdesaan.

5.4.1 OOP untuk Biaya Pelayanan Pengobatan/Kuratif

Jika dibandingkan menurut jenis pengeluaran kesehatan, OOP terbesar dilakukan untuk biaya pelayanan pengobatan/kuratif. Pada tahun 2023, dari total pengeluaran untuk

kesehatan yang dilakukan penduduk sebesar Rp 10.051, hampir sekitar 60 persen diantaranya digunakan untuk pengobatan/kuratif.

5.4.2 OOP untuk Biaya Obat

Jika dirinci menurut jenis obat yang dibeli, sebagian besar pengeluaran untuk biaya obat dan dibayar secara OOP digunakan untuk obat modern yang dibeli tanpa resep dari tenaga kesehatan dan obat yang dibeli dengan resep dari tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat). Gabungan keduanya mencakup hampir 90 persen dari total pengeluaran penduduk untuk biaya dalam sebulan yang dilakukan secara OOP.

5.4.3 OOP untuk Biaya Pelayanan Pencegahan/Preventif

Porsi pengeluaran yang dilakukan penduduk dan pembayarannya dilakukan secara OOP untuk biaya pelayanan pencegahan/preventif menempati urutan terakhir di antara tiga jenis pengeluaran kesehatan. Pada tahun 2023, biaya OOP yang dilakukan untuk pelayanan pencegahan/preventif hampir mendekati 20 persen dari total pengeluaran OOP untuk kesehatan yang dilakukan penduduk dalam sebulan. Jika dirinci menurut jenis pengeluaran untuk pelayanan pencegahan/preventif, secara umum pengeluaran OOP paling banyak dilakukan untuk biaya keluarga berencana, imunisasi, dan pemeliharaan kesehatan lainnya (urut, *fitness*, bekam, *detox*, yoga, futsal, senam kebugaran, vitamin, jamu untuk menjaga kesehatan, dsb).

Tabel 5.1 Rata-rata Pengeluaran Rupiah per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah), 2023

Kabupaten/Kota	2023		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan	706.244	628.047	670.957
Bukan Makanan	421.772	222.447	644.219
Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	210.714	115.913	326.626
Aneka Barang dan Jasa (Kecuali Kesehatan)	83.904	38.897	122.801
Kesehatan	9.671	8.565	18.236
OOP	5.111	4.940	10.051
Non-OOP	4.560	3.625	8.185
Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	23.734	14.922	38.656
Barang Tahan Lama	40.552	19.034	59.586
Pajak, Pungutan, dan Asuransi	33.197	17.016	50.213
Keperluan Pesta dan Upacara/Kenduri	20.000	8.101	28.101
Total Pengeluaran	1.559.459	1.081.507	1.977.631

Tabel 5.2 Rata-rata Pengeluaran Rupiah per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah), 2023

Karakteristik	2023
(1)	(2)
Biaya Pelayanan Pengobatan/Kuratif	11.132
Rumah Sakit Pemerintah	4.276
Rumah Sakit Swasta	5.134
Puskesmas/Pustu/Polindes/posyandu	363
Praktek Dokter/Poliklinik	1.086
Praktek Petugas Kesehatan (Bidan/ perawat/Mantri Kesehatan)	220
Praktek Pengobatan Tradisional	51
Dukun Penolong Persalinan	3
Biaya Pelayanan Pencegahan/Preventif	3.498
Periksa Kehamilan	502
Imunisasi	1.263
Tes Kesehatan/Deteksi Dini/Medical Check-Up	252
Keluarga Berencana (Alat/Cara Kontrasepsi, Konsultasi, dsb)	778
Biaya Pemeliharaan Kesehatan Lainnya (Urut, <i>Fitness</i> , Bekam, <i>Detox</i> , yoga, Futsal, Senam Kebugaran, Vitamin, Jamu untuk Menjaga Kesehatan,dsb)	703
Biaya Obat	2.993
Obat yang Dibeli dengan Resep dari Tenaga Kesehatan (Dokter, Bidan, Perawat)	1.175
Obat Modern yang Dibeli Tanpa Resep dari Tenaga Kesehatan	1.464
Obat Tradisional/Jamu untuk Pengobatan	201
Biaya Pembelian Kacamata, Kaki/Tangan Palsu (Protese), dan Kursi Roda	152
Total Pengeluaran Kesehatan	17.623

Tabel 5.3 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Penduduk di Perdesaan Sebulan Menurut Rincian Pengeluaran Kesehatan (rupiah), 2023

Karakteristik	2023
(1)	(2)
Biaya Pelayanan Pengobatan/Kuratif	13.296
Rumah Sakit Pemerintah	5.419
Rumah Sakit Swasta	5.329
Puskesmas/Pustu/Polindes/posyandu	628
Praktek Dokter/Poliklinik	1.354
Praktek Petugas Kesehatan (Bidan/ perawat/Mantri Kesehatan)	398
Praktek Pengobatan Tradisional	92
Dukun Penolong Persalinan	77
Biaya Pelayanan Pencegahan/Preventif	2.642
Periksa Kehamilan	308
Imunisasi	1.140
Tes Kesehatan/Deteksi Dini/Medical Check-Up	107
Keluarga Berencana (Alat/Cara Kontrasepsi. Konsultasi. dsb)	708
Biaya Pemeliharaan Kesehatan Lainnya (Urut. <i>Fitness</i> . Bekam. <i>Detox</i> . yoga. Futsal. Senam Kebugaran. Vitamin. Jamu untuk Menjaga Kesehatan.dsb)	379
Biaya Obat	3.043
Obat yang Dibeli dengan Resep dari Tenaga Kesehatan (Dokter. Bidan. Perawat)	1.531
Obat Modern yang Dibeli Tanpa Resep dari Tenaga Kesehatan	1.122
Obat Tradisional/Jamu untuk Pengobatan	-
Biaya Pembelian Kacamata. Kaki/Tangan Palsu (Protese). dan Kursi Roda	197
Total Pengeluaran Kesehatan	18,981

Tabel 5.4 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Penduduk Sebulan Menurut Rincian Pengeluaran Kesehatan (rupiah), 2023

Karakteristik	2023
(1)	(2)
Biaya Pelayanan Pengobatan/Kuratif	12.109
Rumah Sakit Pemerintah	4.792
Rumah Sakit Swasta	5.222
Puskesmas/Pustu/Polindes/posyandu	482
Praktek Dokter/Poliklinik	1.207
Praktek Petugas Kesehatan (Bidan/ perawat/Mantri Kesehatan)	300
Praktek Pengobatan Tradisional	69
Dukun Penolong Persalinan	36
Biaya Pelayanan Pencegahan/Preventif	3.112
Periksa Kehamilan	414
Imunisasi	1.207
Tes Kesehatan/Deteksi Dini/Medical Check-Up	187
Keluarga Berencana (Alat/Cara Kontrasepsi, Konsultasi, dsb)	747
Biaya Pemeliharaan Kesehatan Lainnya (Urut, <i>Fitness</i> , Bekam, <i>Detox</i> , yoga, Futsal, Senam Kebugaran, Vitamin, Jamu untuk Menjaga Kesehatan,dsb)	557
Biaya Obat	3.016
Obat yang Dibeli dengan Resep dari Tenaga Kesehatan (Dokter, Bidan, Perawat)	1.336
Obat Modern yang Dibeli Tanpa Resep dari Tenaga Kesehatan	1.310
Obat Tradisional/Jamu untuk Pengobatan	199
Biaya Pembelian Kacamata, Kaki/Tangan Palsu (Protese), dan Kursi Roda	170
Total Pengeluaran Kesehatan	18.236

Tabel 5.5 Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Penduduk Sebulan Menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Pengeluaran Kesehatan (rupiah), 2023

No.	Kabupaten/Kota	Biaya Kuratif	Biaya Obat	Biaya Preventif	Total Pengeluaran Kesehatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bolaang Mongondow	11.352	3.623	2.405	17.380
2	Minahasa	15.609	4.200	3.301	23.110
3	Kepulauan Sangihe	3.110	1.927	3.902	8.939
4	Kepulauan Talaud	5.997	2.624	437	9.059
5	Minahasa Selatan	16.377	2.636	2.382	21.394
6	Minahasa Utara	20.212	2.543	2.794	25.549
7	Bolaang Mongondow Utara	12.771	3.157	2.186	18.113
8	Siau Tagulandang Biaro	3.963	2.034	1.477	7.475
9	Minahasa Tenggara	20.467	2.384	5.443	28.294
10	Bolaang Mongondow Selatan	3.679	1.177	2.446	7.302
11	Bolaang Mongondow Timur	14.041	2.828	3.661	20.531
12	Manado	8.793	2.793	4.284	15.870
13	Bitung	12.224	2.496	3.881	18.601
14	Tomohon	11.126	3.762	1.695	16.583
15	Kotamobagu	10.149	4.386	2.366	16.901
Sulawesi Utara		12.109	3.016	3.112	18.236

Tabel 5.6 Rata-rata Pengeluaran Rupiah per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah), 2023

Karakteristik	2023
(1)	(2)
Biaya Pelayanan Pengobatan/Kuratif	5.789
Rumah Sakit Pemerintah	1.814
Rumah Sakit Swasta	2.528
Puskesmas/Pustu/Polindes/posyandu	242
Praktek Dokter/Poliklinik	842
Praktek Petugas Kesehatan (Bidan/ perawat/Mantri Kesehatan)	263
Praktek Pengobatan Tradisional	64
Dukun Penolong Persalinan	36
Biaya Pelayanan Pencegahan/Preventif	1.981
Periksa Kehamilan	292
Imunisasi	528
Tes Kesehatan/Deteksi Dini/ <i>Medical Check-Up</i>	108
Keluarga Berencana (Alat/Cara Kontrasepsi, Konsultasi, dsb)	580
Biaya Pemeliharaan Kesehatan Lainnya (Urut, <i>Fitness</i> , Bekam, <i>Detox</i> , yoga, Futsal, Senam Kebugaran, Vitamin, Jamu untuk Menjaga Kesehatan,dsb)	474
Biaya Obat	2.281
Obat yang Dibeli dengan Resep dari Tenaga Kesehatan (Dokter, Bidan, Perawat)	839
Obat Modern yang Dibeli Tanpa Resep dari Tenaga Kesehatan	1.133
Obat Tradisional/Jamu untuk Pengobatan	175
Biaya Pembelian Kacamata, Kaki/Tangan Palsu (Protese), dan Kursi Roda	134
Total Pengeluaran Kesehatan	10.051

DAFTAR PUSTAKA

- Adioetomo, S. M. 2018. *Bonus Demografi dan Jendela Peluang Meletakkan Pembangunan Manusia. Memetik Bonus Demografi: Membangun Manusia Sejak Dini*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada.
- Andarini, S., Arif, A. Z., Al Rasyid, H., Wahono, C. S., Kalim, H., & Handono, K. 2019. *Factors associated with health care seeking behavior for musculoskeletal pain in Indonesia: A crosssectional study*. *International Journal of Rheumatic Diseases*. <https://doi.org/10.1111/1756-185X.13536>
- Anwar, Asim dkk. *Government Health Expenditures and Health Outcome Nexus: A Study on OECD Countries*. *Frontiers in Public Health* 10.3389/fpubh.2023.1123759
- Azad, A. D., Charles, A. G., Ding, Q., Trickey, A. W., & Wren, S. M. 2020. *The gender gap and healthcare: associations between gender roles and factors affecting healthcare access in Central Malawi, June–August 2017*. *Archives of Public Health*, 78(1), 1–11. <https://doi.org/10.1186/s13690-020-00497-w>
- Badan Pusat Statistik. 2021. *Profil Statistik Kesehatan 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2023. *Profil Statistik Kesehatan 2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Cui, Xiaodong dan Ching-Ter Chang. 2021. *How Income Influences Health: Decomposition Based on Absolute Income and Relative Income Effects; International Journal of Environmental Research and Public Health*.
- Doiron, D., Fiebig, D. G., Johar, M., & Suziedelyte, A. 2015. *Does self-assessed health measure health? Applied Economics*, 47(2), 180–194. <https://doi.org/10.1080/00036846.2014.967382>
- Kasl, S. V, & Cobb, S. 1966. *Health behaviour, illness behaviour and sick role behaviour. Achives of Environmental Health: An International Journal*, 12(2), 246–266. <https://doi.org/10.1080/00039896.1966.10664365>
- Lauranti, Maria dkk. 2018. *Mewujudkan Jaminan Kesehatan Nasional yang Non-Diskriminatif*. Jakarta: Perkumpulan Prakarsa
- Mahendradhata, Yodi dkk. 2017. *The Republic of Indonesia Health System Review. Journal Health System in Transition Vol.7 No. 1*
- Markus, J. 2015. *Does Neighborhood Deprivation Cause Poor Health? Within-Individual Analysis Of Movers In A Prospective Cohort Study. J. Epidemiol. Community Health* 2015, 9, 899–904.
- Mayer-foulkes, D. 2004. *The Intergenerational Impact of Health on Economic Growth. Mexico City*.
- Raghupati, Viju dan Wullianallur Raghupati. 2020. *The Influence of Education on Health: An Empirical Assessment of OECD Countries for the Period 1995-2015. Archives of Public Health* 78:20
- Rashidian, Arash dkk. 2018. *Comparison of the Thresholds of Households' Exposure to Catastrophic Health Expenditure in Iran and Brazil, and Selection of the Most Appropriate Threshold. Iranian Journal of Public Health* 2018 Dec; 47(12):1945-1952
- Sardjoko, Subandi. 2019. *Ringkasan Eksekutif Kajian Sektor Kesehatan Pembiayaan Kesehatan dan JKN*. Jakarta: Kementerian PPN/ Bappenas

ST 2023

SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Jl. 17 Agustus, Manado, 95119

Telp. (0431) 874047, E-mail: bps7100@bps.go.id

Website: <https://sulut.bps.go.id>